



Premiers secours

Formation de base du secouriste d'entreprise

Version 12/2025

mensurà
Learn & Connect



1



Secouriste d'entreprise

Employé qui dispense les premiers secours sur le lieu de travail.

Formation et recyclage

- Formation de base : minimum **15** heures de cours.
- Recyclage annuel : minimum **4** heures de cours.

mensurà
Learn & Connect



2

Introduction - Approche générale d'une situation d'urgence

1. Inconscient – ne respire pas

- Basic Life Support (BLS) & AED
- Pediatric Basic Life Support (PBLIS) & DEA
- Obstruction des voies respiratoires chez l'adulte
- Obstruction des voies respiratoires chez les bébés, les enfants et les adolescents

2. Inconscient – respire

- Approche par étapes
- Position latérale stable pour adultes
- Position latérale pour les bébés et les enfants
- Pathologies du système resp.
 - Hyperventilation – Essoufflement – Asthme
- Pathologies relatif à la circulation sanguine
 - Douleur thoracique: Crise cardiaque – Angor
 - Choc
- Pathologies en ce qui concerne la conscience
 - Diabète – Epilepsie – Syncope / Présyncope – Accident vasculaire cérébral – Lésion cérébrale
- Tableaux cliniques généraux
 - Coup de chaleur et insolation – hypothermie – déshydratation

mensurá
Learn & Connect

3

Introduction - Approche générale d'une situation d'urgence

3. Conscient – avec la respiration (douleur)

Approche par étapes

A. Hémorragies

- Hémorragie : théorie
- Amputation
- Techniques de bandage

B. Lésions

- Lésions osseuses, musculaires et articulaires
- Brûlures

- Accidents électriques
- Maladies oculaires et dentaires
- Saignements de nez
- Techniques de bandage

C. Contamination

- Anatomie de la peau + soins des plaies
- Types de blessures
- Soins spécifiques des plaies
- Techniques de bandage

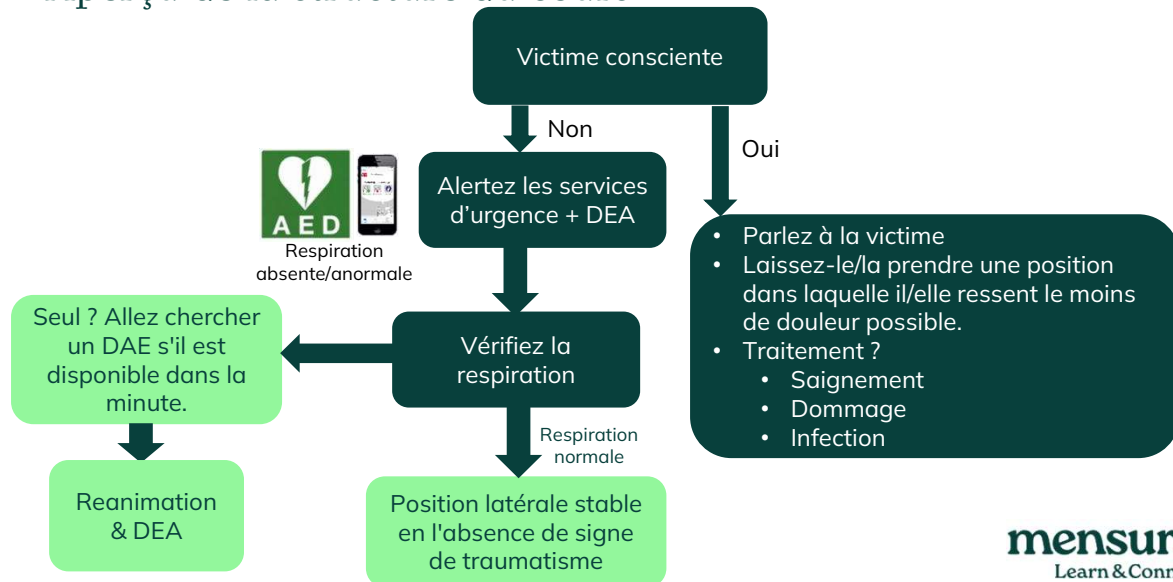
4. Législation

- Cadre légal
- Trousse de premiers secours – Local – Organisation – Registre

mensurá
Learn & Connect

4

Aperçu de la structure du cours



mensurà
Learn & Connect

5

Introduction

Approche générale des situations d'urgence

mensurà
Learn & Connect

6

Approche générale d'une situation d'urgence

- 1 Assurer la sécurité générale
- 2 Vérifier l'état de conscience
- 3 Appeler les secours spécialisés
- 4 Vérifier la respiration
- 5 Prodiger les premiers soins

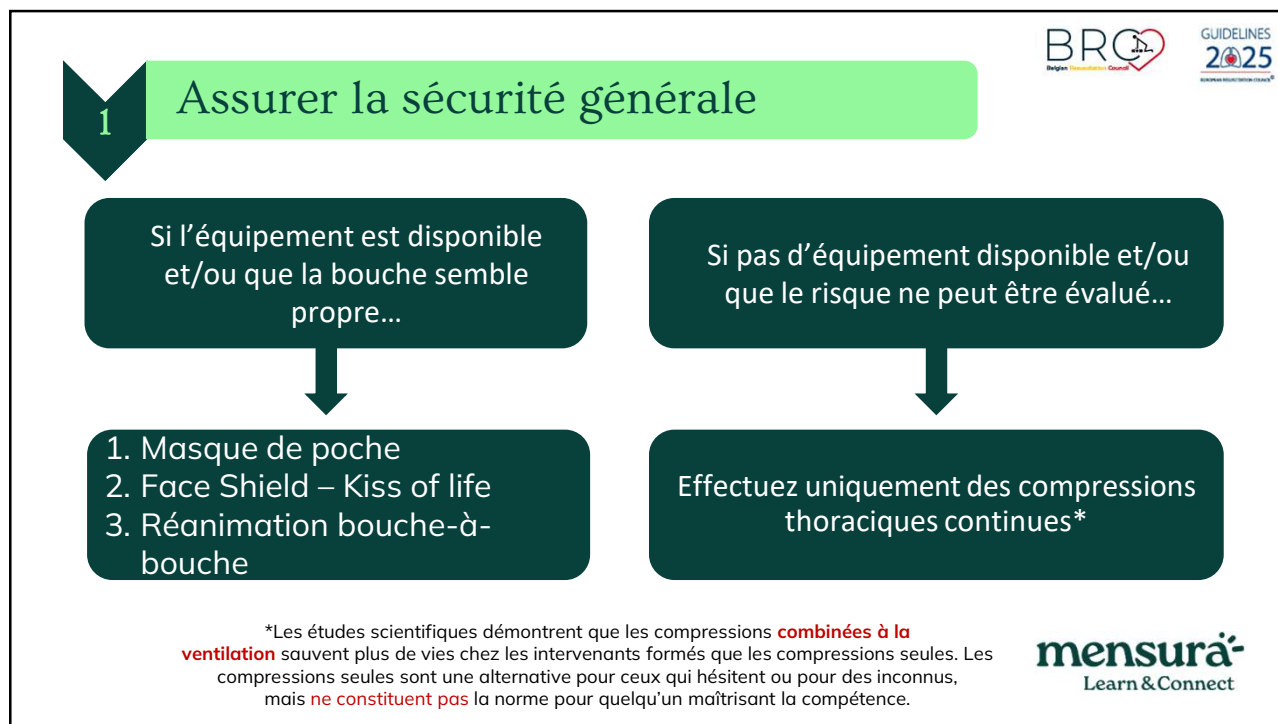
7

1 Assurer la sécurité générale

Observez : quels sont les risques ?

- Que s'est-il passé? (Dangers ? Ampleur ?)
- Sécurité pour: Vous-même → Passants → Victime
 - Ne mettez jamais votre sécurité en danger!
 - Déplacez la victime **si nécessaire** (p.ex. risque d'incendie)
 - Informez les personnes présentes des dangers
- Utilisez des personnes présentes
 - Donnez des instructions p.ex. triangle de signalisation, attendre les secours, ...
- Situation dangereuse → Appelez les secours (police, pompiers)

8



9

1 Assurer la sécurité générale



Exemple: Accident de la circulation

mensurá
Learn & Connect

10

Exemple: Accident de la circulation

1

Assurer la sécurité

1. Passez devant l'accident
2. Allumez les clignotants et verrouillez la voiture
3. Coupez le moteur
4. En cas de danger : évacuation rapide via Rautek
5. Essayez d'éteindre le
6. Triangle de danger

mensurà
Learn & Connect

11

Triangle de danger = Avertissement de trafic approchant

1. **Autoroute** → Triangle de signalisation à 100 mètres du véhicule
2. **Autres routes** → Triangle de signalisation à 30 mètres du véhicule
3. **Zone urbaine** → Triangle de signalisation à 30 mètres du véhicule (si ce n'est pas possible, plus près)

Dans tous ces cas, le triangle doit être visible à une distance d'au moins 50 mètres.



mensurà
Learn & Connect

12

1

Assurer la sécurité générale



Exemple: Écrasement de membre(s)



mensurà
Learn & Connect

13

1

Assurer la sécurité générale

Techniques d'évacuation:



Techniques d'évacuation:
Transport d'une victime

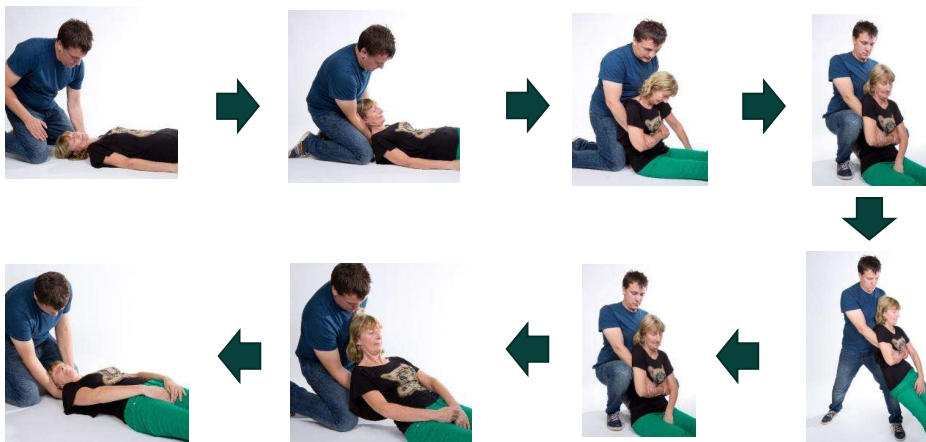
mensurà
Learn & Connect

14

1

Assurer la sécurité générale

Techniques d'évacuation:



mensurà-
Learn & Connect

15

1

Assurer la sécurité générale

Techniques d'évacuation:



Techniques d'évacuation
**Situation ne mettant pas
la vie en danger**

mensurà-
Learn & Connect

16

2

Vérifier l'état de conscience

Stimulez doucement les deux épaules
Appelez fortement la victime

Conscient(e) ?

- La victime répond, ouvre les yeux...
 - Continuez à parler à la victime !

Inconscient(e) ?

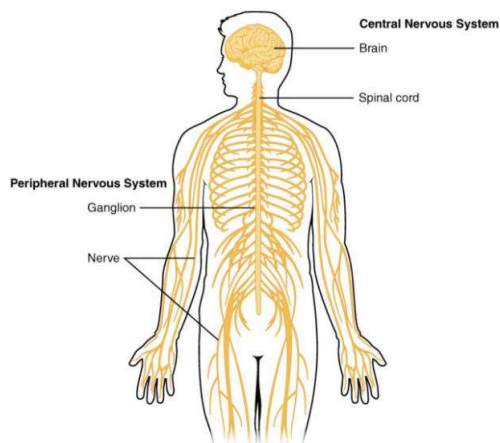
- La victime ne réagit pas?
- Somnolente ou confuse ?
- **Appelez le 112** (haut-parleur si vous êtes seul) / Demandez à un passant d'appeler



mensurà
Learn & Connect

17

Notre conscience: le système nerveux



La conscience est contrôlée par le cerveau.

Grâce au réseau de nerfs, le cerveau peut contrôler toutes les parties du corps.

mensurà
Learn & Connect

18

3

Appeler les secours spécialisés

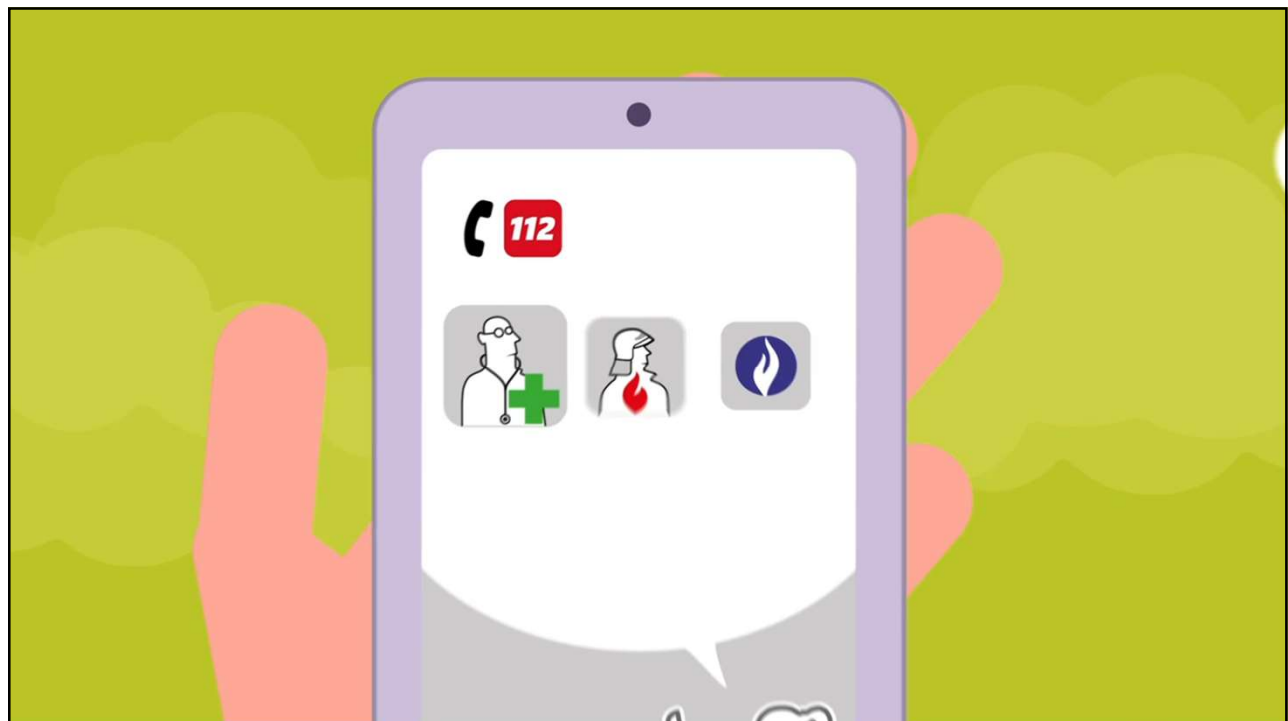
Questions importantes posées par l'opérateur

- **Où, lieu ?**
 - Adresse exacte, nom de l'entreprise, personne à envoyer pour attendre les services d'urgence,...
 - Via application: localisation automatiquement
- **Que s'est-il passé ?**
 - Quel accident, quelle affection,...
- **Qui est la victime ?**
 - Enfant ou adulte, état des fonctions vitales, grossesse,...
 - **Combien** de victimes?
- Y a-t-il des **dangers** supplémentaires ?

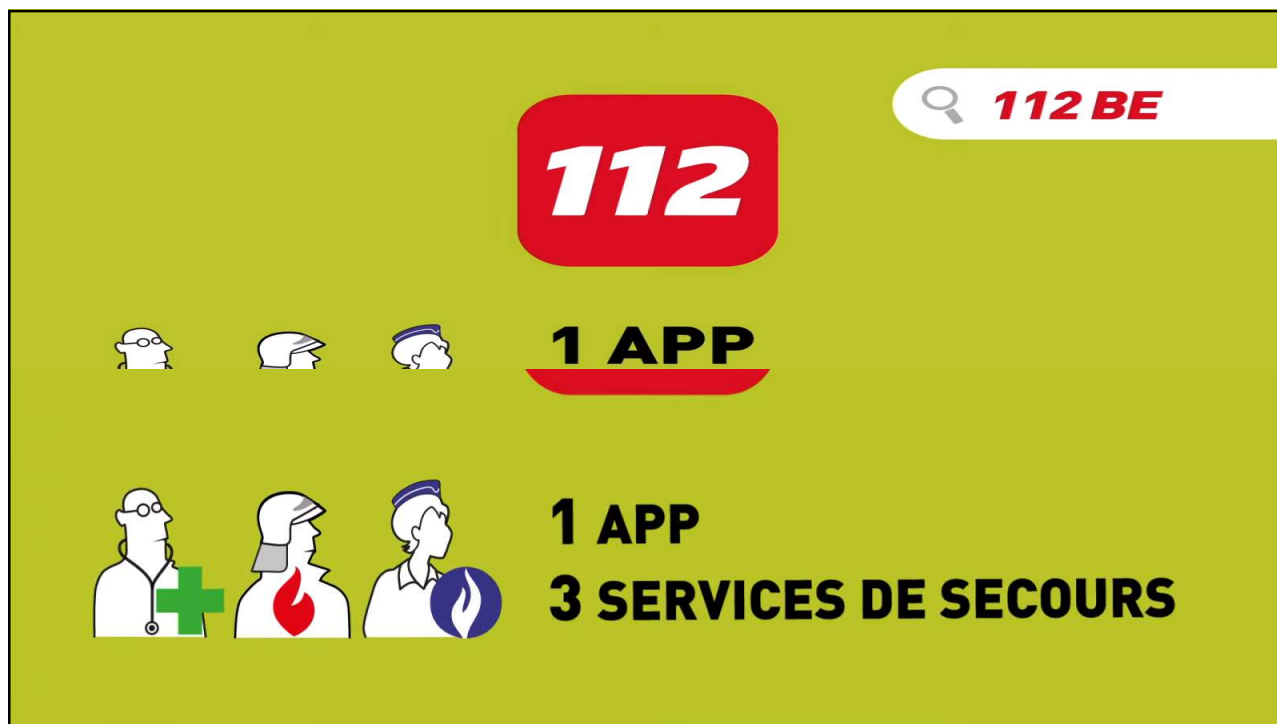


mensurá
Learn & Connect

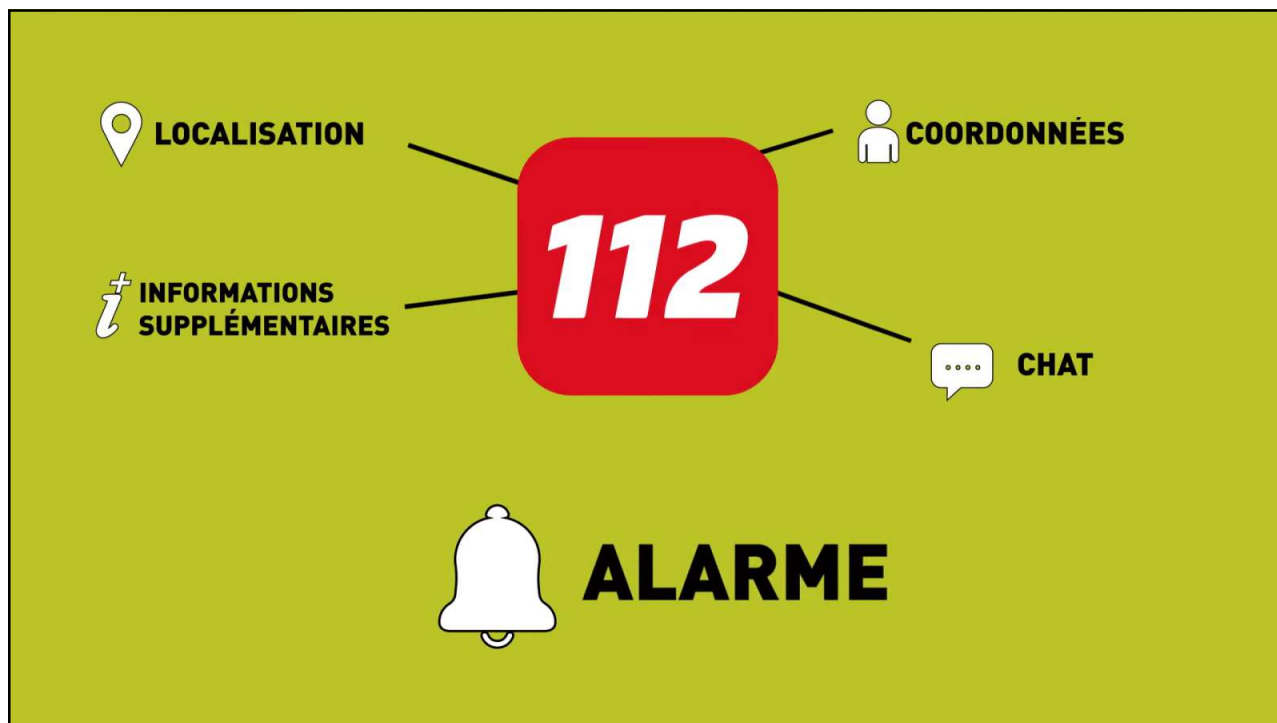
19



20



21



22

Appeler les secours spécialisés

Avantages supplémentaires de l'application 112

- L'employé du centre d'appel 112 peut envoyer une vidéo explicative sur le smartphone de l'appelant.
- Activer la caméra de l'appelant afin que l'opérateur du centre d'appel 112 puisse apporter une aide non seulement auditive, mais aussi visuelle.
- Pas encore de cadre juridique permettant d'appliquer cette mesure dès à présent

Appeler les secours spécialisés

Qui donne l'alerte?

- **Les témoins?** → Demandez à l'un d'entre eux d'appeler, puis demandez-lui de confirmer. Demandez aux témoins d'attendre les secours (signalez-le au centre d'appel d'urgence)
- **Seul?** → Utilisez la **fonction haut-parleur** de votre GSM

Si vous êtes seul et n'avez pas de téléphone ?

Quittez la victime pour appeler le 112
après avoir vérifié son état de conscience et sa respiration.

Localisation via l'application 112

Localisation via un appel normal au 112



Localisation via l'application 112.be



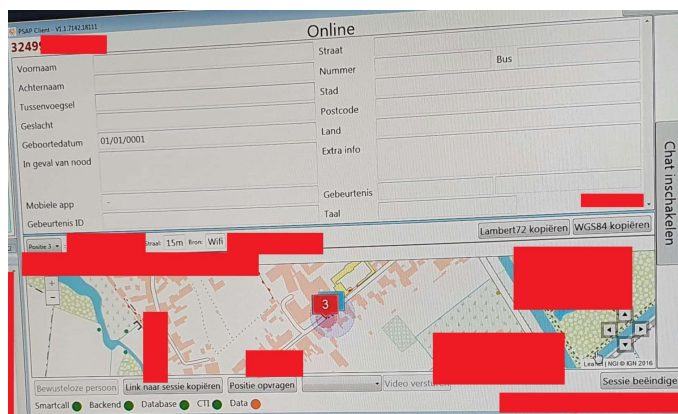
mensurà
Learn & Connect

25

3

Appeler les secours spécialisés

Coup d'œil dans les coulisses



mensurà
Learn & Connect

26

3

Appeler les secours spécialisés



112



101



1733



1722



070/245 245



Police Politie

pour contacter le
médecin de garde

1722



070 245 245

mensurà
Learn & Connect

27

3

Consulter un spécialiste: médecins généraux

- Appelez le **1733**

Choisissez votre **langue**:

- Appuyez sur 1 pour le néerlandais,
- 2 pour le français,
- 3 pour l'allemand et
- 4 pour l'anglais.

- Entrez votre **code postal** et terminez par un dièse (#).

- Vous serez mis en relation avec **un employé du poste médical de garde ou le médecin de garde local**. Un rendez-vous vous sera alors donné ou un médecin de garde vous sera envoyé.

pour contacter le
médecin de garde

mensurà
Learn & Connect

28

Consulter un spécialiste: médecins généraux

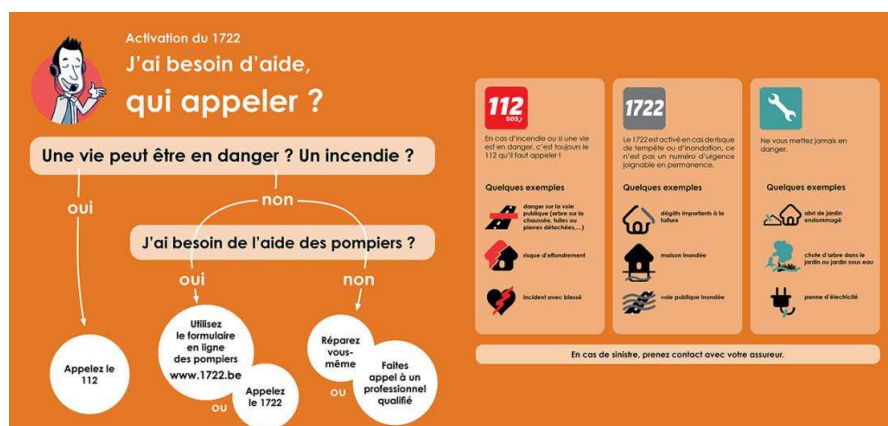
• Un **opérateur du centre d'appel d'urgence (112)** peut également vous **rediriger vers le 1733**. Il vous posera quelques questions et vous donnera des instructions supplémentaires en fonction de votre état de santé :



1. Il peut vous recommander de vous rendre au poste de garde ou de consulter le médecin de garde.
2. Dans certains cas, il peut envoyer un médecin de garde à votre domicile.
3. Il peut vous suggérer d'attendre que votre propre médecin vous consulte
4. Si la situation s'avère grave, il envoie une ambulance

mensurá-
Learn & Connect

Consulter un spécialiste: numéros d'urgence



mensurá-
Learn & Connect

Consulter un spécialiste: numéros d'urgence

Gardez l'emballage du produit concerné à portée de main.

1. Âge et poids de la victime : s'agit-il d'un enfant ou d'un adulte ?
2. Quel est le nom du produit qui a causé l'empoisonnement (gardez l'emballage, la notice... à portée de main) ?
3. De quelle quantité de produit s'agit-il (nombre de comprimés, cuillères à soupe ou à café...) ?
4. Que s'est-il passé exactement (accident, tentative de suicide...)?
5. Constatez-vous des symptômes d'intoxication, et si oui, lesquels ?



Visitez le site Web: <https://www.centreantipoisons.be/>

mensurà
Learn & Connect

31

Consulter un spécialiste: numéros d'urgence

Que faire en cas d'empoisonnement ?

- Appelez le centre antipoison : s'il n'est pas joignable : 02 264 96 30 ou votre médecin traitant.
- En cas de situation mettant **la vie en danger**, composez toujours le **numéro d'urgence européen 112**
- En cas d'accident, **n'attendez pas** l'apparition des symptômes pour appeler le Centre antipoison
- **Ne pas administrer de lait**, le lait n'est pas un antidote
- **Ne faites pas vomir** ! En général, il n'est pas recommandé de faire vomir : demandez d'abord conseil au centre antipoison ou à un médecin
- **Rincer abondamment** à l'eau après projection d'une substance nocive dans les yeux ou sur la peau
- Si un gaz irritant ou toxique s'est échappé, évacuez les personnes présentes et aérez bien la pièce

mensurà
Learn & Connect

32

4

Vérifier la respiration

1. Agenouillez-vous à côté de la victime;
2. Placez une main sur le front de la victime;
3. Inclinez doucement la tête vers l'arrière;
4. Placez deux doigts de votre autre main sous la pointe du menton de la victime;
5. Soulevez le menton pour ouvrir les voies respiratoires.



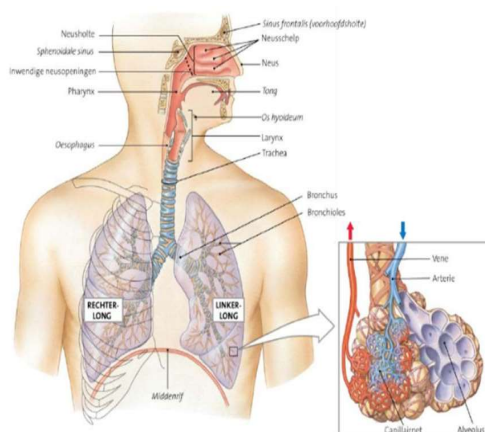
Vérifiez la respiration :
Voir, Entendre et Sentir pour rechercher si la victime respire pendant **10 secondes au maximum**.

mensurà
Learn & Connect

33

Les fonctions vitales : la respiration

Respiration normale



Adulte

- Fréquence 12 à 20 par minute
- Entendre, sentir et voir → 2 à 3 / 10 sec
 - < 2 / 10 sec : absence ou anomalie de la respiration

mensurà
Learn & Connect

34

Les fonctions vitales : la respiration

Respiration normale

Respiration agonale dans les premières minutes suivant l'arrêt circulatoire

- La victime **halète, respire à peine / par intermittence, gémit, soupire, gargouille, bruyante, renifle, respiration lourde / difficile**
- Attention avec les **sportifs**
 - Perte de conscience après un effort physique
 - Peu après le début de l'arrêt cardiaque, les sportifs peuvent présenter un rythme respiratoire presque normal / **haletant**
- La respiration agonale n'est pas une respiration normale, mais un signe d'arrêt circulatoire !
 - → Une réanimation rapide est nécessaire !
- **En cas de doute**, commencez toujours la réanimation !

mensurá-
Learn & Connect

35

Vérifiez la circulation sanguine

Rythme cardiaque normal



Adulte

- Fréquence 60 à 80 par minute
- Le rythme cardiaque (pouls) n'est PAS contrôlé!

Reconnaître un arrêt circulatoire

- Inconscient et absence/anomalie de la respiration
 - → **Commencez la réanimation!**

Reconnaître les signes d'un état de choc

- Peau pâle, froide, moite et transpirante
- Respiration rapide et superficielle
- Coloration bleue de la peau (cyanose)

mensurá-
Learn & Connect

36

JM1 Gewijzigde slide + notities 31/10/2025.
Moerman Joséphine; 2025-10-31T08:16:32.640

5

Prodiguer les premiers soins

- Restez auprès de la victime
- Soins de **confort**:
 - Protection contre le froid, la chaleur, les précipitations
 - Laissez la victime consciente adopter une position qui lui est confortable
- **Nettoyez et désinfectez vos mains** après avoir transféré un patient aux professionnels de santé
- Si nécessaire, communiquez **vos données d'identité** aux professionnels de santé dans le cadre du suivi
- Gardez la victime au **repos**, évitez tout effort physique et ne lui causez pas de douleur supplémentaire
- Veillez à une **bonne hygiène des mains**

mensurá
Learn & Connect

37

5

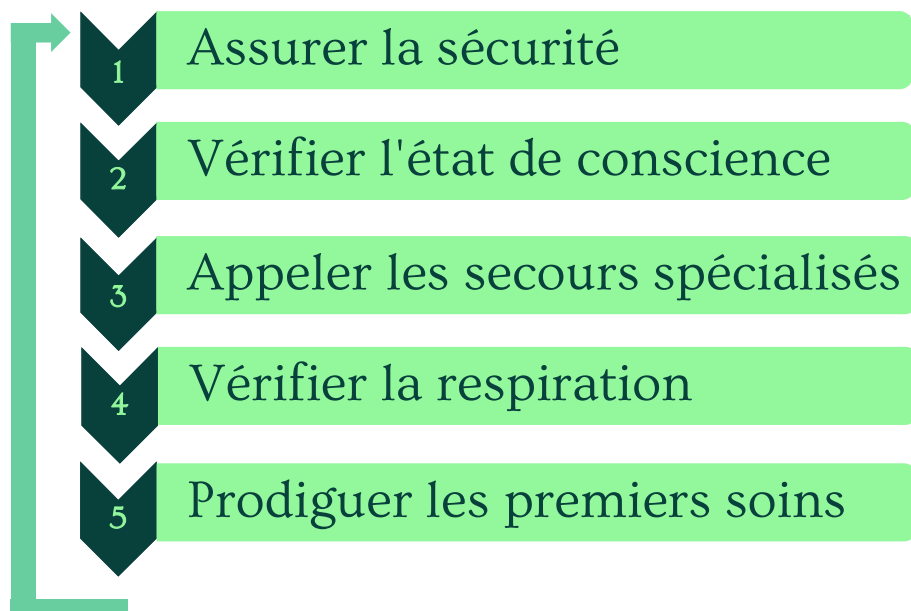
Prodiguer les premiers soins: priorités

1. Donnez toujours la **priorité** aux **techniques qui sauvent la vie**, par exemple la réanimation
2. Stopper les **saignements**
3. Refroidir les **brûlures**
4. Soignez les **plaies** importantes et **couvrez-les**
5. Appliquez les **premiers soins aux blessures** des os, des muscles et des articulations
6. Soignez les blessures moins graves

mensurá
Learn & Connect

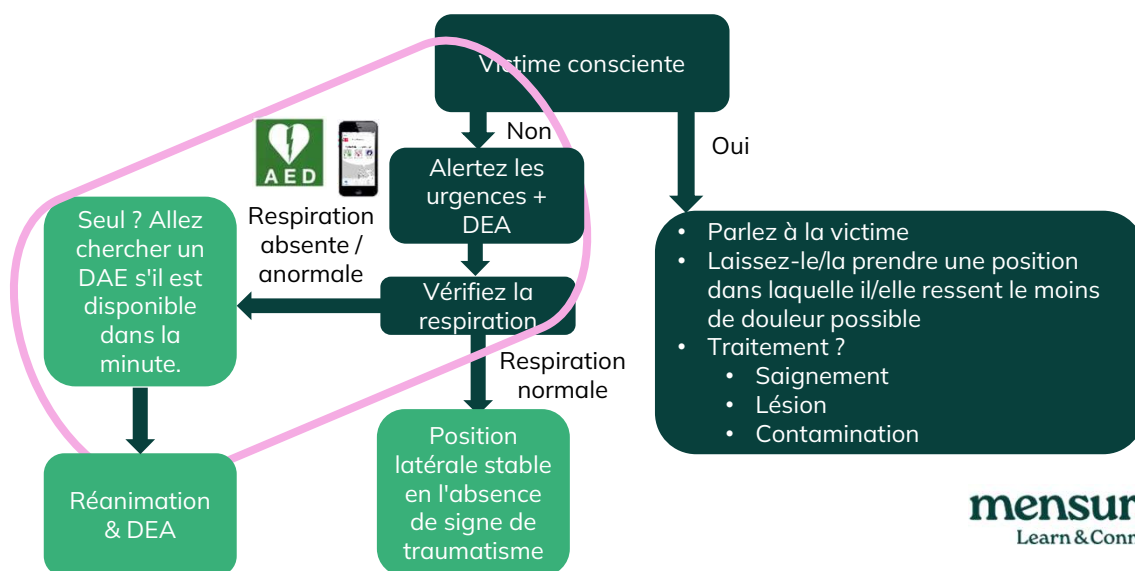
38

Réévaluez la victime



39

Approche par organigramme : inconscient – pas de respiration



40



41

L'arrêt cardiaque ou circulatoire soudain est l'une des principales causes de décès dans l'UE.

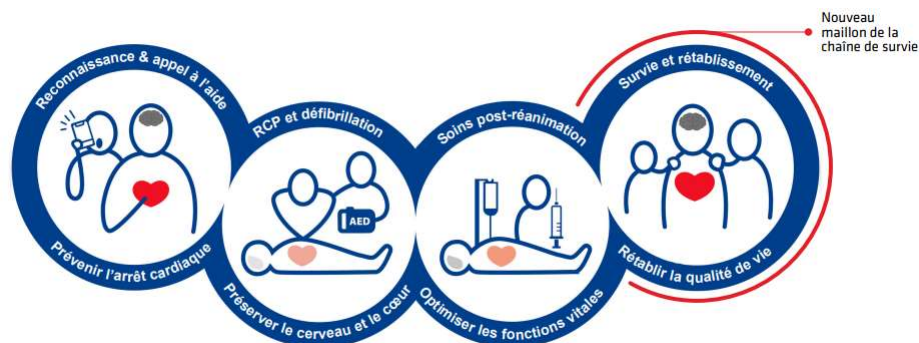
- En Europa, un arrêt cardiaque survient **toutes les 45 secondes**.
- Les chances de survie de la victime sont jusqu'à **4 fois plus élevées** lorsque la réanimation est commencé immédiatement!
- La réanimation et la défibrillation immédiate **dans les 2 minutes** qui suivent offrent une chance de survie pouvant atteindre **80%**.
- Réanimer et défibriller immédiatement dans les 4 minutes donne une chance de survie pouvant atteindre **60%**.

mensurà
Learn & Connect

42

Chaîne de survie

= Actions visant à maximiser les chances de survie après un arrêt cardiaque



mensurà
Learn & Connect

43



Vérifiez l'état de conscience : la victime ne réagit pas

Alertez les services d'urgence – Appelez à l'aide

Vérifiez la respiration: respiration absente/anormale

CPR 30 : 2

Dès que le DAE est disponible : allumez-le et suivez les instructions

Par un passant + DEA / Téléphone en mode haut-parleur

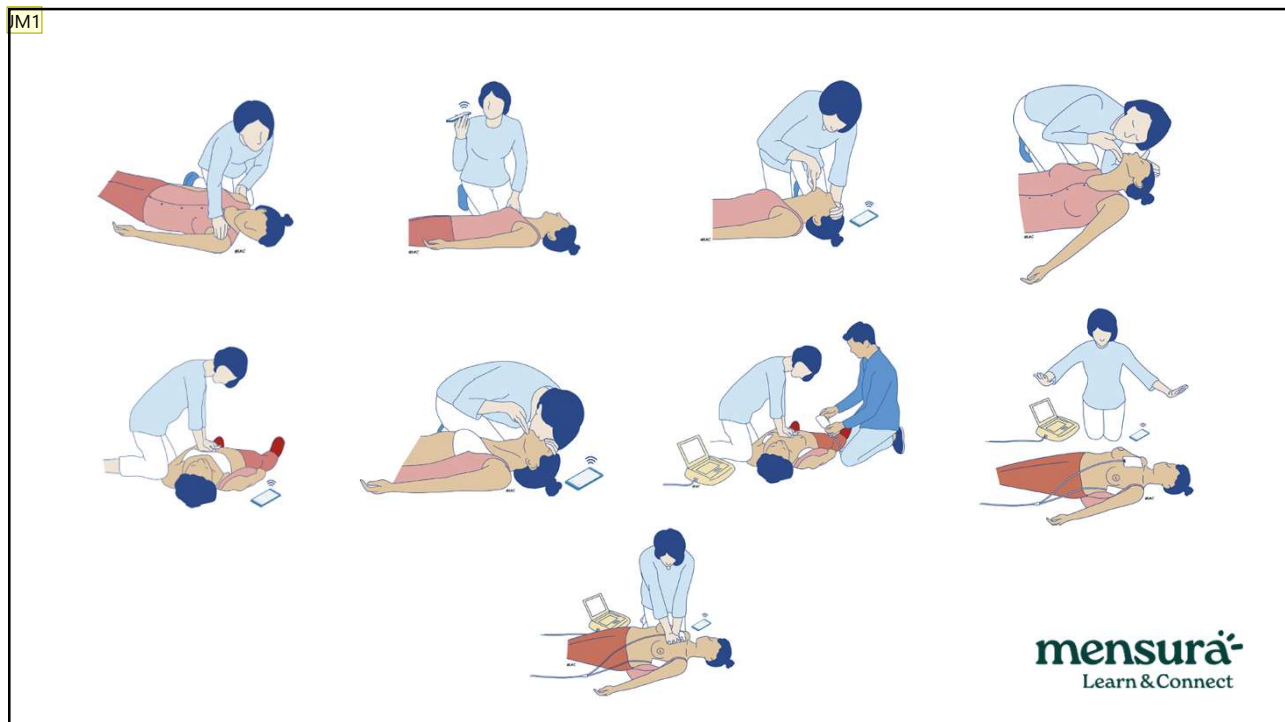
Seul ? Allez chercher un DEA s'il est disponible dans la minute.



mensurà
Learn & Connect

44

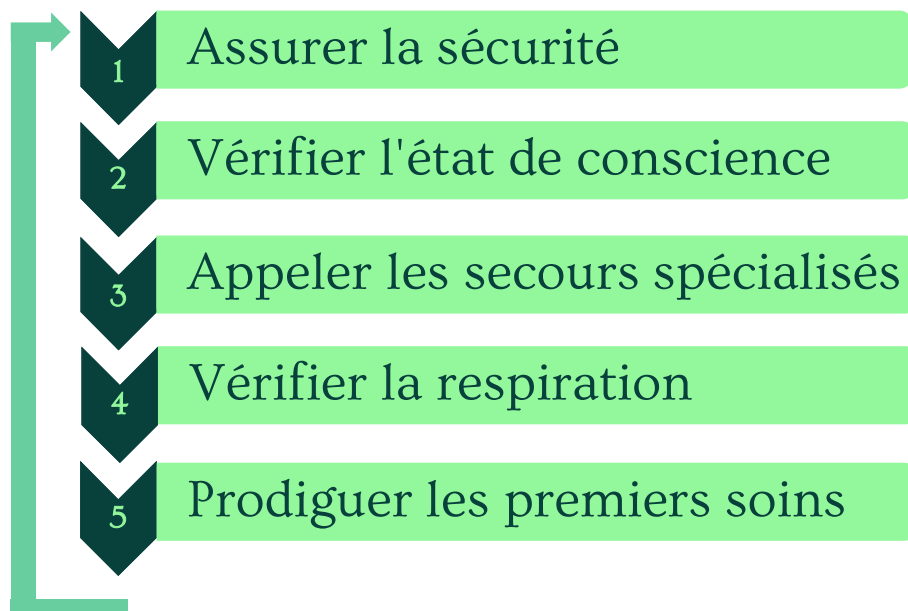
M1



45

Rappel : approche de la situation d'urgence

BRC GUIDELINES 2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL



mensurà
Learn & Connect

46

JM1 Nieuw toegevoegde slide ERC 2025.
Moerman Joséphine; 2025-11-07T07:32:14.989

2

Vérifier l'état de conscience

Stimulez doucement les deux épaules
Appelez fortement la victime

Stimuler les épaules

→ Stimulation sensorielle

Cris provenant des deux côtés de la tête

→ Stimulation auditive



mensurá
Learn & Connect

47

2

Vérifier l'état de conscience

Si la victime ne réagit pas:

La victime est **inconsciente** !

→ Appelez le **112** (haut-parleur si vous êtes seul)



mensurá
Learn & Connect

48

3

Appeler les secours spécialisés

Faites appeler le 112 par un témoin ou faites le vous-même

Utilisez de préférence l'application **112.t**



- Où ?
- Quoi ?
- Qui ?



Demandez d'aller chercher un **DEA**



mensurà
Learn & Connect

49

4

Vérifier la respiration

Vérifiez la respiration → Vérifiez si la victime respire normalement ou non

- Tournez la victime sur le dos si nécessaire
- Ouvrez les voies respiratoires:
 - Agenouillez-vous à côté de la victime, les deux genoux au sol
 - Placez une main sur le front de la victime
 - Inclinez doucement la tête vers l'arrière (hyper-extension)
 - Placez deux doigts de votre autre main sous la pointe du menton de la victime
 - Soulevez le menton pour ouvrir les voies respiratoires



mensurà
Learn & Connect

50

4

Vérifier la respiration

Vérifiez la respiration → Vérifiez si la victime respire normalement ou non

VOIR si le thorax bouge

ENTENDRE si vous entendez une respiration

SENTIR si l'air sort de la bouche lors de l'expiration

Voir, entendre et sentir pendant max. 10 secondes

- 2 à 3 / 10 secondes = normal

- < 2 / 10 secondes : respiration absente ou anormale



51

5

Prodiguer les premiers soins



52

30 compressions thoraciques

- **Agenouillez-vous**, les deux genoux à côté de la poitrine de la victime
- La victime est allongée sur le dos → commencez la réanimation là où se trouve la personne (sauf en cas de danger), vous n'avez pas besoin de la déplacer vers une surface dure. Chaque seconde compte !
- Placez le **talon d'une main** au **milieu** de la poitrine → Moitié inférieure du sternum
- Placez le **talon de votre autre main** au-dessus de la **première** main.
- **Croisez** les doigts de vos deux mains
 - Lève les doigts de ta main inférieure → **Aucune pression sur les côtes** de la victime
- Gardez les **bras tendus** et les épaules **perpendiculaires à la poitrine** de la victime
- Poussez le sternum vers l'intérieur en tendant les bras (**min. 5 cm**, pas plus de 6 cm)
 - Temps d'impression = temps de relâchement → Laisser la poitrine se détendre complètement après chaque compression
 - **100 à 120 fois/min.**

mensurà-
Learn & Connect

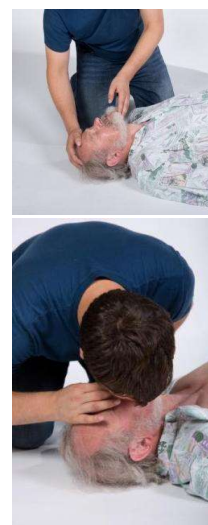
53

2 insufflations → Pas plus de 10 secondes d'interruption!

- Ouvrir les voies respiratoires (voir technique précédente)
- Pincez la partie molle du **nez** avec le pouce et l'index
- Placez votre bouche **entièrement** sur celle de la victime (fermeture hermétique)
- Soufflez pendant **1 seconde**, tout en vérifiant que la poitrine se soulève.
= **respiration efficace**
- Retirez votre bouche et regardez la poitrine redescendre
- Soufflez une deuxième fois dans la bouche de la victime



Maximum 2 tentatives!



mensurà-
Learn & Connect

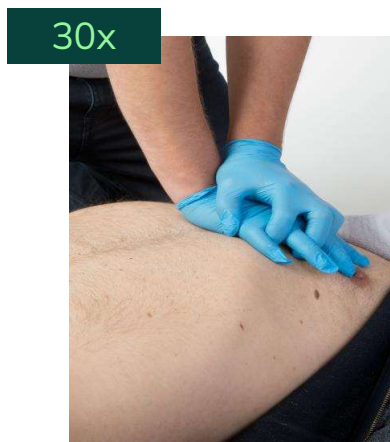
54

Respiration artificielle avec Pocket mask / Life kiss



55

Continuez la RCP



56

Réanimation avec 2 secouristes

La priorité absolue est d'appeler les secours

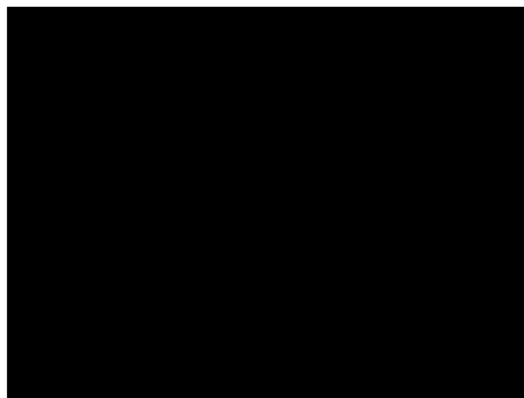
- 1 personne commence la réanimation
- L'autre appelle le 112 et va chercher le DEA

De préférence à genoux face à face

Passer rapidement et facilement d'une tâche à l'autre

- Remplacer toutes les 2 minutes = Durée nécessaire au DEA pour effectuer une nouvelle analyse
- Risque de fatigue ↓ et qualité de la réanimation ↑

57



58

Défibrillateur externe automatique

- Fibrillation = Irrégularité
- DEA = Appareil commandé par ordinateur qui donne des **instructions vocales**
 - Analyse le rythme cardiaque et décide d'administrer un choc électrique
 - Correction d'un trouble du rythme cardiaque = défibrillation
 - Réussi = Le cœur pompe à nouveau normalement
 - Après le premier choc, poursuivre la réanimation → Le DEA analyse à nouveau le rythme cardiaque après 2 minutes
 - Éventuel choc suivant
- Types d'appareils DEA
 - **DEA automatique** → Entièrement automatique
 - **DEA semi-automatique** → Appuyer soi-même sur le bouton pour administrer le choc



Le DEA augmente les chances de réussite d'une réanimation

mensura
Learn & Connect

59

Document standard Mensura: Liste de contrôle des obligations relatives au DEA et registre de vérification du DEA (via MyMensura)

- Contrôle annuel par l'entreprise

Checklijst verplichtingen AED

Register nazicht AED

Onderzoeken/organisatie	
Fabrikant	
Levensduur	
Type	
AED-categorie	

Algemene staat				Alarmboodschap batterij			
	OK	NOK	Opmerking		Ja	Nee	Opmerking
Jan							
Feb							
Maart							
April							
Mai							
Juni							
Juli							
Aug							
Sept							
Oct							
Nov							
Dec							

De AED (automatische externe defibrillator) kan een zeer nuttige aanwinst zijn bij cardiospatoren. Speciale vormen van handblijfsel, die geschikt zijn voor een AED, dient in elke onderneming aanwezig te zijn. Het is echter niet aan te raden om het onderhoud van de AED te laten vallen. Dit omvatten van de democratisering van de publieke toegang tot het gebruik van AED's in openbare gebieden en lokale overheden. AED-categorie 1: automatische externe defibrillator die niet toelaat om te schakelen naar een manuele modus en aldus zelfstandig een elektrische schok toedient, en die niet over een scherm beschikt om het hartritme te volgen. AED-categorie 2: automatische externe defibrillator die toelaat om te schakelen naar een manuele modus en aldus zelfstandig een elektrische schok toedient of die over een scherm beschikt om het hartritme te volgen.

Terbeschikkingstelling en etikettering	Reglementering* en/of toelichting	OK/NOK	Opmerking
1. Wordt het meldingsformulier ingevuld en aan de overheid bezorgd?	Het meldingsformulier van de terbeschikkingstelling van een automatische externe defibrillator (AED) kan men downloaden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: www.vlaanderen.be/nl/overheid/federale-overheidsdienst-volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu . Dit formulier moet ingevuld en overgemaakt worden aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer waarvan het adres vermeld staat op het formulier. Deze instantie kent een registratienummer toe ten laatste één maand nadat het formulier werd ontvangen. Gegevenswijzigingen moeten doorgegeven worden binnen een termijn van één maand.		
2. Bevindt de AED zich in een verzegelde kast die geschikt is voor de opslag van het toestel, de batterij en de elektroden overeenkomstig de aanwijzingen voor opslag van de fabrikant?			
3. Is de kast geplaatst op een duidelijk zichtbare plaats en is de voorkant voorzien van het pictogram zoals voorgeschreven in het KB?			
4. Bevat de kast een geheugensteun zoals verstrekt door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, minimaal in de taal of de talen van het taalgebied waarin de AED ter beschikking wordt gesteld?	De geheugensteun kan men downloaden op de websites van de Europese en Belgische Reanimatieraad: www.er-nls.be en www.renuscab.be		
5. Staan de naam en het adres van de eigenaar vermeld op de kast?			

mensura
Learn & Connect

60

Points d'attention

- Appuyez fermement sur les électrodes
- Les vêtements doivent être suffisamment éloignés
- Retirer les soutiens
- La poitrine doit être sèche
- Épilation des poils du torse à l'aide d'un rasoir pour électrodes
- Ne collez pas les électrodes sur:
 - Bijoux (par exemple piercing)
 - Pansement médicamenteux
 - Pacemaker ou défibrillateur → Collez l'électrode à au moins 8 cm du stimulateur cardiaque

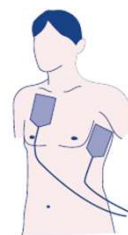


mensurá
Learn & Connect

61

Utilisation d'un DEA

- Activez le DEA
 - Démarre souvent immédiatement à l'ouverture ou via le bouton marche/arrêt
 - Suivez les instructions vocales
 - Placez les électrodes sur la poitrine dénudée comme indiqué
- Position antérolatérale
 - 1 électrode sous la clavicule droite, à côté du sternum
 - Autre électrode sur le côté gauche, sous l'aisselle, au niveau des côtes (ligne midaxillaire)



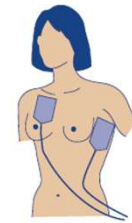
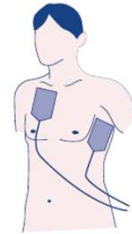
Continuez à **réanimer** pendant que quelqu'un colle les électrodes!

mensurá
Learn & Connect

62

Utilisation d'un DEA

- L'appareil analyse le rythme cardiaque
 - Le DEA demande de ne pas toucher la victime
 - Dites à voix haute que tout le monde doit garder ses distances, faites un geste clair de la main
- L'appareil délivre **un choc**?
 - **Ne pas toucher la victime**
 - Après: reprendre la réanimation
- L'appareil ne délivre **pas de choc**
 - **Reprendre la réanimation**
- Suivez ensuite les instructions du DEA

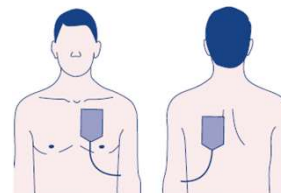
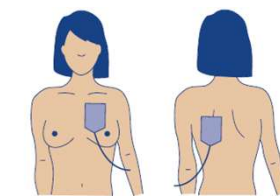


63

Attention!



Position anteropostérieure
si la position **antéro-latérale** n'est pas possible (par exemple en cas de plaies)



64



Defibrillator Externe Automatique

Une défibrillation rapide = plus de chances de réussite!

mensurá
Learn & Connect

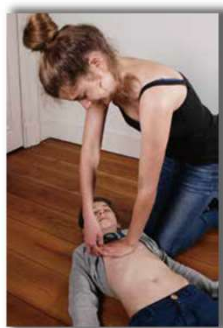
65



Pediatric Basic Life Support (PBLS) et DEA

66

Secourisme pour bébés et enfants



mensurà
Learn & Connect

67

Contexte

- Les arrêts cardiaques chez les enfants sont rares
→ C'est la conséquence d'une **maladie ou d'un accident**
- L'arrêt cardiaque est généralement dû à un **arrêt respiratoire**
→ Commencez par 5 **respirations initiales**
- Une réanimation **mal effectuée** vaut mieux que **pas de réanimation du tout**
- Une réanimation **précoce** améliore la survie des enfants
(**60%** versus 5-10%)

mensurà
Learn & Connect

68

Contexte

Bébé: 0 - 1 an

Enfant: 1 - 18 ans

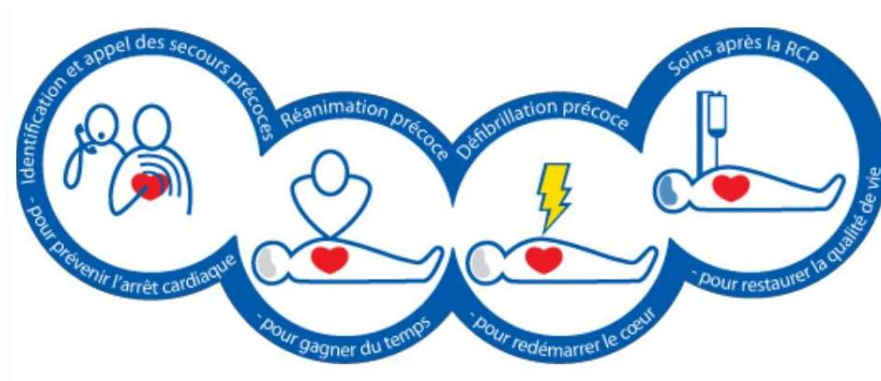
Adulte: +18 ans

Si vous considérez la personne comme un adulte,
suivez les directives Adult BLS.

Enfants et bébés – différences par rapport aux adultes

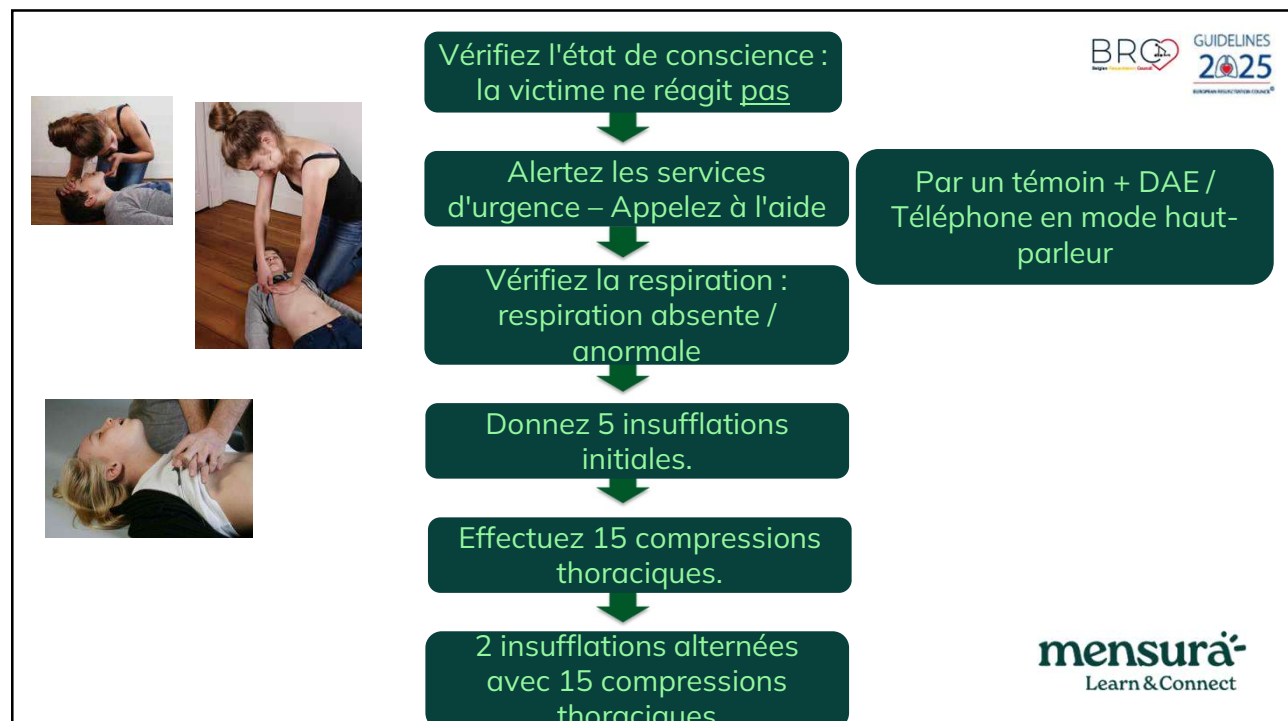
- Tête plus grande
- Langue relativement plus épaisse
- Jusqu'à l'âge de 6 mois environ, les bébés respirent principalement par le nez.
 - Respiration nasale obligatoire
- Plus sensible aux problèmes respiratoires
- Plus sensible à la perte d'humidité
- Signes et symptômes qui peuvent vous alerter
 - Comportement
 - Respiration
 - Couleur du corps

Chaîne de survie



mensurà
Learn & Connect

71



72

Vérifiez l'état de conscience

- Secouez doucement les épaules d'un enfant ou tapotez la plante des pieds du bébé
- **L'enfant / le bébé réagit?**
 - S'il n'y a pas de danger, vous devez maintenir la position de l'enfant.
 - Continuez à **contrôler l'état de conscience**
- **Enfant / bébé ne réagit pas?**
 - Appelez le **112** (haut-parleur si vous êtes seul)
ou
Demandez à un **passant** d'appeler



Si vous êtes seul et sans téléphone ? → Commencez par 1 minute de RCP avant d'appeler les secours

mensurá
Learn & Connect

73

Vérifiez la respiration

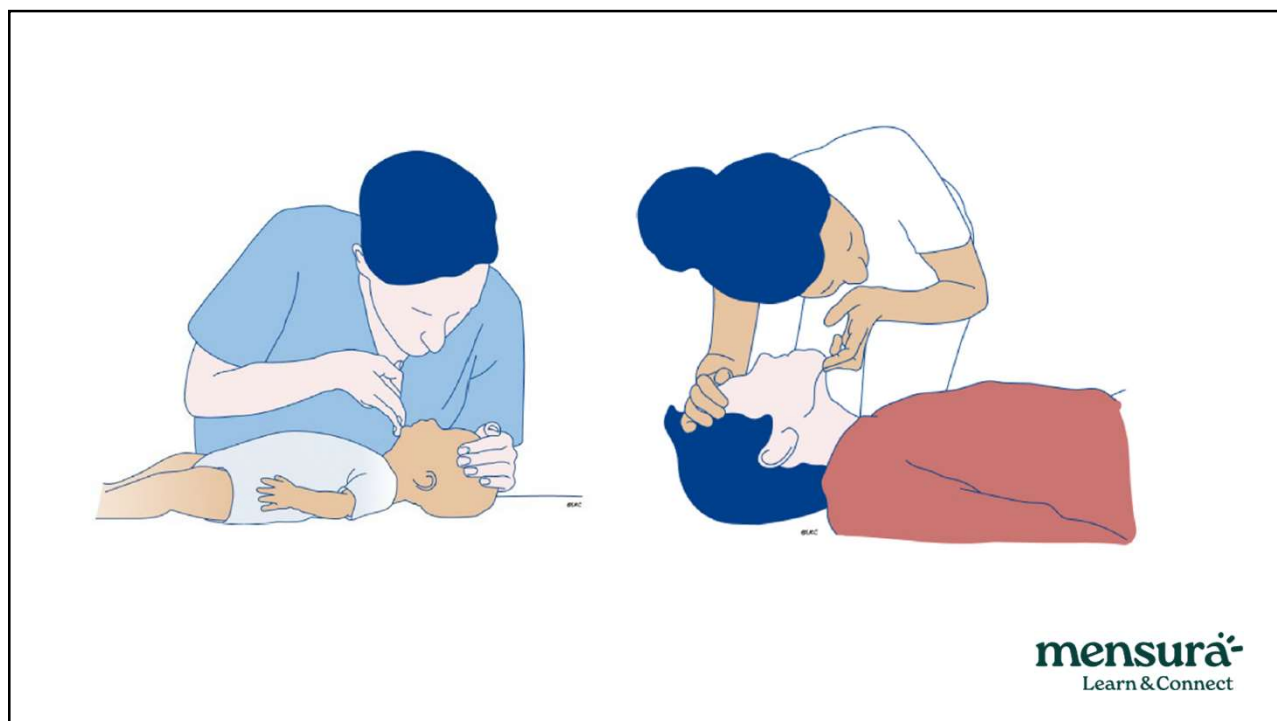
- Ouvrez les voies respiratoires et vérifiez la respiration
- Regardez, écoutez et ressentez pendant **10 secondes maximum**
- - **Bébé** → Tête en position neutre (légère inclinaison)
- - **Enfant** → Inclinaison supplémentaire de la tête
- - **Adolescent** → Extension complète de la tête (comme chez l'adulte)



Si vous êtes seul et sans téléphone ? → Commencez par 1 minute de RCP avant d'appeler les secours

mensurá
Learn & Connect

74



75



Réanimation des bébés et des enfants

5 insufflations initiales
 Ensuite, rapport 15:2 → Sauf signes évidents de vie (par exemple, toux, mouvements)

Compressions thoraciques 100 à 120 x/min.

→ Nourrissons et enfants : min. 1/3 de la profondeur de la poitrine (pas plus de 6 cm)

Bébé 0 – 1 an
 → Technique à deux doigts pour effectuer le massage cardiaque

Enfant/adolescent 1 – 18 ans
 → Technique à une main ou à deux mains
 Avec la technique à une main, l'autre main peut être utilisée pour maintenir les voies respiratoires ouvertes (ou soutenir le bras de compression au niveau du coude)



76

Ventilation artificielle du bébé 0-1 an

Respiration bouche-à-bouche et nez-à-nez

1. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière (position neutre)
2. Soulevez le menton avec l'index
3. Placez votre bouche sur la bouche et le nez du bébé (fermeture hermétique)
4. Soufflez pendant 1 seconde, tout en vérifiant que la poitrine se soulève
5. Retirez votre bouche et regardez la poitrine redescendre
6. Soufflez une deuxième fois dans la bouche et le nez du bébé



mensurà-
Learn & Connect

77

Ventilation artificielle du bébé 0-1 an

Respiration bouche-à-bouche et nez-à-nez

Méthode des deux pouces

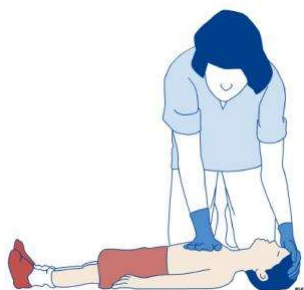
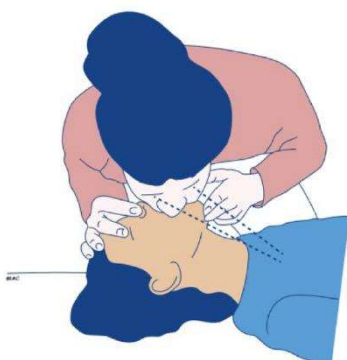


BRC GUIDELINES
2025
RECHERCHES MEDICO-SCIENTIFIQUES

mensurà-
Learn & Connect

78

Ventilation artificielle Enfant ou adolescent (1 tot 18 ans)



ura-
Learn & Connect

79

Utilisation d'un DEA chez les bébés et les enfants

- **Poids < 25 kg**
-> Défibrillateur en mode pédiatrique / Électrodes pédiatriques
- **Poids > 25 kg**
-> Défibrillateur en mode standard pour adultes

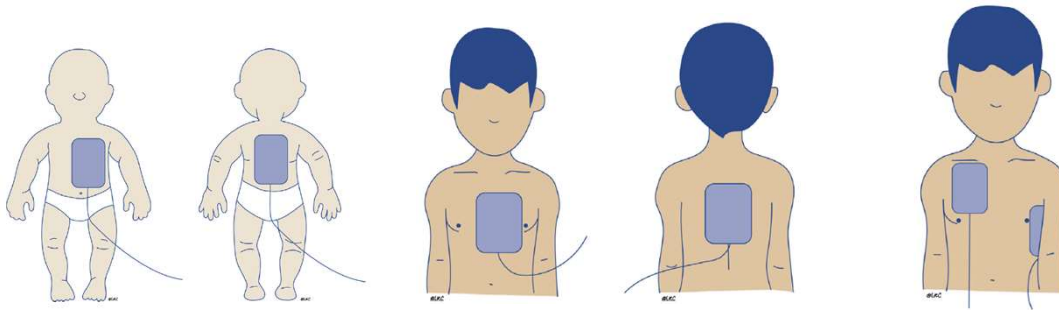


mensurá-
Learn & Connect

80

Defibrillator Externe Automatique

- Position **anteroposterieure** → Bébé et enfants < 25 kg
- Position **anteroposterieure** ou **anterolaterale** → > 25 kg et adolescents



81



Obstruction des voies respiratoires adultes

82

Obstruction des voies respiratoires

La victime tousse ouvertement

Modéré -
Conscient(e)

- **Symptôme(s)**
 - Toux, haut-le-cœur, changement de voix
 - Voies respiratoires = dégagées →
Respiration OK
- **Premiers secours**
 - Encourager la toux



mensurá-
Learn & Connect

83

Obstruction des voies respiratoires

La victime s'étouffe

Sévère -
Conscient(e)

Obstruction (quasi) totale des voies respiratoires

Symptômes

- Panique – porte les mains à la gorge
- Impossible de respirer / parler (parfois respiration sifflante)
- Réduit la conscience / Perte de conscience
- Décoloration progressive de la peau (rouge → pâle → bleu)

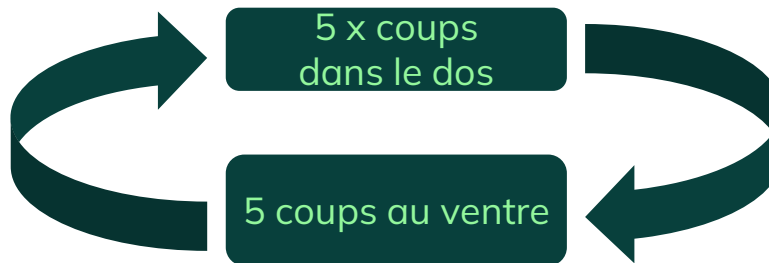


mensurá-
Learn & Connect

84

Premiers secours

- Retirez les objets **visibles** dans la bouche
- Plusieurs personnes → Appelez le 112
 Seul? → D'abord 5 coups dans le dos et 5 coups dans le ventre



Réussi ? → Examen complémentaire par un professionnel de santé en raison du risque de complications, de blessures

85

Obstruction des voies respiratoires adultes



Grave - Conscient

Technique

5 x coups dans le dos

et

5 coups au ventre

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes et les bébés de moins d'un an.

86

Obstruction des voies respiratoires adultes



Sévère -
Conscient(e)

Technique

5 x compressions
thoraciques

Chez les femmes enceintes
ou les personnes obèses

87

Obstruction des voies respiratoires adultes



Dangers

Sévère -
Conscient(e)

Obstruction grave des voies respiratoires

=

Arrêt respiratoire

Manque d'oxygène dans le cerveau → Perte de conscience

88

Obstruction des voies respiratoires adultes

Sévère - Inconscient(e)

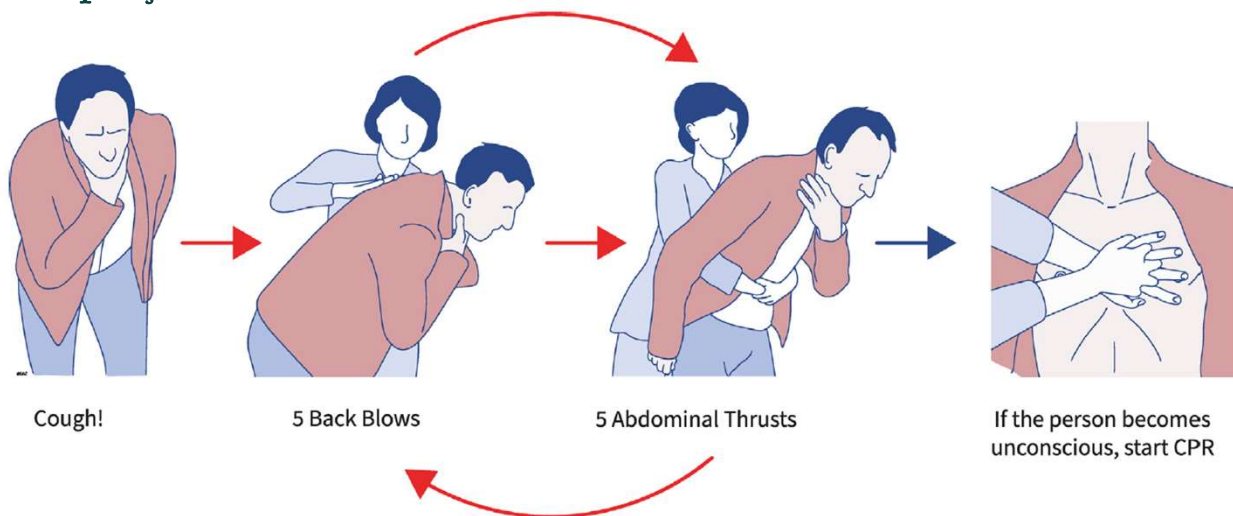
Protocole BLS
(Basic life support)



89

M1

Aperçu



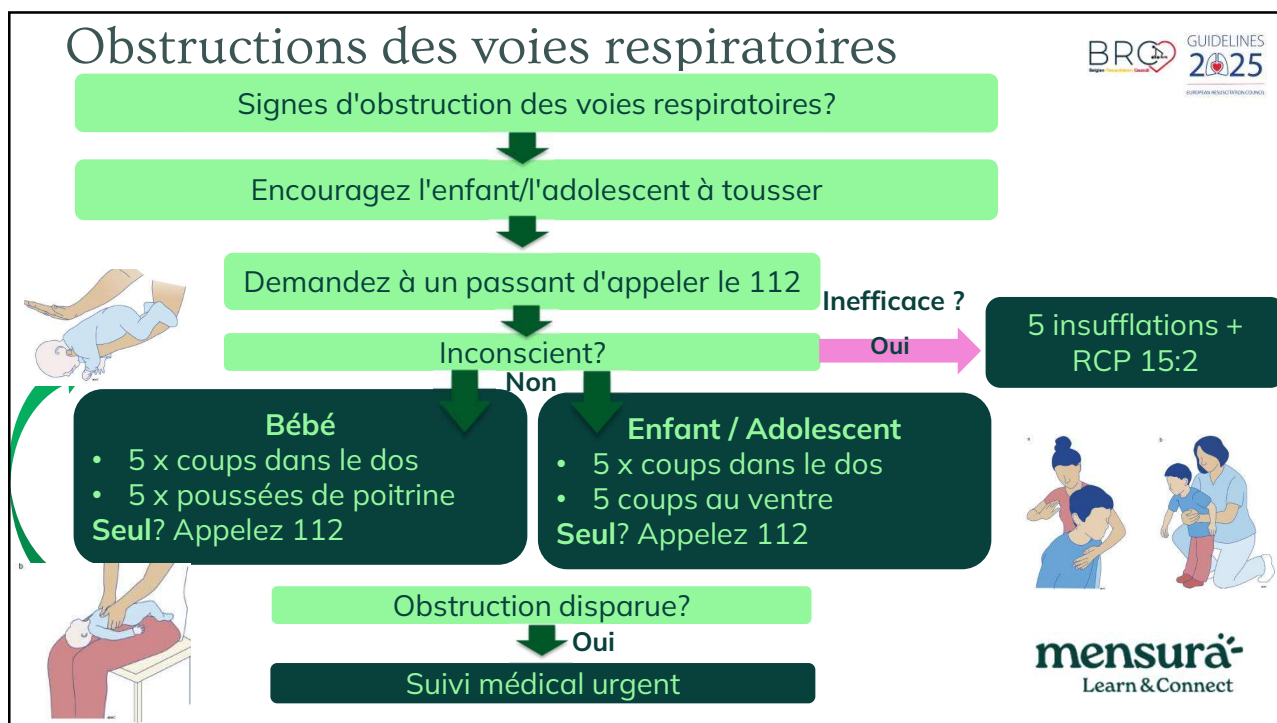
90

JM1 Nieuwe slide 31/10/2025 + nieuw logo ERC 2025.

Moerman Joséphine; 2025-10-31T15:27:03.337

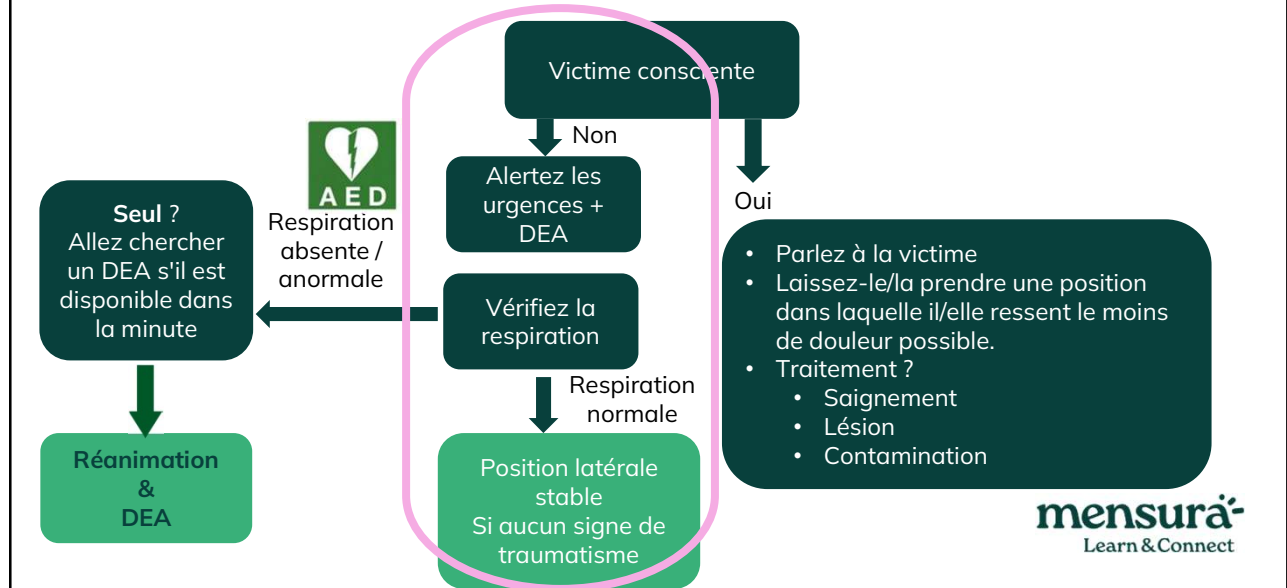


91



92

Organigramme approche



93

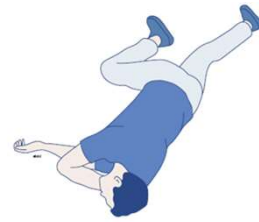
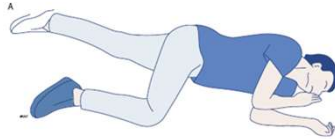


94

Position latérale stable

Placez la victime en position latérale de sécurité si :

- Il respire normalement, mais ne montre aucune réaction
- Sa respiration est entravée par du sang, des vomissures ou d'autres fluides corporels



Attention



En cas de **respiration anormale ou de traumatisme**, la personne ne doit **pas** être placée en position latérale de sécurité !

Position **couchée sur le dos** / Stabilisation cervicale manuelle
(voir chapitre « Lésions vertébrales »)

mensurá
Learn & Connect

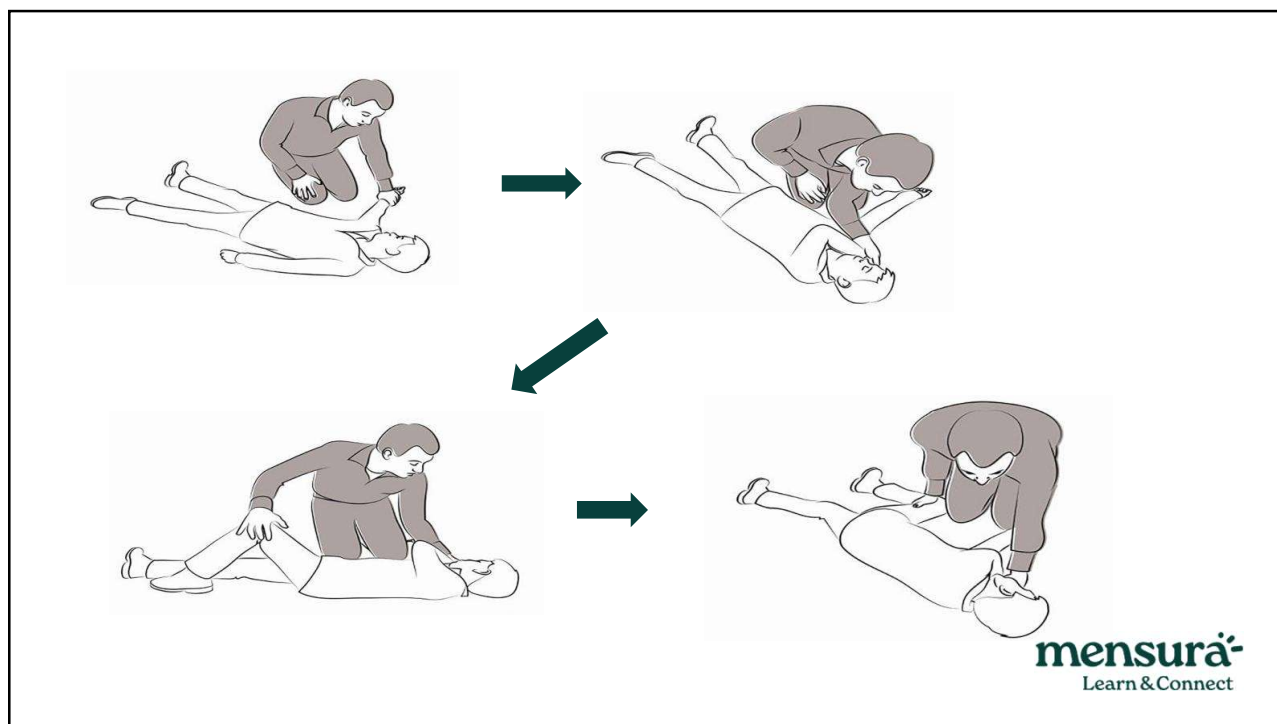
95

Position latérale stable

- **Etape 1:** Agenouillez-vous à côté de la victime
→ Retirez les lunettes de la victime, si nécessaire, et veillez à ce que ses jambes soient tendues
- **Etape 2:** Saisissez le bras de la victime le plus proche de vous
→ Angle droit avec la paume vers le haut
- **Etape 3:** Maintenez le dos de la main de l'autre bras contre la joue
→ Tenez cette main
- **Etape 4:** Saisissez la jambe et tournez la victime
→ Fléchissez le genou de la jambe la plus éloignée, tout en gardant le pied au sol
- **Etape 5:** Maintenez les voies respiratoires dégagées et continuez à surveiller la respiration
→ Penchez la tête en arrière pour dégager les voies respiratoires.

mensurá
Learn & Connect

96



97



98

Position latérale stable pour bébés et enfants

- **Victime inconsciente mais qui respire → Sans signe de traumatisme physique!**

- Position latérale stable
- Placez un petit coussin ou une couverture enroulée derrière le dos
 - Le bébé/l'enfant est plus stable.
- Continuez à contrôler la respiration!

Attention



En cas de respiration **anormale ou de traumatisme**, le bébé/l'enfant ne doit **pas** être placé en position latérale de sécurité !

Position couchée sur le dos / Stabilisation cervicale manuelle
(voir chapitre « Lésions vertébrales »)

mensura
Learn & Connect

99

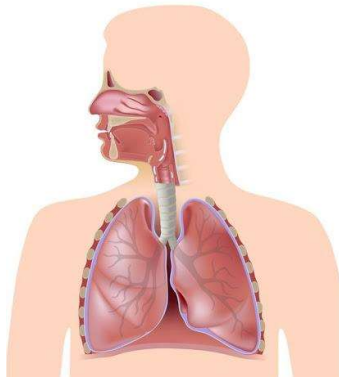


Pathologies du système respiratoire :

Hyperventilation - essoufflement - Asthme

100

Respiration?



Respiration

Échange gazeux

Circulation sanguine

mensurà
Learn & Connect

101

Composition de l'air inhalé

	Inhalation	Expiration
Azote (N ₂)	78%	78%
Oxygène (O ₂)	21%	17%
Dioxyde de carbone (CO ₂)	0,04%	4%
Autres gaz	1%	1%

mensurà
Learn & Connect

102

Hyperventilation

= **Respiration trop rapide** → Oxygène dans le sang ↑ Dioxyde de carbone dans le sang ↓

Causes

- Nerveux
- Peur
- Stress accru
- Après un accès de colère
- Situation émotionnelle
- ...



mensurà
Learn & Connect

103

Hyperventilation

Symptômes

- Anxieux et agité
- Essoufflement/vertiges
- Palpitations cardiaques
- Fourmillements dans les doigts
- Fourmillements autour de la bouche
- Crampes dans les orteils/doigts
- ...



mensurà
Learn & Connect

104

Hyperventilation

Que faites-vous ?

- Transportez la victime dans un endroit calme
- Demandez à inspirer et expirer lentement
 - Main fermée repliée en forme de coquillage
 - Avec un sac en plastique/papier
- (Moins d'oxygène dans le sac que dans l'environnement, la victime respire à nouveau du dioxyde de carbone)
- Relâchez les vêtements trop serrés
- Restez auprès de la victime
- Avertissez les urgences si l'attaque persiste
- ...



À ne pas confondre
avec une crise
cardiaque, des
troubles du rythme
cardiaque et un
œdème pulmonaire.!

mensurà
Learn & Connect

105



mensurà
Learn & Connect

106

Essoufflement ≠ hyperventilation

Essoufflement	Hyperventilation
• Réaction à des substances ou maladies chroniques • Expiration plus longue, respiration sifflante • Bleuissement des lèvres/ongles • Posture voûtée	• Réaction à une situation chargée d'émotion • La respiration est rapide et profonde • Vertiges • Transpiration • Fourmillements et crampes

mensurà
Learn & Connect

107

Essoufflement

Que faites-vous ?

- Rassurez la victime, évitez la panique
- Ne faites pas faire d'efforts à la victime
- Demandez à la victime de respirer calmement
- Recherchez avec la victime la position la plus appropriée
- Relâchez les vêtements trop serrés
- Médicaments ? → Par exemple, faire prendre un inhalateur



mensurà
Learn & Connect

108

Asthme

Quoi? = Maladie pulmonaire associée à une inflammation chronique des voies respiratoires

- Rétrécissement des petites branches trachéales
- Formation de mucus
- Essoufflement

Causes?

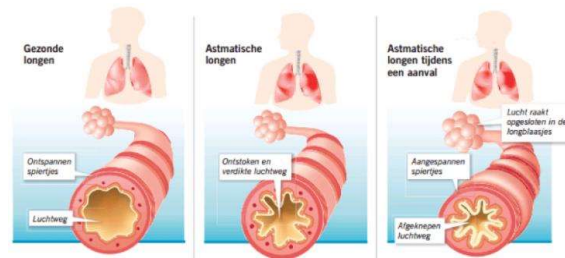
- Allergies

Symptômes?

- Expiration difficile et sifflante
- Utilisation des muscles respiratoires auxiliaires
- Cyanose : ongles/lèvres bleus, peau pâle

Traitement

- Aidez la victime à prendre ses médicaments → p. ex. son inhalateur



mensura
Learn & Connect

109

1

Sécurité générale

- Desserrer les vêtements serrés (col, cravatte, ceinture)
- Ne plus faire d'efforts

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience et de la respiration

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Attaque prolongée et/ou le médicament n'a aucun effet après 5 minutes
- Perte de conscience, cyanose, toute première crise

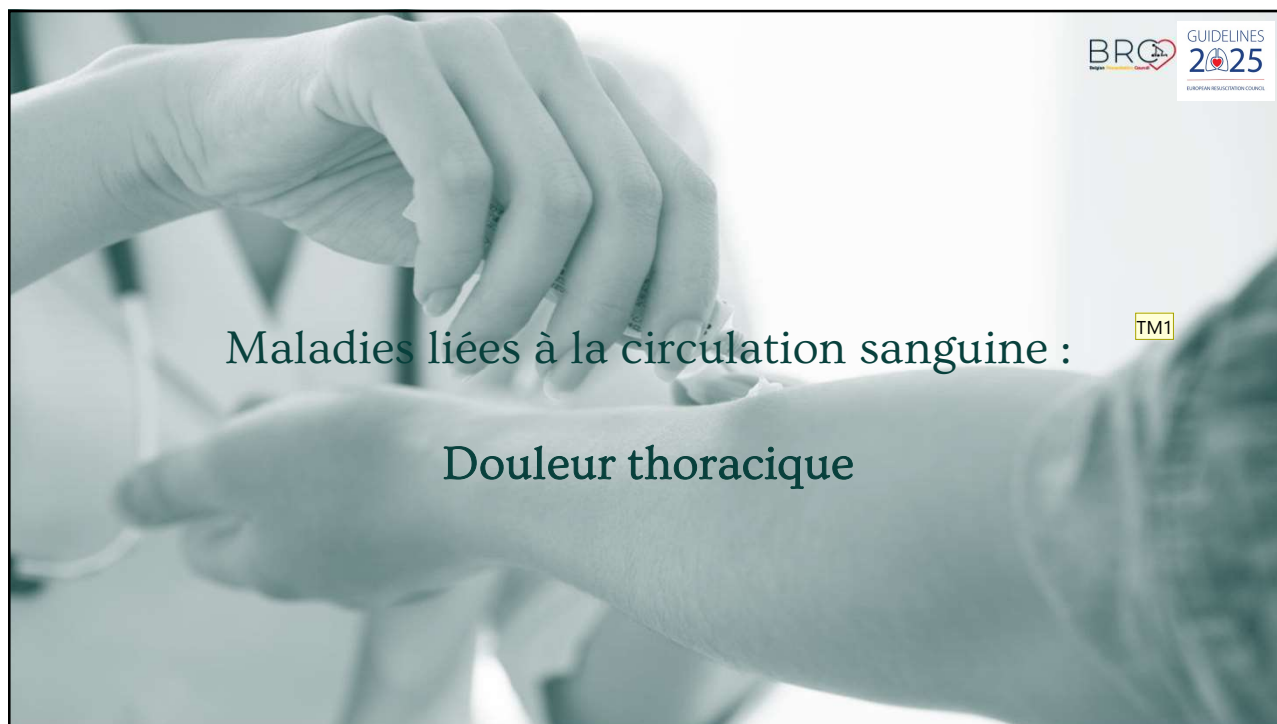
4

Premiers secours supplémentaires

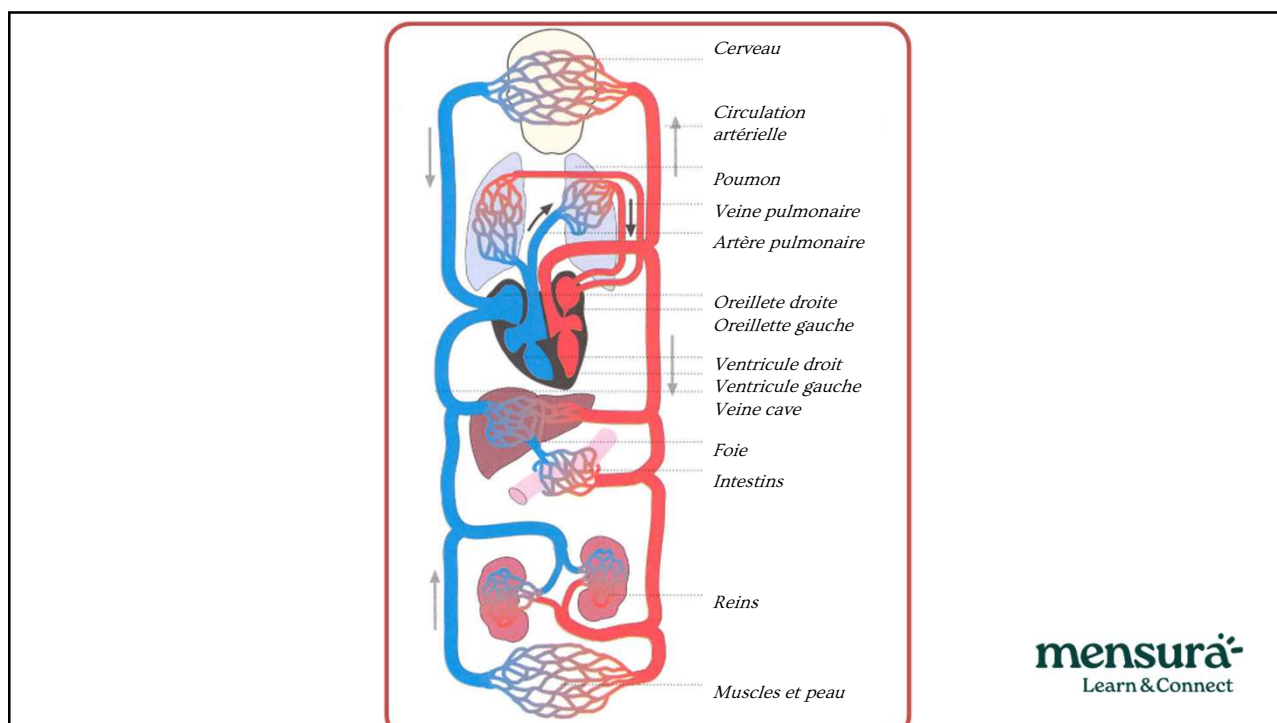
- Position assise légèrement penchée en avant, en s'appuyant sur les coudes
- Antécédents ? Médicaments?
- Essayez de rassurer la victime
- Essayer de normaliser la respiration

mensura
Learn & Connect

110



111



112

TM1 Dit zijn titels dus moet OVO zijn ipv Mulish
Motton Tiffany; 2025-10-22T07:45:37.564

Douleur thoracique

Pour les adultes conscients souffrant de douleurs thoraciques non traumatiques résultant d'une crise cardiaque présumée:

- Rassurez la victime
- Placez ou allongez la victime dans une position confortable
- Appel à l'aide

Si la victime souffre d'un problème cardiaque connu, elle peut prendre les médicaments qui lui ont été prescrits

mensurà
Learn & Connect

113

Douleur thoracique

Caractéristiques courantes:

- Douleur intense et sensation d'oppression derrière le sternum
- Irradiant vers l'épaule et le bras gauches
- Teint parfois pâle ou grisâtre
- Parfois, lèvres et ongles bleus
- Peur
- Tension au niveau de la mâchoire
- ...



La douleur thoracique peut avoir plusieurs causes autres qu'un problème cardiaque, p.ex. des brûlures d'estomac, une crise de panique, un pneumothorax ou une rupture de l'aorte



mensurà
Learn & Connect

114

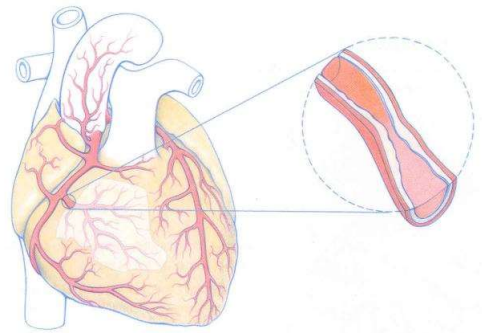
Angor

= **Crise cardiaque**

- Le muscle cardiaque ne reçoit pas assez d'oxygène
- Rétrécissement des artères du cœur
- Surtout pendant l'effort physique
- S'améliore parfois lorsque l'effort cesse

Que faites-vous?

- Consultez un spécialiste → Symptômes également au repos, symptômes apparaissant pour la première fois, symptômes s'aggravant en intensité, fréquence ou durée
- Veillez à ce que la victime reste aussi calme que possible et évite tout effort physique
- Position confortable (pas allongée !)
- Retirez les vêtements serrés



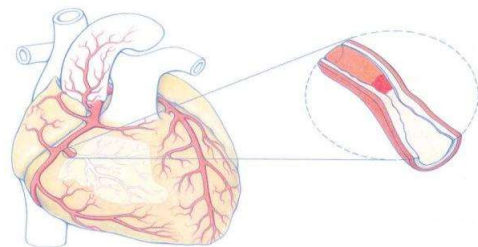
mensurà-
Learn & Connect

115

Crise cardiaque

= **Rétrécissement ou obstruction de l'artère coronaire**

- Manque d'oxygène dû à l'obstruction d'une artère du cœur
- Perturbation du fonctionnement cardiaque → Accélération ou ralentissement du rythme cardiaque
- Nécrose d'une partie du muscle cardiaque
- Au repos ou à l'effort
- Inattendu



Plus de risques en cas de facteurs de risque

→ Âge, hérédité, sexe, hypertension, diabète, surpoids, tabagisme, ...

mensurà-
Learn & Connect

116

Conséquences

- Fonctionnement normal perturbé
- Pompage plus rapide ou plus lent
- Contractions moins puissantes ou irrégulières
- Perturbation de l'apport en oxygène de l'organisme
- Pâle, grisâtre, bleu
- Peur
- Troubles du rythme cardiaque, arrêt cardiaque



DEA à proximité!!!

mensurá-
Learn & Connect

117

Que faites-vous?

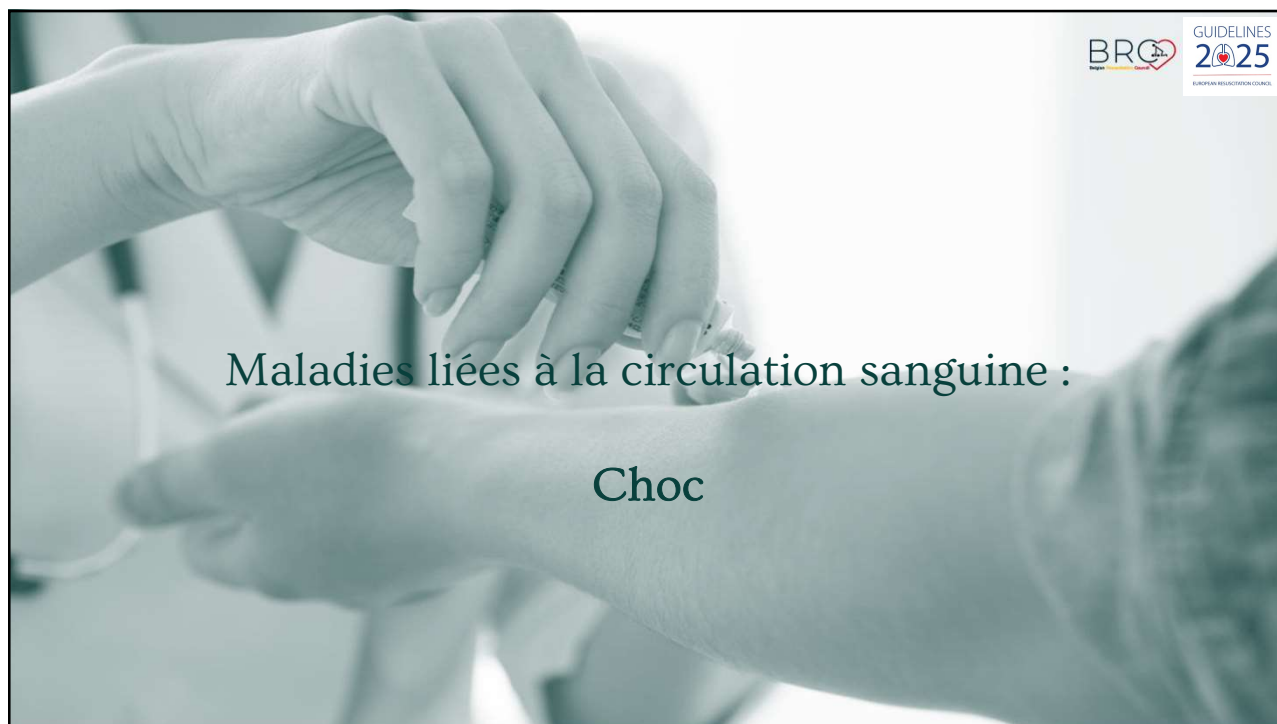
- Consultez un spécialiste → la victime est plus rapidement essouffée, moins TM1 apte à fournir des efforts physiques, a les jambes enflées, souffre d'essoufflement.
- Position semi-assise
- Contrôle des fonctions vitales toutes les minutes
- Règles de base des premiers secours, c'est-à-dire rassurer, limiter les efforts au minimum, demander si la victime a déjà eu de telles crises
- Si la victime souffre d'un problème cardiaque connu, elle peut prendre les médicaments qui lui ont été prescrits.

mensurá-
Learn & Connect

118

TM1 Tekst was nog in ovo

Motton Tiffany; 2025-10-22T07:48:05.616



119

Choc

La circulation est un système de pompage fermé

Sous pression → tension artérielle

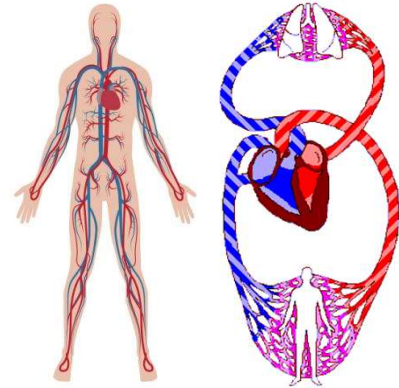
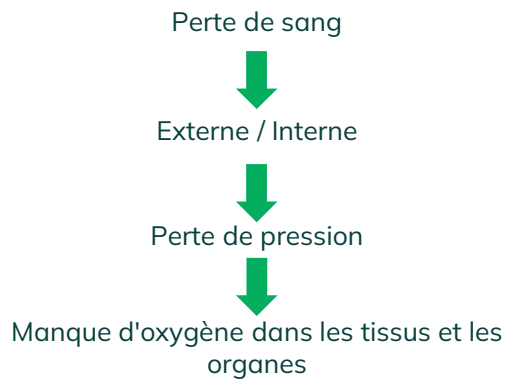
Il y a trois éléments importants:

1. Pompe = Cœur
2. Conduites = Vaisseaux sanguins
3. Moyen de transport = Sang

mensura
Learn & Connect

120

Choc



Le fonctionnement des organes vitaux (cœur, cerveau, reins) est menacé.

mensurà
Learn & Connect

121

Choc

Comment notre corps réagit-il?

Compenser la perte de pression et le manque d'oxygène

Comment?

- La pompe passe en surrégime, le rythme cardiaque s'accélère
- La fréquence respiratoire augmente, besoin supplémentaire en O₂
- Les vaisseaux sanguins se rétrécissent pour compenser la baisse de pression artérielle

→ Peau pâle, froide et moite

→ Nausées

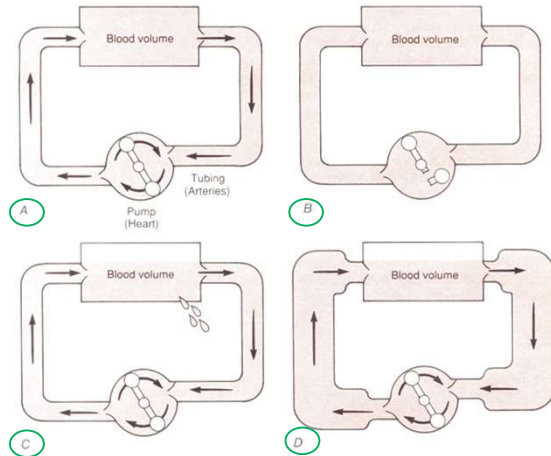
→ Ce sont les premiers signes extérieurs d'un CHOC auxquels vous devez réagir immédiatement !

mensurà
Learn & Connect

122

Choc

Exemples



A. Système de pompage normal

B. CHOC cardiogénique

- Pompe à vide

C. CHOC hypovolémique

- Perte de sang

D. CHOC distributif

- Extrême dilatation des vaisseaux sanguins

mensurà
Learn & Connect

123

Symptômes du choc hypovolémique

= Choc dû à une insuffisance du volume sanguin

- Teint pâle, grisâtre ou marbré
- Sensation de froid dans tout le corps
- Peau humide et moite
- Pouls difficile à sentir, faible et accéléré
- Respiration difficile ou accélérée
- État de conscience modifié ou personne difficile à réveiller
- Agitation anormale ou calme anormal

Toute personne présentant **une perte de sang** importante est un candidat potentiel au CHOC

mensurà
Learn & Connect

124

1

Sécurité générale

- Gants
- Laissez la victime allongée

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience, possible : éveillé → somnolent → après contact
- Contrôle respiratoire
! Ne vous laissez pas tromper par une respiration rapide!

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Alerter les services d'urgence (ou faire en sorte qu'ils soient alertés) le plus rapidement possible.



mensurà
Learn & Connect

125

4

Premiers secours supplémentaires

- Éliminez la cause, compressez le saignement externe ;
- Soyez vigilant face au refroidissement ou à l'hypothermie ;
- Laissez la victime se reposer et ne lui demandez plus aucun effort ;
- Parlez à la victime ;
- Réévaluez la situation toutes les minutes à l'aide du plan en étapes.

mensurà
Learn & Connect

126



127

Diabète

Prévalence : 4/100 personnes (dont 2 ne le savent pas)

Pancréas → Insuline

Sucre provenant de l'alimentation → Le glucose (combustible) passe par l'insuline (pancréas) → Cellules du corps → Taux de sucre dans le sang ↓

Diabètes = Troubles du métabolisme du glucose → Glycémie du sang déséquilibrée

Taux de glycémie normal : 80 à 120 milligrammes/100 millilitres de sang

2 types

mensurá-
Learn & Connect

128

Diabète

Type 1 → Diabète insulino-dépendant

= Perturbation de la production d'insuline dans le pancréas

- Déficit quasi absolu en insuline
- Généralement à un jeune âge
- Souvent un début aigu
- Souvent très instable
- Le patient s'injecte de l'insuline ou porte une pompe à insuline



mensurá-
Learn & Connect

129

Diabète

Type 2 → Diabète non insulino-dépendant ou diabète de la vieillesse

= Les cellules de l'organisme sont moins sensibles à l'insuline (résistance à l'insuline)

- Seulement un déficit relatif en insuline
- Généralement chez les patients âgés de plus de 40 ans.
- Commence généralement de manière insidieuse
- Traitement:
 - Une alimentation saine, plus d'activité physique
 - Médicaments
 - Injections d'insuline éventuelles

mensurá-
Learn & Connect

130

Diabète

Facteurs causaux

- Prédisposition héréditaire
- Suspicion chez:
 - Personnes ayant reçu un diagnostic familial de diabète
 - Naissance d'un enfant dont le poids à la naissance est supérieur à 4,5 kg
- Obésité
- Infections
- Stress intense et chronique, brûlures graves
- Médicaments : hormone de croissance, cortisone,...
- Lésions du pancréas

mensurà-
Learn&Connect

131

HYPO

- Changement de caractère
- Maux de tête
- Fatigue
- Pâleur
- Transpiration
- Tremblement
- Vertige
- Vue trouble

HYPER

- Fatigue
- Somnolence
- Langue sèche
- Soif

Novo Nordisk Pharma AG
Strickhofstrasse 45
6709 Küssnacht
Tel. 01818 11 11
Fax 01818 11 00
www.novonordisk.ch

novonordisk

mensurà-
Learn&Connect

132

Hypoglycémie

→ Les symptômes apparaissent souvent rapidement!

La victime est consciente et capable d'avaler :

- Donnez par voie orale 4 à 5 comprimés de glucose, un verre de soda ou de jus de fruits, 2 à 3 morceaux de sucre, des Skittles ou des Mentos, des bonbons gélifiés

→ Sucres à action rapide!

- Répétez si les symptômes persistent et ne s'améliorent pas après 15 minutes
- Donnez une collation légère (sandwich, gaufre) lorsque les symptômes ont disparu et que la victime se sent mieux



mensurà
Learn & Connect

133

1

Sécurité générale

- Dans le cadre des premiers secours, nous partons du principe qu'il s'agit d'une **hypoglycémie**.
- En cas d'« hypo », il faut en effet agir rapidement.
- L'hyperglycémie évolue beaucoup plus lentement.

2

Évaluez l'état de la victime

- Identifiez le problème.
- Vérifiez l'état de conscience.
- Ouvrez les voies respiratoires et vérifiez la respiration si nécessaire.
- Si conscient : contrôler la glycémie + demander quand il a mangé pour la dernière fois => si impossible, donner du sucre.

mensurà
Learn & Connect

134

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- La victime est ou devient inconsciente
- L'état de la victime ne s'améliore pas après les premiers secours
- La première prise de sucre n'a pas l'effet souhaité



Une hypoglycémie non corrigée est une urgence médicale qui peut être fatale. La rapidité de la prise en charge est cruciale pour éviter les séquelles graves voir la mort.

mensurà
Learn & Connect

135

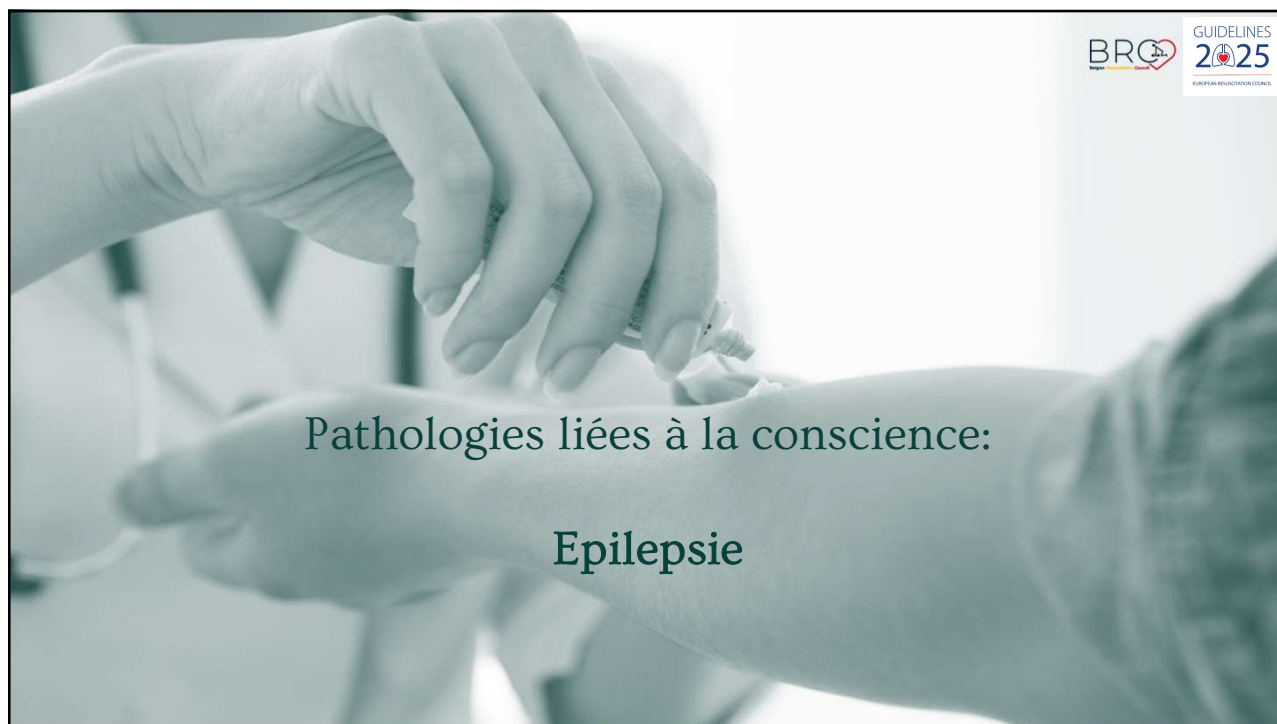
4

Premiers secours supplémentaires

- Essayez de savoir si la victime qui présente des troubles de la conscience souffre de diabète.
- Donnez à une victime diabétique qui se sent faible, mais qui est bien conscient, sucres rapides puis lents.
- Demandez à la victime ou à un proche (par exemple un membre de la famille) de mesurer son taux de glycémie si possible.
- S'il s'avère qu'il s'agit d'une hyperglycémie, demandez-lui s'il a déjà pris ses médicaments à ce moment-là.
- Ne lui donnez pas de médicaments vous-même, mais laissez-le prendre ses médicaments s'il le souhaite.
- Demandez-lui de respecter la dose et d'utiliser la bonne technique.

mensurà
Learn & Connect

136



137

Causes des convulsions

La victime présente soudainement des mouvements saccadés.

Cause des convulsions :

- Épilepsie
- Lésions cérébrales : à la naissance, après un accident, tumeur
- Empoisonnement
- Drogues
- Inflammation du cerveau ou des méninges
- Troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels
- Fièvre , hyperthermie
- ...

mensurà
Learn & Connect

138

Epilepsie

Définition = Surexcitation soudaine du cerveau. Les signaux électriques ne sont pas transmis correctement.

→ Conséquence = Ecrise d'épilepsie (différents types)

- **Hyperstimulation locale**

= Le bras, la jambe ou la tête effectue soudainement des mouvements incontrôlables.

Perceptions anormales, mouvements sans but.

- **Surcharge sensorielle totale**

- **Petite attaque** = La victime semble soudainement absente, sans chute

- **Grande attaque** = Perte de conscience, muscles tendus, mouvements saccadés

mensurá-
Learn & Connect

139

Epilepsie

Conséquences → la victime n'a plus aucun contrôle sur elle-même

- La victime peut se blesser avec des objets se trouvant à proximité
- la victime peut tomber ou n'est plus en mesure de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine
- La victime peut se blesser en se mordant la langue ou la joue
- Lors d'une crise grave, il est possible que la victime ne puisse plus respirer
- La durée de l'attaque détermine le danger

L'attaque en soi n'est pas dangereuse et cesse généralement spontanément, sauf en cas de **status epilepticus!**

→ L'attaque dure plus de 5 minutes / Série d'attaques consécutives

mensurá-
Learn & Connect

140

Epilepsie

- Risque de lésions cérébrales irréversibles dues à un manque d'oxygène (par la production de salive et de mucus)
- Risque de maladies cardiaques (personnes âgées)

Lorsque deux ou plusieurs attaques importantes se succèdent dans un court laps de temps



mensurà
Learn & Connect

141

Epilepsie

Observations lors d'une attaque majeure

- **Première phase:** Prise de conscience
→ Attaque : perte de conscience
- **Deuxième phase:** Tension musculaire
- **Troisième phase:** Phase de choc
- **Dernière phase:** Relaxation



mensurà
Learn & Connect

142

Epilepsie

Prévention

Il y a certains **facteurs déclencheurs** d'une crise d'épilepsie

Conseillez à la victime d'**éviter** ces déclencheurs :

- Lumière flash
- Manque de sommeil
- Stress
- Hyperventilation
- Ne pas prendre de médicaments
- Consommation excessive d'alcool
- Consommation de drogues (XTC)

mensurá
Learn & Connect

143

1

Sécurité générale

- Retirez les objets avec lesquels la victime pourrait se blesser
- Ne déplacez que si vous ne pouvez pas sécuriser les environs
- Enfilez des gants jetables
- **Ne mettez rien dans la bouche ou entre les dents!**
- Ne retenez pas la victime et n'essayez pas de l'arrêter
- La victime peut être confuse et agressive après la crise

2

Évaluez l'état de la victime

- Identifiez le problème
- Les convulsions sont-elles terminées?
 - Contrôle de la conscience
 - Retirez l'objet de sous la tête
 - Contrôle respiratoire

mensurá
Learn & Connect

144

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Victime sans antécédents d'épilepsie? → **112**
- Victime connue pour souffrir d'épilepsie?
 - 1ère phase de tension et de détente = pas de **112**
 - 2e phase de tension et de détente = **112**
- La victime reste inconsciente pendant plus de 2 minutes **après** l'agression ;
- L'attaque dure plus de 5 minutes ;
- Les attaques se succèdent sans discontinuer ;
- Si les symptômes diffèrent des crises précédentes ;
- La victime a consommé de la drogue ou de l'alcool, elle a de la fièvre, elle est enceinte, elle souffre de diabète, elle présente des blessures graves supplémentaires et en cas de doute.

mensurá
Learn & Connect

145

4

Premiers secours supplémentaires

- Restez auprès de la victime pendant la phase de tension
- Enregistrez les caractéristiques de l'attaque
 - Durée
 - Réactions de la victime
 - Antécédents?
- Pendant la phase de relaxation → approche victime
 - Conscient et respiration → laissez la victime allongée, parlez-lui et donnez-lui la possibilité de reprendre ses fonctions
 - Inconscient et respiration
 - Position latérale stable
 - Vérifiez toutes les minutes

mensurá
Learn & Connect

146

Convulsions fébriles

Quoi?

- Généralement chez les enfants de moins de 5 ans
- **Augmentation rapide de la température corporelle**
- Parfois, les convulsions fébriles sont les premiers signes indiquant que l'enfant est malade
- Peut être héréditaire
- Apparition soudaine d'un état convulsif
- Prévalence : 5 % des enfants

mensurá
Learn & Connect

147

Convulsions fébriles

Symptômes

- Fièvre
- Mouvements brusques
- Parfois perte de conscience
- Respiration saccadée
- Bleuissement des ongles et des lèvres
- Parfois détourner les yeux

mensurá
Learn & Connect

148

1

Sécurité générale

- Retirez les objets avec lesquels la victime pourrait se blesser
- Ne déplacez que si vous ne pouvez pas sécuriser les environs
- Enfilez des gants jetables
- Si nécessaire, allongez la victime sur une surface molle
- Ne mettez rien dans la bouche ou entre les dents
- Ne retenez pas la victime et n'essayez pas de l'arrêter

2

Évaluez l'état de la victime

- Identifiez le problème
- Les secousses sont-elles terminées?
Contrôle de la conscience
Contrôle respiratoire

mensurá-
Learn & Connect

149

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Consultez un médecin, même si la crise a été brève et que la victime se sent bien après coup
- **112?**
 - L'attaque dure plus de 2 minutes
 - Plusieurs crises pendant la même période de fièvre
 - C'est la première agression de la victime
 - Les convulsions sont toujours présentes à l'approche
 - En cas de vomissements, de photophobie, de taches rouges ou violettes sur la peau
 - En cas de doute

mensurá-
Learn & Connect

150

Premiers secours supplémentaires

- Position latérale stable dès que les secousses ont cessé
- Approche de base chaque minute
- Mesurez la température corporelle
- En cas de convulsions fébriles, demandez aux **parents** d'administrer un **antipyrétique** adapté à l'âge de l'enfant
- Le refroidissement physique peut aider à faire baisser rapidement la température corporelle
- Déshabillez la victime et tamponnez-la avec de l'eau tiède
 - Pas d'eau froide ! → Les vaisseaux sanguins se contractent
 - Le corps peut dégager moins de chaleur
- Ne pas donner à manger ni à boire
- Assurez-vous d'être dans un environnement calme

mensurá-
Learn&Connect

151



152

Syncope/Flauwte

= Perte de conscience brève et soudaine résultant d'une diminution de l'apport sanguin au cerveau (manque d'oxygène)

Causes

- Fièvre, fatigue, émotions (par exemple, peur, vue du sang)
- Rester debout longtemps
- Se redresser brusquement après être resté allongé longtemps
- Long bain
- Arrêter brusquement un travail pénible



la victime peut se blesser en tombant!



mensurá-
Learn & Connect

153

Syncope/ Faiblesse

Causes

- Soyez conscient que cela peut également être causé par des problèmes plus graves
- Problèmes cardiaques
- Traumatismes crâniens ou accidents vasculaires cérébraux
- Hémorragies
- Électrification
- Empoisonnement
- Epilepsie
- Difficultés respiratoires
- Hypothermie et hyperthermie
- Déshydratation
- Choc ou piqûre d'insecte



mensurá-
Learn & Connect

154

Syncope/Flaiblesse

Symptômes

- Une victime blanche devient pâle, les victimes à la peau foncée prennent une couleur grisâtre
- Vertiges, taches noires ou étoiles devant les yeux
- Troubles auditifs → Acouphènes, tout semble plus lointain
- La victime se sent faible et parfois nauséuse
- La victime dit avoir chaud et transpirer
- La peau est froide et moite au toucher
- Victime bâillant
- Fourmillements dans les doigts
- Conscience altérée, perte de connaissance et chutes

mensurá-
Learn & Connect

155

1

Sécurité générale

Aidez la victime si vous le pouvez afin d'éviter qu'elle ne se blesse pas :

- 1) Placez-vous derrière la victime, soutenez-la avec vos deux épaules. Écartez légèrement les jambes afin de ne pas perdre l'équilibre.
- 2) Saisissez l'avant-bras de la victime à deux mains
- 3) Passez lentement en position accroupie
- 4) Allongez délicatement la victime au sol

2

Évaluez l'état de la victime

Contrôle de la conscience et de la respiration

mensurá-
Learn & Connect

156

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Si le malaise survient sans cause apparente telle qu'une émotion ou une douleur
- Évanouissements répétés
- En cas de suspicion d'un problème cardiaque
 - La victime est allongée et s'évanouit
 - Lors d'efforts intenses
- Suspicion d'AVC (test FAST)
- Après un coup violent ou un choc à la tête

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- > 2 minutes d'inconscience avec respiration
- En cas de doute

mensurá-
Learn&Connect

157

4

Premiers secours supplémentaires

- Laissez la victime allongée (éventuellement les jambes surélevées)
 - **Conscient** → Placez la victime dans une position confortable
!! Ne pas abandonner en cas de suspicion de traumatisme crânien
 - **Inconscient** → position latérale stable
- Assurez-vous qu'il y ait de l'air frais, les personnes présentes doivent garder leurs distances
- Détacher les vêtements
- Compresses froides ou gant de toilette humide sur le front de la victime
- Laissez la victime **se redresser lentement toute seule**
 - Position semi-assise
 - Se lever prudemment
- Vérifiez si la victime a subi des blessures lors de la chute

mensurá-
Learn&Connect

158

Presyncope

= Fait référence aux symptômes ressentis par une personne avant de s'évanouir

Symptômes

- Se sentir léger dans la tête
- Nausées
- Transpiration
- Voir des taches noires devant les yeux
- Sensation imminente de perte de conscience



mensurà
Learn & Connect

159

Presyncope

Prévention des évanouissements

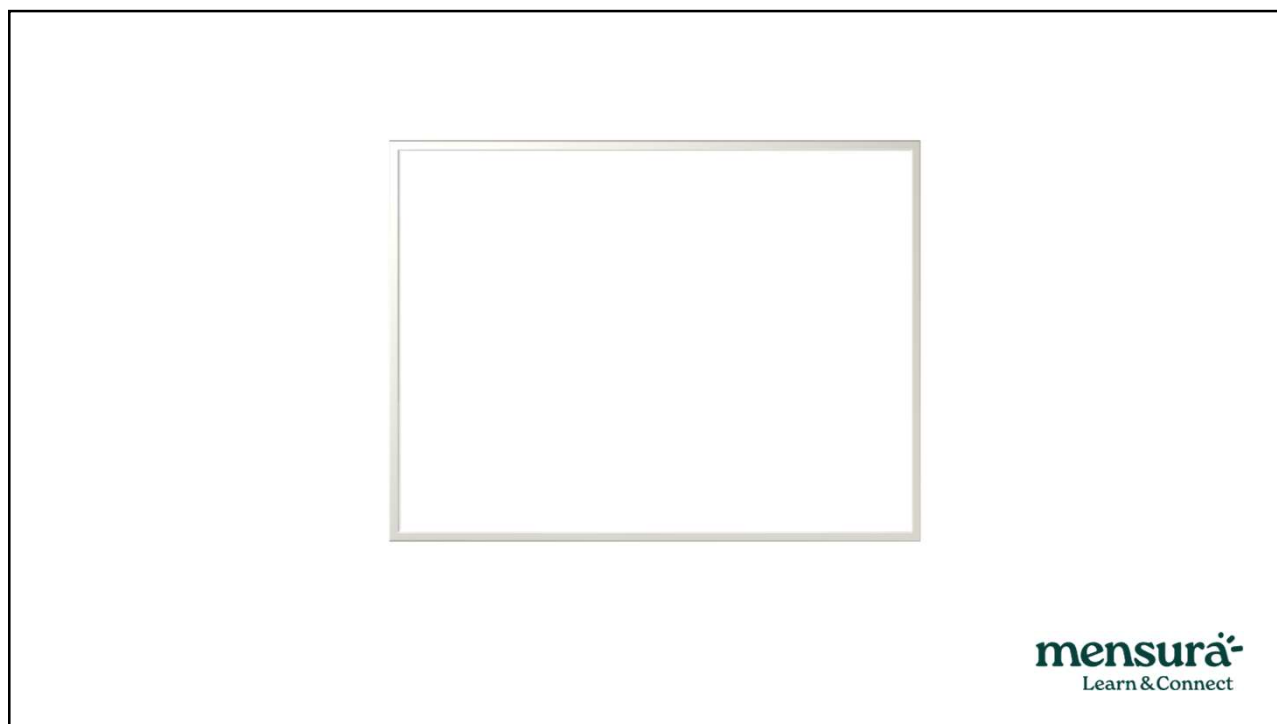
Vous vous sentez faible ? → Allongez-vous / Asseyez-vous

Manœuvres physiques de contre-pression :

- S'accroupir avec ou sans croiser les jambes
- Serrez le poing ou prenez un objet et serrez-le longtemps
- Placez votre menton sur votre poitrine et contractez les muscles de votre cou

mensurà
Learn & Connect

160



161



162

Accident vasculaire cérébral (AVC)

= Terme générique désignant différentes affections dans lesquelles une partie du cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang (pas assez d'oxygène)

Hémorragie cérébrale

= un saignement dans le cerveau

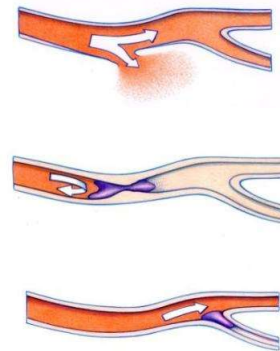
→ Spontané, problème de coagulation, choc à la tête, anévrisme

Thrombose cérébrale

= Obstruction causée par un caillot sanguin (thrombose) qui se forme dans un vaisseau sanguin du cerveau ou qui s'y loge

Embolie cérébrale

= Obstruction d'un vaisseau sanguin dans le cerveau par un caillot (embolie) provenant d'une autre partie du corps



mensura
Learn & Connect

163

Accident vasculaire cérébral

Causes

Les accidents vasculaires cérébraux peuvent avoir les mêmes causes que le

Conjonction de facteurs de risque

- Hypertension artérielle, diabète, surpoids
- Mauvaises habitudes de vie → Tabagisme, alimentation grasse, manque d'activité physique

AIT = Accident ischémique transitoire

= Symptômes d'accident vasculaire cérébral, mais de nature transitoire (quelques minutes à quelques heures)

→ **Signal d'alarme!** Le AIT est souvent un signe avant-coureur d'un AVC

mensura
Learn & Connect



164

Accident vasculaire cérébral

Dangers

Risque de lésions cérébrales :

- Manque de sang = manque d'oxygène et de sucre
- **La rapidité de l'aide spécialisée est déterminante pour prévenir ou limiter les dommages permanents!** → À l'hôpital le plus vite possible ! → Unité de soins spécialisée dans les AVC

Obstruction respiratoire :

- Faiblesse musculaire → difficulté à avaler
- En cas d'inconscience
- En cas de nausées

mensurà-
Learn & Connect

165

Accident vasculaire cérébral

Symptômes → Soudain, en fonction de la localisation et de la taille de la partie du cerveau affectée

- Parfois, perte de conscience, somnolence, confusion, absence, agitation, nervosité
- Parole lente ou incohérente
- Démarche étourdie, instable ou d'ivrogne
- Maux de tête et nausées
- Vision perturbée
- Bouche déformée, difficulté à parler, difficulté à avaler
- Faiblesse musculaire ou paralysie d'un côté

→ Ces caractéristiques ne se manifestent pas toujours simultanément



mensurà-
Learn & Connect

166

Accident vasculaire cérébral - Le test

FAST

Visage (Face)



Discours (Speech)



Bras (Arm)



Temps (Time)



mensurà
Learn & Connect

167

1

Sécurité générale

- Veillez à ce que la victime ne tombe pas et ne se blesse pas davantage
- Si nécessaire, placez la victime au sol

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Test FAST

mensurà
Learn & Connect

168

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Alertez le 112 et précisez l'heure
- Seul → alertez vous-même, sinon → passant
- Veuillez mentionner « AVC » et l'état de la victime...

4

Premiers secours supplémentaires

- Vérifiez les fonctions vitales
- Effectuez une réanimation si nécessaire
- Contrôlez régulièrement les signes vitaux
- Appliquez les règles de base des premiers secours

mensura⁺
Learn & Connect

169



170

Lésion cérébrale ou commotion cérébrale

Lésion cérébrale

= Perturbation **permanente** du cerveau

- Menace mortelle!
- Les conséquences possibles peuvent inclure la paralysie ou la mort

Commotion cérébrale

= Perturbation **temporaire** des fonctions cérébrales, sans dommage permanent grave

- Il est difficile pour un secouriste de déterminer les dégâts avec certitude
- Les symptômes dépendent de la localisation et de la taille de la partie du cerveau touchée.

mensurà
Learn & Connect

171

Lésion cérébrale ou commotion cérébrale

Traumatisme crânien → Hémorragie possible dans ou autour du cerveau

Un saignement se produit:

- Aigu → Immédiatement après l'accident
- Subaigu → Se déroule jusqu'à une semaine après l'accident
- Chronique → Se déroule sur une période de 2 à 3 semaines

mensurà
Learn & Connect

172

Lésion cérébrale ou commotion cérébrale

Symptômes

- Mal de tête
- Nausées et vomissements
- Sensible à la lumière et/ou au son
- Mouvements saccadés, position tendue et tordue des bras ou des jambes
- Symptômes de paralysie des membres
- Problèmes croissants de marche
- Troubles de la parole
- Crises d'épilepsie
- Confusion ou changements de comportement
- Troubles de la conscience, somnolence, somnolence

mensurá-
Learn&Connect

173

1

Sécurité générale

- Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains, portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Qu'est-ce qui s'est passé?
- Contrôle de la conscience et de la respiration

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- La victime ne se sent pas bien
- Inconscience, diminution de la conscience ou perte de conscience transitoire
- Lorsqu'une force violente a agi sur la tête de la victime
- Soupçons de:
 - Fracture du crâne
 - Fracture faciale
 - Lésion(s) vertébrale(s)

mensurá-
Learn&Connect

174

Premiers secours supplémentaires

Conscient et respire normalement

- Laissez la victime se reposer
- Calmez la victime et convainquez-la de rester dans la même position
- Demandez à la victime de bouger la tête le moins possible
- L'immobilisation de la tête n'est nécessaire que si la victime est incapable de rester immobile
- Traitez une possible blessure à la tête (2 secouristes)
- Surveillez attentivement la victime et ne la laissez pas seule pendant les premières 24 heures

Inconscient mais respire normalement

- Allongez la victime sur le dos
- La victime a-t-elle des difficultés à respirer?
 - Inclinaison de la tête et soulèvement du menton (doucement)
- Si la victime est presque en position latérale stable, laissez-la simplement ainsi
- Continuez à observer la victime
- Arrêt respiratoire = réanimation

mensurá
Learn & Connect

175



176

Empoisonnement

Substances toxiques

Solide:

- Médicaments, drogues, plantes toxiques, pesticides en granulés...

Liquide:

- Eau de javel et produits de nettoyage, déboucheurs de canalisations, ...

Gaz:

- Gaz d'échappement, gaz butane ou propane...



mensurá
Learn & Connect

177

Empoisonnement

Voies d'entrée

- Avaler
- Inhaler
- Injecter
- Toucher



→ Le produit toxique entre en contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux

mensurá
Learn & Connect

178

Empoisonnement

- Fréquent chez les enfants
- Souvent dans les tentatives de suicide
- Les fonctions vitales sont gravement perturbées
- On sous-estime souvent sa gravité
 - ➔ L'aide spécialisée a été appelée trop tard
- Pensez à votre propre sécurité ! (gaz, aérosols)



mensurà-
Learn & Connect

179

Empoisonnement

Voici quelques exemples et symptômes pouvant indiquer un empoisonnement:

- Emballages vides de médicaments
- Pièces mal ventilées avec un appareil de chauffage allumé ou un moteur en marche
- Sites d'injection
- Crampes abdominales, vomissements ou nausées
- Peau pâle ou bleue



mensurà-
Learn & Connect

180

Intoxication au CO

Intoxication CO

Symptômes:

- Nausée
- Mal de tête



Conséquences:

- La conscience diminue
- Arrêt respiratoire et cardiaque



Que faire:

- Ventiler
- Vérifier les fonctions vitales
- Alerte

mensurà
Learn & Connect

181

1

Sécurité générale

- N'entrez jamais dans une zone contenant des gaz ou des fumées toxiques
- Portez des gants en cas d'intoxication par des substances pulvérisées
- Coupez le moteur et aérez la pièce
- Évacuer la victime à l'air frais (rautek) avant de vérifier ses fonctions vitales

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience, peut-être : éveillé → somnolent → après le toucher
- Contrôle de la respiration

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Lorsque les fonctions vitales ne fonctionnent pas correctement
- En cas de suspicion d'empoisonnement



mensurà
Learn & Connect

182

Premiers secours supplémentaires

- **Ne faites pas vomir** la victime
(uniquement sur les conseils d'un centre antipoison ou du 112)
- **Ne laissez pas** la victime **boire**
(uniquement sur les conseils d'un centre antipoison ou du 112)
- victime **inconsciente** – **respire?**
→ Position latérale stable
- La victime est **inconsciente** et **ne respire plus?**
→ Réanimation → Aérer uniquement si sûre
- Utilisez un DEA disponible



Coup de chaleur vs. insolation

Régulation thermique perturbée (production de chaleur > dégagement de chaleur) ?

→ Température corporelle ↑

- **Coup de chaleur**

- Victime souffrant de problèmes liés à la chaleur peut développer un coup de chaleur
→ Danger de mort!

- **Insolation**

- Perturbation de l'équilibre thermique due au rayonnement direct sur la tête

Température corporelle normale : 36,5 °C – 37,5 °C

= Équilibre entre la chaleur produite et celle restituée

→ **Débit thermique:**

Par augmentation circulation sanguine au niveau de la peau

→ Peau rouge et chaude

Par la transpiration

→ Évaporation de la sueur = Chaleur évacuée du corps

mensurà
Learn & Connect

185

Insolation

Comment notre corps réagit-il?

Symptômes

- Soif
- Mal de tête, nausée
- Vomissement
- Rougeurs et peau sèche
- Rythme cardiaque rapide
- Crampes musculaires

Premiers secours

- Éloignez la victime du soleil
- Déplacez-la dans un endroit frais, retirez ses vêtements chauds
- Compresses froides sur le front
- Si nécessaire, prenez une boisson fraîche
- Si nécessaire, consultez un médecin ; appelez le 112 si elle perd connaissance



mensurà
Learn & Connect

186

Coup de chaleur léger

Efforts physiques intenses dans un environnement où la température et l'humidité sont **supérieures** à la normale

Symptômes:

- Maux de tête, vertiges
- Transpiration excessive et soif
- Peau fraîche, pâle et moite
- Rythme cardiaque et respiration rapides

mensurà
Learn & Connect

187

Coup de chaleur grave

Symptômes:

- La personne a cessé de transpirer (en raison d'une faible consommation de boisson et de l'évaporation de la transpiration)
- Température corporelle élevée supérieure à 40°C
- Peau sèche, rouge et chaude
- Nausées, vomissements → Incapacité à boire
- Être confus
- Troubles de la conscience
- Convulsions

mensurà
Learn & Connect

188

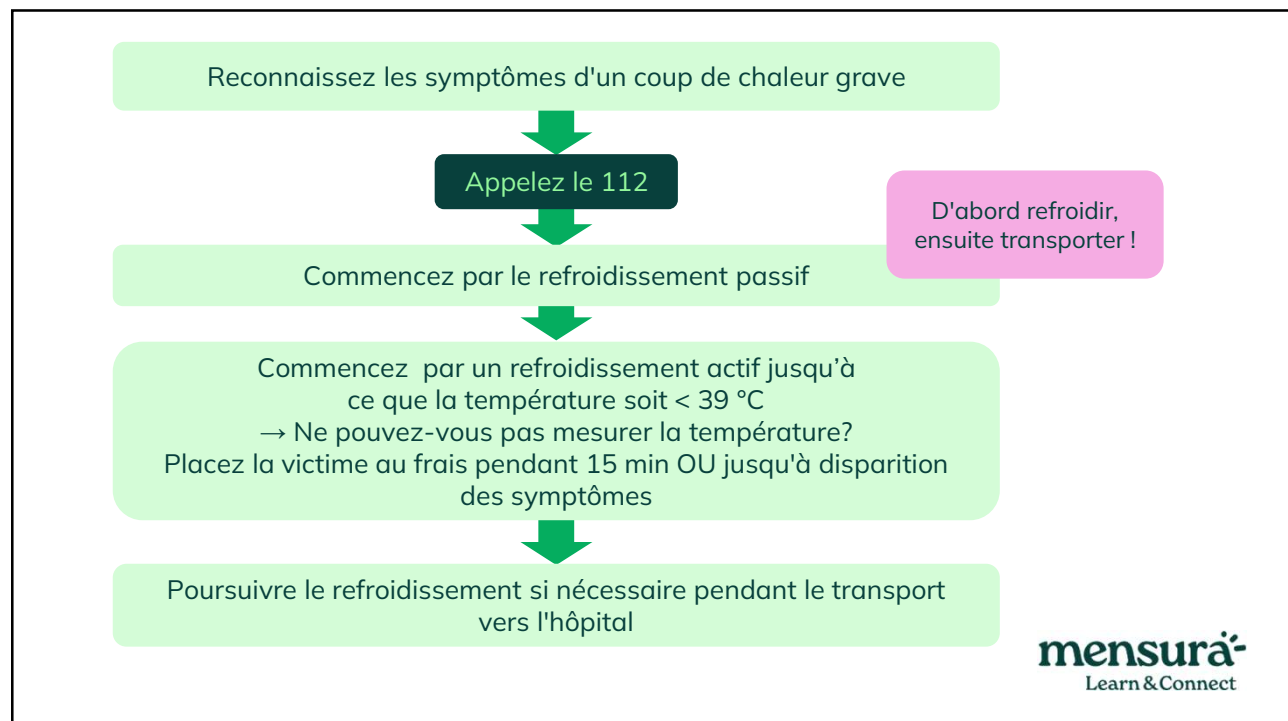
Coup de chaleur grave

→ Besoin d'aide spécialisée

- Température corporelle centrale **supérieure à 40°C?**
 - **Refroidissement passif:** Déplacez la victime dans un endroit plus frais, retirez les vêtements chauds, mesurez sa température centrale
 - **Refroidissement actif:** Refroidir la victime → **Refroidissement progressif!**
 - Dirigez le ventilateur vers la victime
 - Placez des glaçons dans un sac d'eau, des sacs réfrigérants ou des linges humides et froids sur le corps (aine, aisselles et cou)
 - Aspergez/versez la victime d'eau froide
 - Plongez les mains et les pieds de la victime dans l'eau froide
 - Immergez la victime dans une baignoire remplie d'eau tiède à froide (1 à 26 degrés)

mensura
Learn & Connect

189



190

- 1 **Sécurité générale**
 - Veillez à éviter les insolationes et les coups de chaleur
- 2 **Évaluez l'état de la victime**
 - Contrôle de la conscience, possible: éveillé → somnolent → après le toucher
 - Contrôle de la respiration
- 3 **Consultez un spécialiste 112, médecin**
 - Lorsque les fonctions vitales ne fonctionnent pas correctement
- 4 **Premiers secours supplémentaires**
 - À moitié assis par terre
 - Vérifier les fonctions vitales
 - Refroidissez la victime (à l'aîne, sous l'aisselle ou dans le cou)
 - Mettez-la à l'ombre et donnez-lui à boire

mensurà
Learn & Connect

191

Hypothermie

Pertes de chaleur > Chaleur produite → Température corporelle ↓

Conséquence: Hypothermie < 35°C

Normalement, dans un environnement **froid**, la **production de chaleur augmente** et le rendement thermique est limité.

- Frissons
 - Vaisseaux sanguins contractés
 - Chair de poule.
- Frissons incontrôlables
Confus, somnolent
Diminution de conscience
- Engelures de parties du corps

!! L'humidité, le vent et l'alcool accélèrent la détérioration de l'état

mensurà
Learn & Connect

192

Hypothermie

- Hypothermie légère (35°C – 32°C)
- Hypothermie modérée (32°C – 28°C)
- Hypothermie grave (< 28°C)



Symptômes

- Tremblements incontrôlables et claquements de dents
→ L'arrêt est progressif si l'hypothermie persiste
- Peau froide, pâle et sèche → Lèvres, oreilles, doigts et orteils bleus
- Respiration rapide → superficielle
- La victime a des difficultés à bouger et à parler → Les muscles se raidissent
- Confusion, somnolence, pertes de mémoire, fatigue
- Perte de conscience

mensurá-
Learn & Connect

193

1

Sécurité générale

- Évitez les mouvements brusques et saccadés de la victime
→ Risque d'arythmies cardiaques → Placez la victime en hypothermie horizontalement

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience, possible: éveillé → somnolent → après le toucher
- Contrôle de la respiration

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Lorsque les fonctions vitales sont menacées

mensurá-
Learn & Connect

194

4

Premiers secours supplémentaires

- Déménager dans un environnement plus chaud
- Retirer les vêtements mouillés
 - Par exemple, ceux d'une personne qui se noie, p ex, les détacher
 - Séchez la victime et couvrez-la chaudement
- Mesurer la température corporelle
- **Ne pas** frictionner!
- Lésions de la peau et des muscles sous-jacents

mensurà-
Learn&Connect

195

4

Premiers secours supplémentaires

- La victime tremble et est conscient?
 - **Réchauffement progressif!**

→ **OUI** = **Réchauffement passif**

- - Réchauffez-vous dans un sac de couchage/une couverture en duvet ou en polaire (en combinaison avec une couverture isolante). → Couvrez également la tête de la victime!
- - Vêtements chauds et secs
- - Boissons chaudes et sucrées et/ou aliments à une victime consciente (p ex du lait au chocolat)

→ **NON** = **Grave** = la victime ne peut pas se réchauffer → **Réchauffement actif**

- Couverture chauffante, oreiller en noyau de cerise, compresses chaudes, bouillotte (avec linge)
- Réanimation d'une personne inconsciente qui ne respire pas

mensurà-
Learn&Connect

196

Gelure

= La peau et les tissus sous-jacents sont endommagés par les gelures

- Rougeurs cutanées → Taches, coloration bleutée
- Ampoules remplies de liquide foncé
- Décoloration blanche de la peau → Noire → Peau morte et relâchée
- Picotements, sensation de brûlure → Douleur intense
- Engourdissement d'une partie du corps gelée



mensurà-
Learn & Connect

197

1

Sécurité générale

- Gants

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience, possible: éveillé → somnolent → après toucher
- Contrôle de la respiration

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Lorsque les fonctions vitales ne fonctionnent pas correctement

4

Premiers secours supplémentaires

- Retirez les bagues et les bijoux sans abîmer la peau
- Réchauffez progressivement la partie du corps affectée
→ Mains sous les aisselles, ne pas frotter, couvrir les engelures

mensurà-
Learn & Connect

198

Déshydratation

= La victime perd plus de liquide qu'elle n'en absorbe
→ Perte d'humidité, de sels et d'autres nutriments

Causes: diarrhée/vomissements sévères, transpiration abondante, consommation excessive d'alcool, effort physique intense, fièvre, ...

Symptômes:

- Victime faible et fatiguée
- Mal de tête, vertiges ou nausées
- Diminution du niveau de conscience
- Yeux enfoncés
- Bouche sèche, soif fréquente
- Urine peu abondante → Urine foncée et à forte odeur

mensurà
Learn & Connect

199

Déshydratation

Que faites-vous?

Permettre à la victime de boire régulièrement de petites quantités

- Cas moins graves → Eau, boisson pour sportifs, thé
- Déshydratation due à l'effort? → Boisson pour sportifs, lait écrémé
- Cas graves? → Solution de réhydratation orale (SRO) prête à l'emploi

Évitez de consommer des boissons alcoolisées

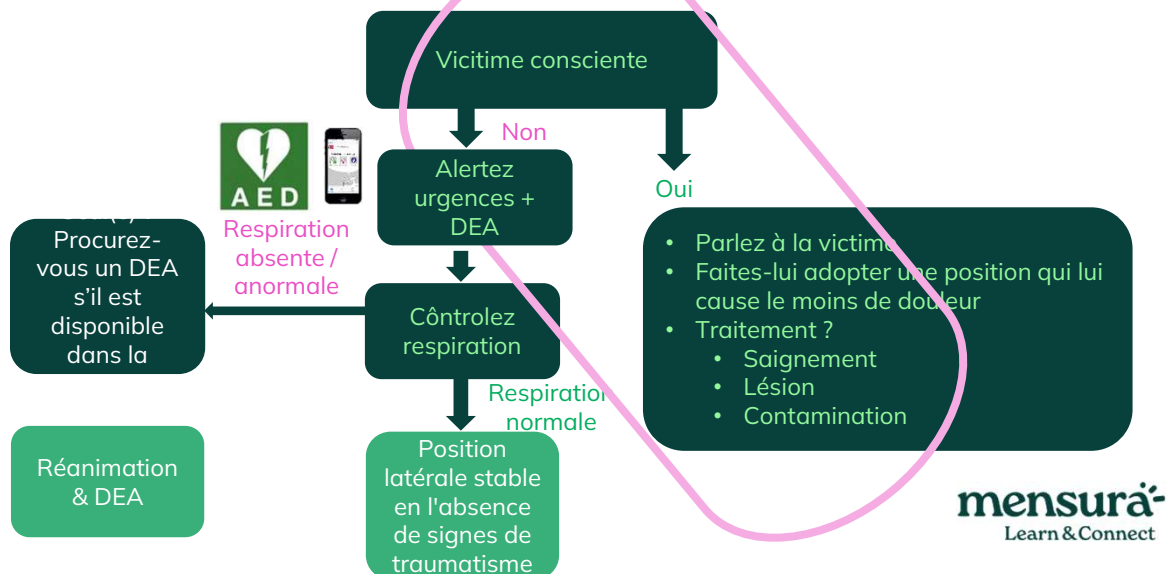
Alertez les urgences si:

- La personne est ou devient inconsciente
- La personne présente des signes de coup de chaleur

mensurà
Learn & Connect

200

Organigramme approche

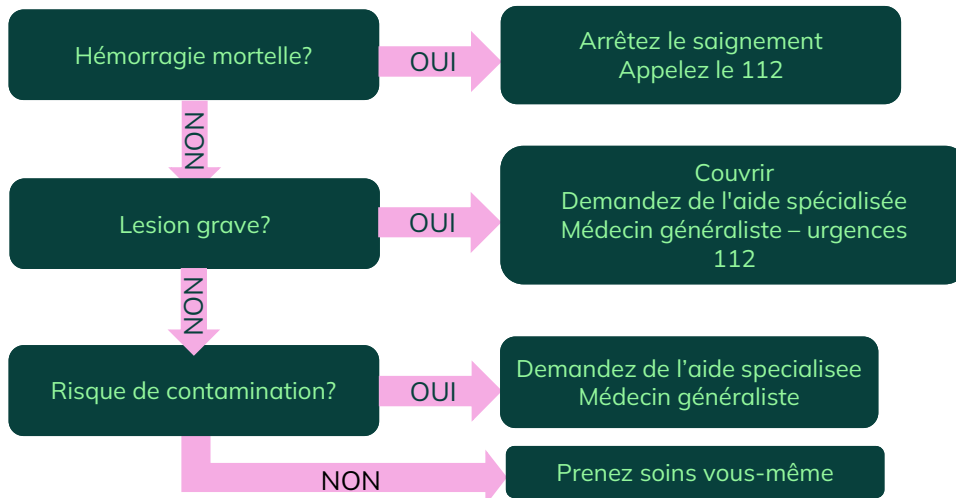


201



202

Comment faire?



mensurà
Learn & Connect

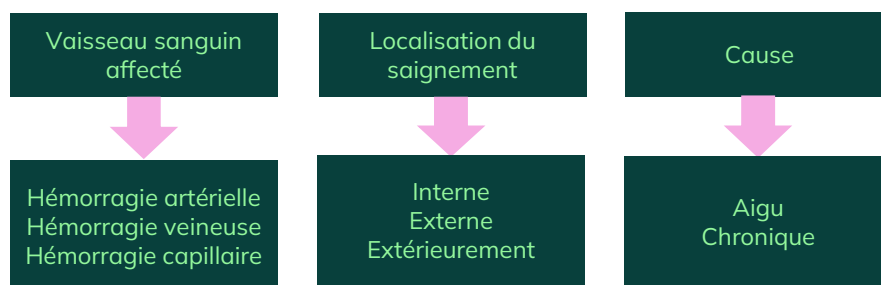
203

Qu'est-ce qu'un saignement et quels sont les différents types?

Saignement = Sang libéré après lésion d'un ou plusieurs vaisseaux sanguins par:

- Un objet
- Impact / retard
- Se fissure tout seul

→ Classification des saignements selon le type et la localisation des vaisseaux sanguins,

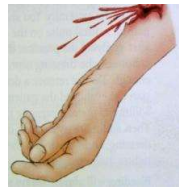
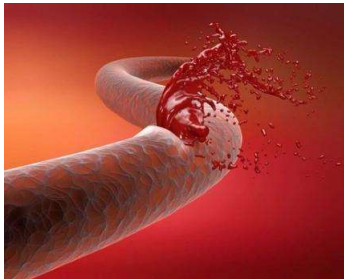


mensurà
Learn & Connect

204

Vaisseaux sanguins : artériel / saignement artériel

- Se produit à la suite d'un traumatisme
- Provoque une hémorragie abondante et pulsatile
- Couleur rouge vif → Sang riche en oxygène



mensurà
Learn & Connect

205

Vaisseaux sanguins : saignement veineux

- Se couper avec un objet tranchant
- Il y a (beaucoup) de sang, mais il s'écoule de la plaie.
- De couleur plutôt foncée → Sang pauvre en O₂



mensurà
Learn & Connect

206

Vaisseaux sanguins : saignement capillaire

- Un saignement capillaire survient lorsqu'il y a lésion des capillaires
- Petites hémorragies ponctuelles
- Ces saignements s'arrêtent souvent spontanément
- Par exemple l'abrasion



mensurà
Learn & Connect

207

Hémorragie interne

= Le sang reste à l'intérieur du corps

Faites attention à: Cerveau – thorax – abdomen – fractures – contusion



RISQUE DE CHOC: Diminution de la vigilance, confusion, peau froide et marbrée, augmentation de la respiration, accélération du rythme cardiaque



Souvent remarqué trop tard

mensurà
Learn & Connect

208

Hémorragie externe

= Lésion de la surface corporelle

Faites attention à: Coupures - Fractures

RISQUE DE CHOC: Diminution de la vigilance, confusion, peau froide et marbrée, augmentation de la respiration, accélération du rythme cardiaque



En cas de perte de sang importante, environ 25 à 30 % de son volume sanguin total

mensurà
Learn & Connect

209

Hémorragie externe

= Le sang est produit à l'intérieur du corps, mais il s'évacue par un orifice naturel

bouche – nez – oreille – œil – anus – vagin ou pénis

Indique souvent un traumatisme très grave



mensurà
Learn & Connect

210

Quand une hémorragie met-elle la vie en danger?

- Hémorragie des organes vitaux
- Lésions des gros vaisseaux sanguins
- Si l'hémorragie n'est pas maîtrisée, la victime entrera en **CHOC HYPOVOLEMIQUE**



mensura
Learn & Connect

211

Hémorragie potentiellement mortelle



Contrôler une hémorragie potentiellement mortelle:

- **Demandez à la victime d'appuyer immédiatement** sur la zone qui saigne et guidez la victime au sol
- Appliquez **une pression manuelle directe** pendant **10 minutes**
 - ➔ Main gantée, bandage de gaze
- Maintenez le membre surélevé si possible
- Application d'un pansement hémostatique directement sur la plaie, associée à une pression manuelle sur le pansement
- **Après 10 minutes** ➔ **Bandage compressif**: Utile pour maintenir l'hémostase (processus naturel d'arrêt du saignement) une fois le saignement maîtrisé (ne pas utiliser comme substitut à une pression manuelle directe en cas de saignement incontrôlé)

Non recommandé: utilisation de points de pression, de garrots de fortune ou de la thérapie par le froid.

mensura
Learn & Connect

212

Hémorragie potentiellement mortelle : garrot

En cas d'hémorragie mettant la vie en danger dans les membres
p ex, bras, jambe, amputation traumatique

En principe, nous n'utilisons pas de garrot.

Exceptions:

- si le saignement ne peut être arrêté par une pression manuelle directe et que le **secouriste est formé** à l'utilisation d'un garrot
 - En tout dernier recours
 - Ecrasé > 10 min
 - Hémorragie artérielle extrême
 - Plusieurs victimes

➔ Demander conseil au 112 peut vous aider à décider si vous devez finalement utiliser un garrot



mensurà
Learn & Connect

213

Utiliser un garrot

- Placez le garrot autour du membre blessé, **5 à 7 cm au-dessus de la blessure**, mais **pas au niveau d'une articulation**, de préférence sur le bras ou la cuisse.
- Serrez le garrot **jusqu'à ce que le saignement ralentisse et s'arrête**.
Cela peut être très douloureux pour la victime.
- Maintenir la pression du garrot.
- Notez l'heure à laquelle le garrot a été appliqué.
- Ne **desserrez pas** le garrot – seul un secouriste qualifié doit le desserrer.
- Appelez immédiatement le **112** pour obtenir des soins médicaux supplémentaires..
- Dans certains cas, il peut être nécessaire d'appliquer deux garrots en parallèle pour ralentir ou arrêter l'hémorragie.

mensurà
Learn & Connect

214

1

Sécurité

- Faites allonger la victime
- Reconnaître les symptômes de choc
- Portez des gants, faites attention à ne pas vous blesser

2

Évaluer l'état de la victime

- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Évaluer le saignement

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- En cas d'hémorragie massive
- Si vous estimez que le saignement sera difficile à contrôler
- Si la victime prend des anticoagulants
- ...

4

Premiers secours supplémentaires

- En cas de saignement : appliquer une pression directe pendant 10 minutes (par exemple avec la main de la victime) et appliquer un bandage compressif
- En cas de lésion : stopper la lésion, appliquer un pansement temporaire ou un bandage compressif
- En cas de contamination : nettoyer, désinfecter, couvrir (temporairement)
- Continuez à observer la victime, (ré)utilisez le plan en 4 étapes



215



216

Amputation

= (Une partie d'un) membre est arrachée ou coupée

- Amputation **complète**
= Un membre (ou une partie d'un membre) est **complètement** arraché/coupé
- Amputation **partielle**
= Un membre (ou une partie d'un membre) a été **partiellement** arraché/coupé



mensurà-
Learn & Connect

217

1

Sécurité générale

- Demandez à la victime d'appuyer sur/autour de la plaie
- Utilisez des gants jetables
- Aidez la victime à s'allonger
- Demandez à ce que le membre partiellement amputé reste aussi immobile que possible

2

Évaluez l'état de la victime

- Ce qui s'est-il passé?
- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Calmez la victime si nécessaire

mensurà-
Learn & Connect

218

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Appelez ou demandez à quelqu'un d'appeler

4

Premiers secours supplémentaires

- Pression directe sur et autour de la plaie → 10 minutes
- Après 10' ? → Bandage compressif
- Si une hémorragie importante ne peut être arrêtée par une pression directe, un garrot peut être nécessaire

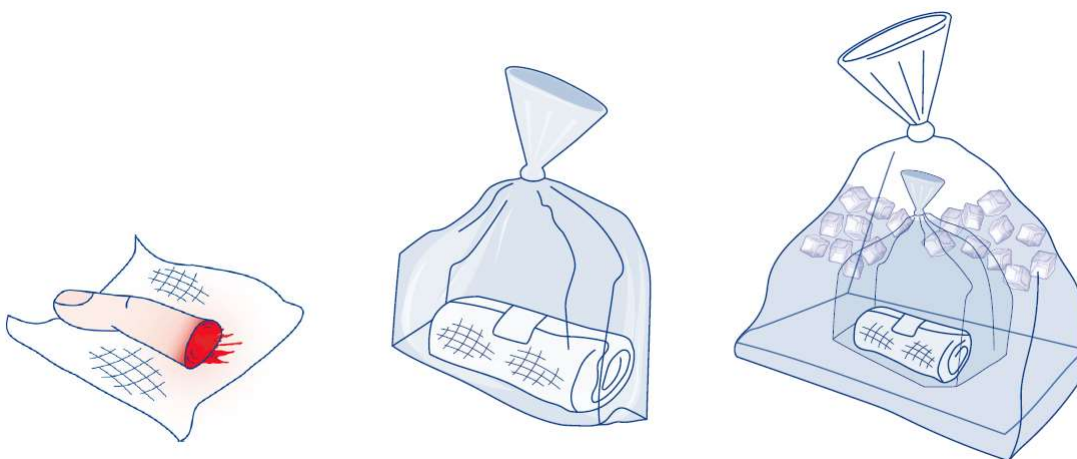
Pour les **ambulanciers/médecins/infirmières**

Recherche, emballage du membre:

- Enveloppez le membre dans une compresse stérile et placez-le dans un sac, puis fermez-le.
- Placez-le dans un deuxième sac avec de la glace et fermez-le hermétiquement.

mensurá
Learn & Connect

219



mensurá
Learn & Connect

220



221

Bandages

Techniques bandages

À quoi servent les bandages?

- Arrêter le saignement
- Couverture temporaire des lésions
- Prévention d la contamination
- Pour apporter un soutien



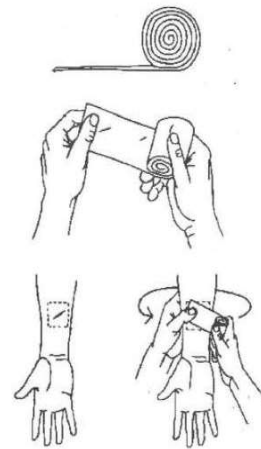
mensurà
Learn & Connect

222

Bandages

Techniques bandages

- Largeur correcte
- Installez la victime dans une position confortable, assise ou allongée
- Tenez le bandage de façon à ce que le **rouleau soit orienté vers le haut**
 - Rouleau dans la main dominante
 - Et la fin dans l'autre main
- Travaillez toujours de la plaie vers le torse
- Placez le premier enroulement à un angle léger
- Après le premier tour, repliez un coin du bandage



mensurá
Learn & Connect

223

Arrêter le saignement : bandages compressifs



mensurá
Learn & Connect

224



225

Saignements – lésions - infections

- Lésions vertébrales
- Fractures - Contusions - Entorses – Luxations
- Commotion cérébrale
- Lésions musculaires

mensurà
Learn & Connect

226

Suspicion de lésion(s) vertébrale(s)

Fracture ou luxation d'une ou plusieurs vertèbres, lésion ligamentaire

Dans le cou, le dos ou le bassin

Risque de **lésions de la moelle épinière et/ou des nerfs**

→ **Lésion médullaire** = Paralysie sous le niveau de la lésion médullaire

- Au niveau du cou → Grande partie du corps paralysée / Arrêt respiratoire
- Au niveau de la poitrine ou du dos → Paralysie du bas du corps

Accident de la circulation, accident de plongée en eaux peu profondes, blessure grave à la tête, ...

mensurà-
Learn & Connect

227

Lésions à la tête et aux vertèbres

Que pouvez-vous observer ?

- La victime souffre de troubles émotionnels ou de symptômes de paralysie
- Douleurs dans la nuque, le cou, le dos ou l'arrière du bassin
- La victime est ou devient somnolente, agitée, agitée ou inconsciente
- Ne se souvient plus exactement de ce qui s'est passé
- Souffre de graves blessures à la tête
- Souffre de maux de tête persistants et sévères, a des nausées ou commence à vomir, est très irritable, se comporte de manière étrange ou a des convulsions



mensurà-
Learn & Connect

228



Sécurité générale

- Gants



Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience et de la respiration
 - Victime sur le **ventre**?
 - → Tourner la victime comme un tout sur le dos (aux 2 secouristes)
Cou aligné avec le corps
- Calmez la victime si nécessaire

mensurà
Learn & Connect

229



Consultez un spécialiste 112, médecin

- Appelez ou faites appeler les secours



Premiers secours supplémentaires

- Demandez à la victime consciente de bouger le moins possible.
- Immobilisez la tête de la victime si nécessaire
- Victime inconsciente : vérifiez les fonctions vitales

mensurà
Learn & Connect

230

Techniques en cas de lésions à la tête ou à la colonne vertébrale

Immobilisation du cou si la victime est inconsciente ou ne coopère pas correctement.

Si la personne ne réagit pas et est allongée sur le dos ?

Méthode: maintien de la tête

1. Agenouillez-vous derrière la tête de la victime
2. Saisissez la tête de la victime des deux côtés avec vos deux mains
→ Sans bouger la tête victime !
→ Ne couvrez pas les oreilles : Pouce au-dessus de l'oreille et autres doigts sous l'oreille
3. Appuyez-vous avec vos mains sur vos cuisses



mensurà-
Learn & Connect

231

Techniques en cas de lésions à la tête ou à la colonne vertébrale

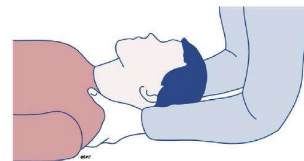
Immobilisation du cou si la victime est inconsciente ou ne coopère pas correctement.

Si la personne ne réagit pas et est allongée sur le dos ?

Méthode: Variation stabilisation manuelle

Méthode de compression du trapèze

- Prise ferme sur les muscles supérieurs des épaules
- Stabiliser la tête entre les avant-bras



mensurà-
Learn & Connect

232

Techniques en cas de lésions à la tête ou à la colonne vertébrale

Immobilisation du cou si la victime a des difficultés à respirer

Si la personne ne réagit pas avec une blessure au cou ou au dos

Méthode: technique jaw-thrust

Objectif

Ouverture des voies respiratoires lorsque l'hyperextension de la tête + le soulèvement du menton ne sont pas possibles

Étapes

1. Agenouillez-vous derrière la tête de la victime → Appuyez vos avant-bras sur vos genoux
2. Saisissez la tête de la victime des deux côtés avec vos mains, en laissant les oreilles libres
3. Placez vos index derrière l'angle de la mâchoire
4. Poussez légèrement vos doigts vers le haut pour dégager les voies respiratoires (sans incliner la tête !)

mensurá
Learn & Connect

233

Fracture – Contusion – Entorse – Luxation

En tant que secouriste, il n'est pas toujours évident de reconnaître le type de lésion.

	Fracture	Contusion	Entorse	Luxation
Douleur	X	X	X	X
Gonflement	X	X	X	X
Coloration bleue	X	X	X	X
Mobilité anormale	X	X	X	X
Position anormale	X	-	-	X
Craquement osseux	X	-	-	-

mensurá
Learn & Connect

234

JM1 Nieuw toegevoegde slide 6/11.
Moerman Joséphine; 2025-11-06T13:14:49.419

Fractures

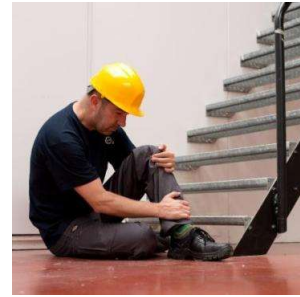
= Fracture totale ou partielle d'un os

Synoniem: Fracture = os « cassé »

Cause:

- Par impact direct ou indirect
- Par choc électrique
- En raison d'une surcharge ou de certaines maladies

Il y a des fractures ouvertes ou fermées.



mensurà-
Learn & Connect

235

Fractures

Fracture fermée = Aucune blessure à l'endroit de la fractur

- Immobilisation (articulation au-dessus et au-dessous de la fracture)
- Couverture, support, pull-over, chemise, tissu, planche
- Soyez créatif



N'essayez JAMAIS de replacer un os fracturé



Fracture ouverte = **Plaie** au niveau de la fracture

→ Présence visible de sang et/ou d'os cassés

- Arrêtez prudemment une hémorragie sévère
- Couvrez la plaie avec des bandages ou des compresses stériles
- Immobilisation



mensurà-
Learn & Connect

236

1

Sécurité générale

- Conseillez à la victime de ne pas bouger le membre affecté
 - Maintenez le membre supérieur immobile contre la poitrine
 - Ne pas laisser appuyer sur le membre inférieur douloureux
- Gants jetables en cas de fracture ouverte
- Bougez le membre le moins possible pendant que vous intervenez
- Ne jamais réduire l'articulation ou le membre qui est en position anormale

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?
- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Calmez la victime si nécessaire
- Comparez avec l'autre côté pour voir s'il y a des déviations.
- Ne vérifiez JAMAIS la mobilité !

mensurà
Learn & Connect

237

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Le gonflement est très prononcé
- Position anormale du membre
- Mobilité ou immobilité anormale
- Troubles sensoriels
- La victime peut encore se déplacer

mensurà
Learn & Connect

238

4

Consultez un spécialiste 112, médecin

- La victime ne peut plus se déplacer
- Une immobilisation est souvent nécessaire
- En cas de doute



mensurá-
Learn & Connect

239

4

Premiers secours supplémentaires

Fracture ouverte

- Arrêtez l'hémorragie (qui peut être grave)
 - Compression directe
- Fracture osseuse des membres supérieurs
 - Enlevez les bagues et les bijoux
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
- Couvrez avec une compresse stérile
 - Humidifiez la compresse avec de l'eau ou une solution désinfectante incolore.
- N'utilisez pas de glace

Fracture fermée

- Fracture osseuse du membre supérieur
 - Enlevez les bagues et les bijoux
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
- Une écharpe est appropriée si la victime le permet.
 - Diminue la douleur
- Appliquez de la glace sur la plaie pour refroidir
 - Soulage la douleur
 - Préviend le gonflement

mensurá-
Learn & Connect

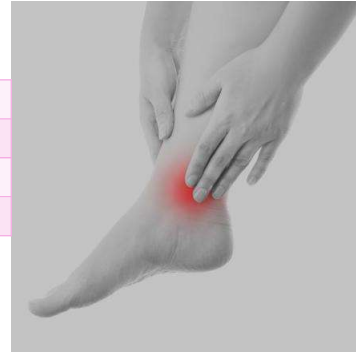
240

Contusions

Lésion du tissu sous-cutané

- Chute
- Coup
- Choc
- Compression

Douleur
Gonflement
Coloration bleue
Mobilité anormale



mensurà
Learn & Connect

241

1

Sécurité générale

- Conseillez à la victime de bouger le membre affecté le moins possible.
 - Maintenez le membre supérieur immobile contre la poitrine.
 - Ne pas laisser appuyer sur un membre inférieur douloureux.

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Le gonflement est très prononcé
- Position anormale du membre
- Mobilité ou immobilité anormale
- Troubles sensoriels

mensurà
Learn & Connect

242

Premiers secours supplémentaires

- Retirez les bagues et les bijoux en cas de contusion des membres supérieurs
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
- Eventuellement membre supérieur surélevé
- Refroidissez avec de la glace sur la plaie
 - Soulage la douleur
 - Prévient le gonflement
- Interrompez le refroidissement si cela provoque des douleurs plus importantes
- L'application d'un bandage peut augmenter le confort pour la victime.

Entorse

Souvent appelé **élongation** ou **foulure**

Cause

Sport, mauvaise réception après un saut

Quoi

Déplacement des extrémités des articulations l'une par rapport à l'autre

→ La capacité de mouvement est dépassée

Conséquence?

- Les ligaments sont étirés, parfois ils sont déchirés
- Lésions de la capsule articulaire, des vaisseaux sanguins environnants



1

Sécurité générale

- Conseillez à la victime de bouger le membre affecté le moins possible.
 - Maintenez le membre supérieur immobile contre la poitrine.
 - Ne pas laisser appuyer sur un membre inférieur douloureux

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Le gonflement est très prononcé
- Position anormale du membre
- Mobilité ou immobilité anormale
- Troubles sensoriels

mensurà
Learn&Connect

245

4

Premiers secours supplémentaires

- Entorse du membre supérieur
 - Enlever les bagues et les bijoux
- Entorse au niveau membre inférieur :
 - Ne pas enlever la chaussure
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
 - Eventuellement membre haut
- Refroidissez avec de la glace sur la plaie ou sur la chaussure
 - Soulage la douleur
 - Préviend le gonflement
- Interrompez le refroidissement si cela provoque des douleurs plus importantes
- L'application d'un bandage peut augmenter le confort pour la victime

mensurà
Learn&Connect

246

Luxation

Dislocation d'une articulation

Quoi?

Extrémités osseuses déplacées les unes par rapport aux autres

Symptômes

- Position anormale de l'articulation
- Douloureux
- Utilisation anormale des membres
- **Ouvert** déchirure → Associé à une plaie avec perte de sang
- **Fracture-luxation** → Associée à une fracture

Cause

Force directe provenant de l'extérieur (coup, choc ou chute)



mensurà-
Learn & Connect

247

1

Sécurité générale

- Conseillez à la victime de bouger le membre affecté le moins possible.
 - Maintenez le membre supérieur immobile contre la poitrine.
 - Ne pas laisser appuyer sur un membre inférieur douloureux
- Gants jetables en cas de lésion ouverte
- Bougez le membre le moins possible quand vous intervenez
- **Ne redressez JAMAIS une luxation ou un membre dans une position anormale**

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?
- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Calmez la victime si nécessaire
- Comparez avec l'autre côté pour voir s'il y a des déviations.
- Ne vérifiez JAMAIS la mobilité !

mensurà-
Learn & Connect

248

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Le gonflement est très prononcé
- Position anormale du membre
- Mobilité ou immobilité anormale
- Troubles sensoriels

mensurà
Learn & Connect

249

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- La victime ne peut plus se déplacer
- Une immobilisation est souvent nécessaire
- En cas de doute



mensurà
Learn & Connect

250

Premiers secours supplémentaires

Luxation ouverte

- Arrêtez l'hémorragie (qui peut être grave)
 - Compression directe
- Luxation du membre supérieur
 - Enlevez les bagues et les bijoux
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
- Couvrez avec une compresse stérile
 - Humidifiez la compresse avec de l'eau ou une solution désinfectante incolore.
- N'utilisez pas de glace

Luxation fermée

- Luxation du membre supérieur
 - Enlevez les bagues et les bijoux
- Permettez à la victime de prendre une position confortable
- Appliquez de la glace sur la plaie pour refroidir
 - Soulage la douleur
 - Prévient le gonflement

mensurà
Learn & Connect

251

Entorse, foulure, luxation, contusion

ColdPack :

- **ColdPack** : congélateur – flexible, réutilisable
- **Instant ColdPack** : armoire – usage unique



Avantages du refroidissement :

- les vaisseaux sanguins se contractent, la perte de sang diminue
- le refroidissement permet le bon drainage des liquides (idéal contre les gonflements/inflammation/douleur)

Attention:

en cas de raideurs ou douleurs musculaires, ne pas refroidir, mais utiliser de la **chaleur**!

mensurà
Learn & Connect

252



253

Brûlures

Comment déterminer la gravité d'une brûlure ?

- La cause
- La profondeur (degré) de la brûlure
- La surface brûlée (étendue)
- La localisation
- L'âge de la victime

Distinction entre **brûlures légères** et **graves** :

- Brûlure légère → Vous pouvez la soigner vous-même
- Brûlure grave → Aide spécialisée



mensurà
Learn & Connect

254

Brûlures

La cause

- Brûlure thermique
- Brûlure par flamme
- Brûlure par éclair
- Brûlure de contact
- Brûlure chimique
- Brûlure électrique
- Brûlure provoquée par de la lumière
- Brûlures provoquée par des radiations
- ...



mensurá-
Learn & Connect

255

Brûlures

La cause

Brûlures chimiques

- Toujours sérieuses
- Outre la brûlure proprement dite, le produit continue également à brûler (tant que le produit n'est pas neutralisé).
- Il peut y avoir une absorption dans la circulation sanguine, ce qui peut causer des lésions ailleurs dans le corps.

Brûlures électriques

- Le degré de gravité est très difficile à estimer.

Brûlures par flammes

- Souvent des brûlures du 3e degré.

mensurá-
Learn & Connect

256

La profondeur (le degré) de la brûlure

Brûlures du première degré

Seul l'épiderme est touché

- Rougeur
- Léger gonflement
- Pas d'ampoules/cloques
- Douleur
- Remplissage des capillaires
- Cicatrisation spontanée après environ 7 jours sans cicatrices
- Pommades locales



mensurá-
Learn & Connect

257

La profondeur (le degré) de la brûlure

Brûlures du deuxième degré

L'épiderme et une partie de l'hypoderme sont endommagées

- Rougeur

Formation d'ampoules/cloques

- Douleur intense
- Sensible au test de piqûre
- Remplissage des capillaires
- Guérison spontanée avec cicatrices après 2 à 6 semaines
- Pommades locales
- Essayez de garder les ampoules intactes



mensurá-
Learn & Connect

258

La profondeur (le degré) de la brûlure

Brûlures du troisième degré

L'épiderme, le derme et l'hypoderme sont détruits ;

- Aspect blanc, jaune, brun-noir, parchemin, cuir
- Surface sèche et cartonnée

Indolore

- Aucune sensation avec le test de piquûre
- Pas de remplissage des capillaires
- Guérison avec des cicatrices, chirurgie plastique recommandée



Brûlures du quatrième degré

Atteinte de la peau, des tissus musculaires et des os → Très grave !

mensurà
Learn & Connect

259

Brûlures

La surface brûlée et l'âge

- Plus la brûlure est grande, plus elle est grave
- Risque élevé d'infection

Comment déterminer la taille d'une brûlure ?

- La surface de la main d'une victime, avec les doigts fermés
= 1% de la surface totale du corps

5 % pour les -5 ans = danger de mort

10% pour les +5 ans = danger de mort



Toujours consulter un médecin si < 5 ans et > 60 ans

mensurà
Learn & Connect

260

Brûlures

La localisation



Une attention particulière doit être accordée aux brûlures dans les endroits suivants :

- Dans et autour de la **cavité buccale et du pharynx**
 - Toujours potentiellement mortelles, quelle que soit leur taille.
 - Risque de lésions dans la bouche et aux voies respiratoires
 - Le gonflement des tissus risque de provoquer de la suffocation.
- Visage, oreilles, mains, pieds, articulations ou organes génitaux
 - Risque de formation de cicatrices et de perte de fonction
- Brûlures circulaires
 - Cou, tronc ou membre
 - Le gonflement peut bloquer l'apport sanguin

mensurá-
Learn & Connect

261

1

Sécurité générale

- Éteignez le feu
- Faites attention aux surfaces chaudes
- N'ouvrez pas les portes ou les fenêtres s'il y a un feu à proximité de la victime
- Évacuez la victime avec la technique rautek vers une zone sûre.

2

Évaluez l'état de la victime

- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Évaluez le degré de gravité
 - 1^{ère} degré
 - 2^{ème} degré
 - 3^{ème} degré
- Quel est le pourcentage de brûlures par rapport au corps?

mensurá-
Learn & Connect

262

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

Chez le médecin

- Deuxième et troisième degrés supérieurs à la pièce de 2 euros
- Visage, mains, pieds, articulations et parties génitales
- Flammes
- Douleur persistante après 15 minutes de refroidissement

112

- En cas de doute
- Brûlures circulaires
- Yeux, bouche et gorge
- Produits chimiques
- Inconscience, difficultés respiratoires
- L'état de la victime se détériore

mensurá
Learn & Connect

263

4

Premiers secours supplémentaires

- **D'abord l'eau, le reste viendra plus tard**
Eau froide/tiède du robinet (robinet ou douche)

Appliquer la règle 20-20-20: 20' – 20° – 20 cm

- Ne pas utiliser de glace !
 - Soyez attentif à l'hypothermie en cas de blessures thermiques importantes/chez les **nourrissons et les enfants !**
- Retirez les bijoux et les vêtements s'ils ne collent pas à la peau.
- Ne PAS percer les ampoules = risque d'infection
- Attention aux signes d'intoxication (brûlures chimiques)

mensurá
Learn & Connect

264

4

Premiers secours supplémentaires

- Agir en fonction de la gravité de la brûlure

1^{ière} degré brûlure

- Crème hydratante (à base de glycérine, de panthénol et/ou d'aloë vera)
- Appliquez un bandage couvrant

2^{ème} degré brûlure (petit)

- Utilisez un pansement gras prévu à cet effet
- Un hydrogel = pommade ou gel spécifique pour le brûlures
- Appliquez un bandage couvrant

2^{ème} degré brûlure (grand) et 3^{ème} degré

Il faut une aide spécialisée !

- Appliquez un pansement humide (bandage triangulaire)
- Ou recouvrez la plaie d'un film plastique alimentaire
- Appelez le 112

mensurá
Learn & Connect

265

Refroidir la main

Appliquer un bandage triangulaire ou un film plastique



mensurá
Learn & Connect

266



267

Accidents électriques

Lorsqu'un corps entre en contact avec un courant électrique nocif, un accident électrique ou une électrification se produit.

Si cela conduit à un arrêt cardiaque, on parle d'électrocution.

L'électricité ne choisit pas le chemin le plus court, mais le chemin de moindre résistance :

- Nerfs
- Vaisseaux sanguins
- Muscles



mensurà
Learn & Connect

268

Accidents électriques

Risques spécifiques

- Arythmie cardiaque
- Troubles respiratoires
- Brûlures
- Déchirures musculaires et tendineuses, fractures
- Troubles nerveux
- Troubles des voies urinaires
- ...



mensurá-
Learn & Connect

269

Accident au basse tension

- Appareil électroménager dont la fiche est encore branchée dans la prise
- La victime peut être inconsciente
- Possibilité de problèmes respiratoires ou d'arrêt respiratoire
- Possibilité d'arythmie ou d'arrêt cardiaque
- Souvent une ou plusieurs brûlures
- Eventuellement des brûlures internes
- Crampes musculaires

Accident au haute tension

- Une cabine électrique est ouvert ou un câble a été coupé.
- Un ou plusieurs symptômes de blessures par basse tension
- La victime peut être éloignée de plusieurs mètres de la source en raison de la force du choc.
- De ce fait, les vêtements peuvent avoir été déchirés et/ou le casque et les gants ont été projetés (équipements de protection individuelle)

mensurá-
Learn & Connect

270

1

Sécurité générale

Basse tension

- Ne touchez jamais une victime qui est encore connecté à la source électrique.
- Coupez le courant électrique
 - Enlevez la prise murale
 - Mise hors tension des fusibles
 - Coupez l'interrupteur principal
- Assurez-vous que l'appareil ne peut pas être remis sous tension.
- Détachez la victime de l'appareil électrique



Haute tension

- Ne vous approchez pas de la source d'alimentation électrique
- Respectez une zone de 10 mètres de sécurité autour de la zone
- L'arc électrique peut sauter de 3 à 5 mètres
- Ne prenez pas le risque d'éteindre la source d'alimentation
- Travail pour le 112 / pompiers

mensurà
Learn & Connect

271

2

Évaluez l'état de la victime

Basse tension

- Trouvez ce qui ne va pas
- Ne touchez pas la victime à moins qu'il n'y ait plus de contact avec la source
- Touchez d'abord la victime avec le dos de votre main:
 - Empêche de la saisir suite à une crampe soudaine
- Vérifiez les fonctions vitales

Haute tension

- Essayez d'évaluer l'état de la victime à distance
- Ne vous approchez pas
- Ne touchez pas la victime!

mensurà
Learn & Connect

272

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

Basse tension

- La victime dit se sentir "bizarre«
 - perte de conscience momentanée = 112
- Examen par un médecin nécessaire
- Il est possible qu'il y ait des :
 - Blessures internes
 - Problèmes de santé à court et/ou à long terme
- Blessures graves, problèmes respiratoires, inconscience ou hésitation
 - Appel à 112

Haute tension

- Toujours le 112
- Préciser qu'il s'agit d'un accident de haute tension

mensurà
Learn & Connect

273

4

Premiers secours supplémentaires

Basse tension

- En fonction des lésions
 - Refroidir les brûlures
 - Réanimation et défibrillation
 - Position latérale de sécurité
- Possibilité de formation de caillots sanguins
 - Test FAST

Haute tension

- Laissez faire les services d'urgence
- Assurez une approche aisée pour les services d'urgence
- Évacuez l'environnement de travail ou l'entreprise

mensurà
Learn & Connect

274



275

Lésions oculaires

Les lésions oculaires sont réparties dans les groupes suivants:

- Lésions oculaires non pénétrantes
- Lésions oculaires pénétrantes
- Lésions chimiques

mensurá
Learn & Connect

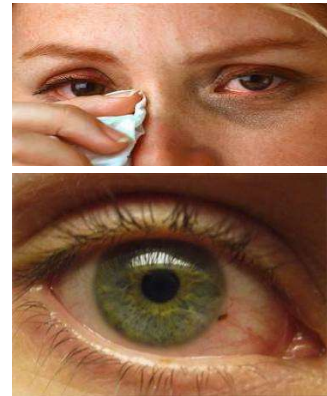
276

Lésions oculaires non pénétrantes

Blessures superficielles qui ne perforent pas la paroi du globe oculaire

Symptômes:

- Éclancements (coup de poignard)' ou picotements
- Œil rouge
- Production de larmes



mensurá
Learn & Connect

277

Lésions oculaires non pénétrantes

Traitement

- Rincez abondamment l'oeil avec de l'eau (min. 20°C)
 - → Faites retirer les lentilles de contact à la victime
 - → Faites pencher la tête de la victime vers l'arrière
 - → Écartez les deux paupières avec le pouce et l'index
 - → Demandez à la victime de regarder tour à tour vers le haut, le bas, la gauche et la droite
- Flacon de rinçage oculaire
- Ne laissez pas la victime se frotter les yeux
- Si nécessaire, orientez le patient vers les urgences/un ophtalmologue

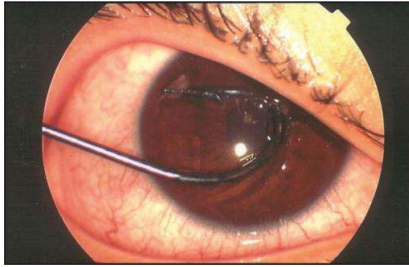


mensurá
Learn & Connect

278

Lésions oculaires pénétrantes

= Blessures profondes perforant la paroi du globe oculaire



mensurá
Learn & Connect

279

Lésions oculaires pénétrantes

Traitement

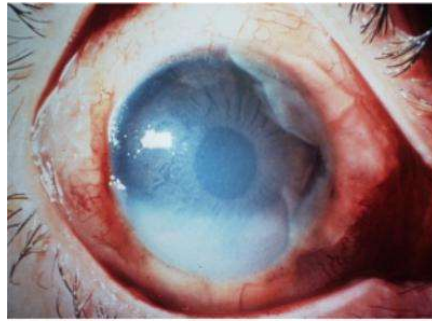
- Appelez le 112
- Évitez toute pression sur l'œil
- Si nécessaire, recouvrir d'un cache-œil en plastique dur ou d'un pansement oculaire non compressif.
- Il est préférable de couvrir les deux yeux
 - Mouvements oculaires simultanés



mensurá
Learn & Connect

280

Lésions oculaires provoquées par des produits chimiques



mensurà-
Learn & Connect

281

Lésions oculaires provoquées par des produits chimiques

Traitement:

- Rincez immédiatement pendant 10 à 20 minutes
 - D'abord avec un liquide neutralisant
 - Puis de l'eau pure (?)
- Si nécessaire, des analgésiques (après avis médical).
- 112 ou ophtalmologiste (toujours en cas de lésions oculaires chimiques)
- Veillez à ne pas contaminer l'œil non affecté.
- Il est conseillé de porter des gants pour traiter les lésions oculaires provoquées par des produits chimiques inconnus
- Jetez les gants avec précaution lorsque le traitement est terminé.



mensurà-
Learn & Connect

282

Avulsion d'une dent ou dent arrachée

Traumatisme entraînant le détachement complet de la dent de son alvéole dentaire

Si la victime saigne à l'endroit où se trouvait la dent:

- Mettez des gants jetables avant d'aider la victime.
- Rincez la bouche de la victime avec de l'eau fraîche.
- Arrêtez l'hémorragie comme suit :
 - Pressez un pansement humide contre la plaie
 - Demandez à la victime de mordre sur la compresse humide
 - Ne le lui demandez pas s'il y a un risqué que la victime avale la compresse:
 - Un petit enfant
 - Une personne agitée
 - Une personne dont la conscience est altérée

mensurá
Learn & Connect

283

Avulsion d'une dent ou dent arrachée

S'il n'est pas possible de replacer la dent tombée immédiatement sur le lieu de l'accident :

- Demandez l'aide d'un spécialiste
- Dans ce cas, la victime doit emporter en même temps la dent tombée quand elle va voir le spécialiste
- Ne prenez la dent tombée que par la couronne
- Ne touchez jamais la racine
- Rincez la dent tombée et visiblement sale avec une solution saline ou sous l'eau du robinet pendant 10 secondes avant de demander de l'aide.

mensurá
Learn & Connect

284

Avulsion d'une dent ou dent arrachée

Pour transporter la dent :

Enveloppez la dent dans du film alimentaire
ou conservez-la temporairement dans un petit pot :

- Avec du lait de vache (n'importe quelle forme ou taux de graisse)
- Évitez d'utiliser de l'eau du robinet, du lait battu (babeurre) ou une solution saline (chlorure de sodium).



mensurá
Learn & Connect

285



286

Saignements de nez

Le sang sort par le nez



- **Cause:**

- **Choc:** Après un coup ou un choc au nez
- **Spontanément:** Passage d'un espace froid à un espace chaud, hypertension artérielle

- En cas de saignements importants de nez, le sang peut également couler dans la bouche.
- Le saignement peut apparaître d'un ou des deux côtés du nez

mensurà
Learn & Connect

287

1

Sécurité générale

- Gants
- Faites asseoir la victime

2

Évaluez l'état de la victime

- Calmez la victime si nécessaire

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Si le saignement de nez n'est toujours pas stoppé après 20 minutes (2 x 10 minutes) de compression
- La cause est un coup ou un choc
- Le saignement de nez s'aggrave et s'accompagne d'autres symptômes
- Si la victime commence à somnoler, perd connaissance

mensurà
Learn & Connect

288

Premiers secours supplémentaires

- N'inclinez **pas** la tête en arrière.
 - Le sang peut couler jusque dans l'estomac et la victime pourrait avoir des nausées.
- Demandez de se moucher une fois (il est ensuite conseillé de ne pas se moucher pendant les 24 premières heures).
 - Ne **pas** le demander si une **fracture** est **suspectée**.
- Faire en sorte que la victime adopte une **position d'écriture**.
- Faire **pincer** les ailes du nez en continu **pendant 10'** (sous la partie osseuse).
- Faire **répéter** pendant 10 minutes si le saignement ne s'est pas arrêté.
- Demandez à la victime **de sucer un glaçon** (cela peut réduire le flux sanguin).
- **Nettoyez** le nez avec de l'eau
 - Ne vous mouchez pas pendant 24 heures, ne vous curez pas le nez
- Un **gant de toilette froid et humide** dans le cou peut avoir un effet **apaisant**, mais pas curatif.
- Pour permettre aux muqueuses endommagées de guérir correctement :
 - Éviter le passage d'un endroit froid à un endroit chaud, si possible
 - Éternuer avec la bouche ouverte
 - Les boissons chaudes doivent être refroidies pendant 5 à 10 minutes.

mensurá
Learn & Connect

289



Techniques de bandage

290

Couvrir temporairement les lésions – Bandage couvrant

Objectif

Couvrir une plaie ouverte, garder une plaie (brûlée) humide...

Localisation

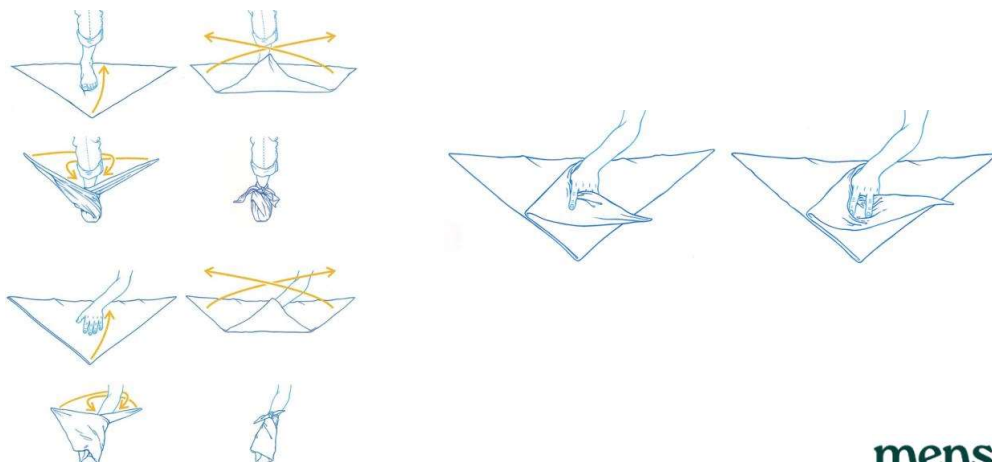
- Main/Pied
- Bras/jambes

mensurà
Learn & Connect

291

Bandage couvrant grâce à un bandage triangulaire

Main / Pied

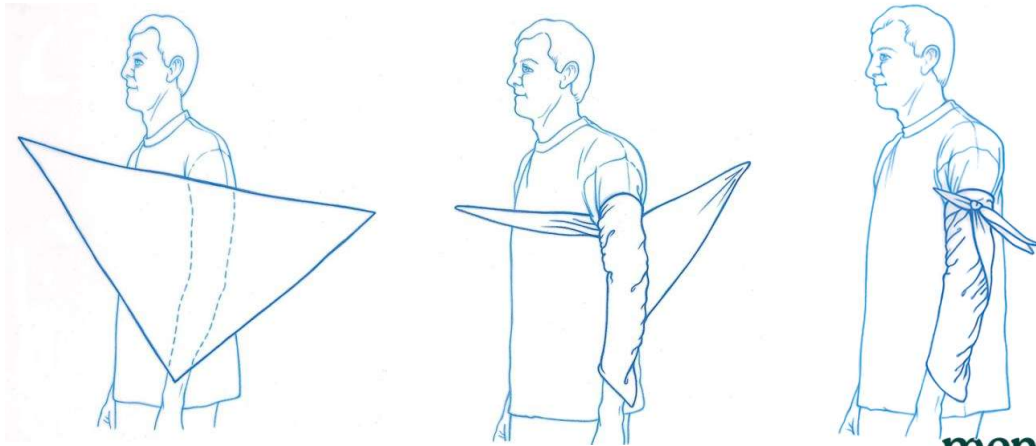


mensurà
Learn & Connect

292

Bandage couvrant

Grâce à un bandage triangulaire



mensurá-
Learn & Connect

293

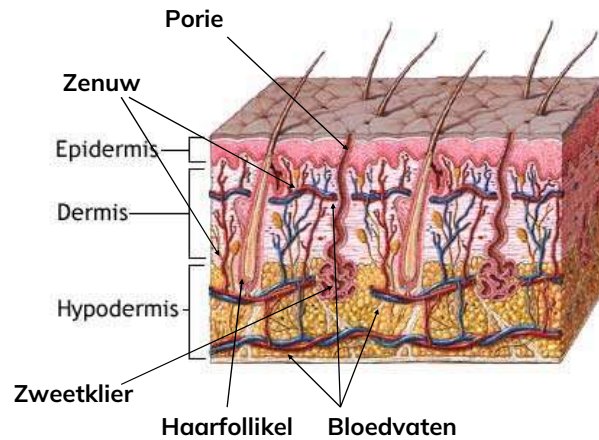


294

Anatomie de la peau

La peau:

- Épiderme
- Derme
- Hypoderme
- Tissus musculaires
- Os



mensurā
Learn & Connect

295

Soins des plaies

Les soins de la plupart des plaies cutanées se font de la même façon

Il y a des exceptions :

- Ampoules
- Échardes
- Peau prise dans une fermeture éclair
- Blessures par balle
- Déchirure(s) de la peau
- Plaie causée par un jet à haute pression



mensurā
Learn & Connect

296

Soins des plaies

En général

3 critères: SLC

- Saignement
- Lésion
- Contamination ou infection



mensurà
Learn & Connect

297

1

Sécurité générale

- Éliminez la cause de la plaie cutanée
 - Ne pas le faire si un corps étranger est encore dans la plaie
- Se laver et se désinfecter les mains et utiliser des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?
- Estimez le type et l'importance de la plaie cutanée



mensurà
Learn & Connect

298

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Blessures au visage, aux yeux ou aux organes génitaux
- Un corps étranger dans la plaie
- Plaie pénétrante avec un objet sale
- Morsure animale ou humaine
- Quand la vaccination contre le tétanos n'est pas en ordre
- Saignement qui ne parvient pas à être arrêté
- La plaie ne peut pas être nettoyée → **risque d'infection**
- Abrasion > paume de la main
- Plaie(s) béante(s)
- Blessures par déchirement
- Os ou tissus sous-cutanés visibles...

mensurá
Learn & Connect

299

4

Premiers secours supplémentaires



De l'eau est disponible?

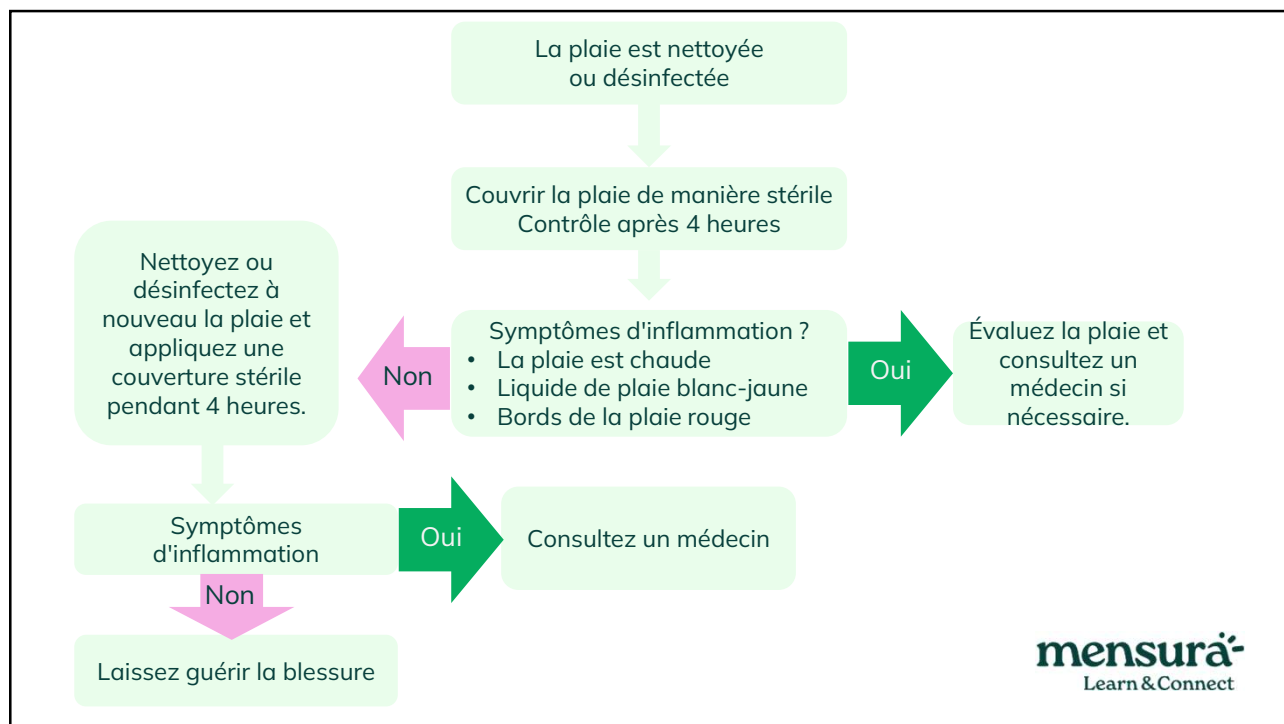
- Nettoyez soigneusement la plaie, de préférence avec l'eau tiède.
- Directement dans la plaie
- Ne pas frotter
 - La victime peut se laver les mains si nécessaire
- Tamponnez la zone autour de la plaie
- Couvrez la plaie avec
 - Une compresse stérile
 - Tulle gras
 - Pansement pour plaies
 - Pansement du type « seconde peau »

L'eau n'est pas ou peu disponible?

- Utilisez un désinfectant aqueux, incolore
- Tamponnez avec une compresse, ne pas frotter
- Si la plaie est propre, désinfectez à nouveau.
- Tamponnez la zone autour de la plaie
- Couvrez la plaie avec
 - Une compresse stérile
 - Tulle gras
 - Pansement pour plaies
 - Pansement du type « seconde peau »

mensurá
Learn & Connect

300



301

Plaies infectées

La plaie est infectée par des micro-organismes (bactéries, virus ou champignons)

Contamination

- Les micro-organismes ne se sont pas encore multipliés OU le système immunitaire les reconnaît et les élimine à temps

Infection

- Les micro-organismes **se multiplient** et sont la cause de plusieurs symptômes

Exemple : pince ou tétanos

- Pénètre dans l'organisme par une plaie cutanée
- Période d'incubation : 3 à 21 jours
- La bactérie du tétanos produit une toxine qui affecte le système nerveux
- Raidissement des muscles de la déglutition et de la mastication, puis du cou, des bras et des jambes

Prévention du tétanos: **la vaccination !**

mensurá
Learn & Connect

302

Plaies infectées

Symptômes d'inflammation :

2 des symptômes suivants

- Rougeur (**Rubor**)
- Chaleur (**Calor**)
- Douleur (**Dolor**)
- Gonflement (**Tumeur**)

+ Sécrétion purulente/pus



mensurá
Learn & Connect

303



Saignements - lésions - infections :

Types de plaies cutanées

304

Qu'est-ce qu'une plaie cutanée et quels en sont les types?

La peau est endommagée, ce qui perturbe la structure normale des couches cutanées

En cas de plaies cutanées profondes, les tissus sous-jacents peuvent également être endommagés.

- Muscles
- Os
- Organes



Cela crée un risque élevé de contamination

mensurà
Learn & Connect

305

Différentes lésions cutanées

- Chaque blessure est différente et fait plus ou moins mal.
- Peut également s'accompagner d'une perte de sang
- Classification des plaies cutanées en fonction de leur **cause** :
 - Abrasions
 - Coupures
 - Brûlures
 - Lésions pénétrantes
 - Lésions par déchirure



mensurà
Learn & Connect

306

Abrasion

Superficiel

Seule la couche supérieure protectrice de la peau est abrasée

Visible par les petites fractions de peau

Souvent après une chute sur les mains et les genoux:

- La plaie est rouge et de petits points sanguins sont visibles
- Saleté dans la plaie (sable ou gravillon)
- Douloureux (terminaisons nerveuses touchées)



mensurá-
Learn & Connect

307

Coupure

La peau est abîmée par un objet tranchant

Nous distinguons :

- Coupures **superficielles**
 - Petite incision
 - Saignement léger
- Coupures **profondes**
 - Saignement abondant



Les bords de la plaie sont bien définis

Moins douloureux car moins de terminaisons nerveuses sont endommagées

mensurá-
Learn & Connect

308

Brûlure

Cause?

- Chaleur
- Électricité
- Substances chimiques
- Radiation
- Vapeur

Résultat : brûlure de la peau et des tissus sous-jacents

Soins : Chapitre brûlures

Les engelures sont une certaine forme de brûlures
(ref. chapitre chaleur et froid)



mensurà
Learn & Connect

309

Plaies pénétrantes

- Causée par un objet pointu et tranchant
- Petite plaie visible sur la peau
- Les lésions internes sont très difficiles à évaluer
- Selon l'endroit, il peut y avoir une perte de sang modérée à importante
- Ne jamais retirer un objet de la plaie



Conseillez à la victime de ne pas toucher

mensurà
Learn & Connect

310

Plaies par déchirure

Exemples :

- Accident au du fil barbelé
- Une boucle d'oreille qui s'arrache
- Traumatisme important par objet contondant



Les bords de la plaie sont effilochés et irréguliers:

- La guérison sera plus difficile
- Risque élevé de cicatrices
- Douloureux
- Les saignements sont (généralement) modérés

mensurá
Learn & Connect

311



Saignements -lésions- infections :

Soins spécifiques des plaies

BRG GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

312

Blessures à la tête

Il est souvent difficile de faire la différence entre :

- Blessure à la tête
- Fracture du crâne
- Lésion cérébrale
- Commotion cérébrale

Signes d'alarme

- Fracture du crâne
 - ➔ Crâne déformé ou une sensation d'instabilité du crâne
- Lésion cérébrale/commotion cérébrale
 - ➔ changement du comportement (ne bouge soudainement plus...)

mensura
Learn & Connect

313

4

Premiers secours supplémentaires

- Suspicion de lésion crânienne ou vertébrale ?
 - Agir en tant que tel!
- La plaie saigne-t-elle beaucoup ?
 - 10 minutes de pression sur la plaie
 - Puis une bandage compressive
- Traiter comme une plaie cutanée
- Refroidissement pendant 20 minutes avec glace
- Continuez à observer la victime

mensura
Learn & Connect

314

Blessures par morsure

Par l'homme ou un animal

En fonction de la localisation et de l'intensité de la morsure :

- Perte de sang modérée ou importante
- Douleur légère à sévère

Risque élevé d'infection en raison de la forte teneur en bactéries dans la bouche

Symptômes

- Peau rouge à l'endroit de la morsure
- Empreinte dentaire visible
- De petites blessures (parfois des grandes)
- La peau est (souvent) déchirée,
- Des bleus (hématomes)
- Douleur

mensurá
Learn & Connect

315



Sécurité générale

- Méfiez-vous des animaux agressifs



Évaluez l'état de la victime

- Calmez la victime si nécessaire



Consultez un spécialiste 112, médecin

- Consultez toujours un médecin

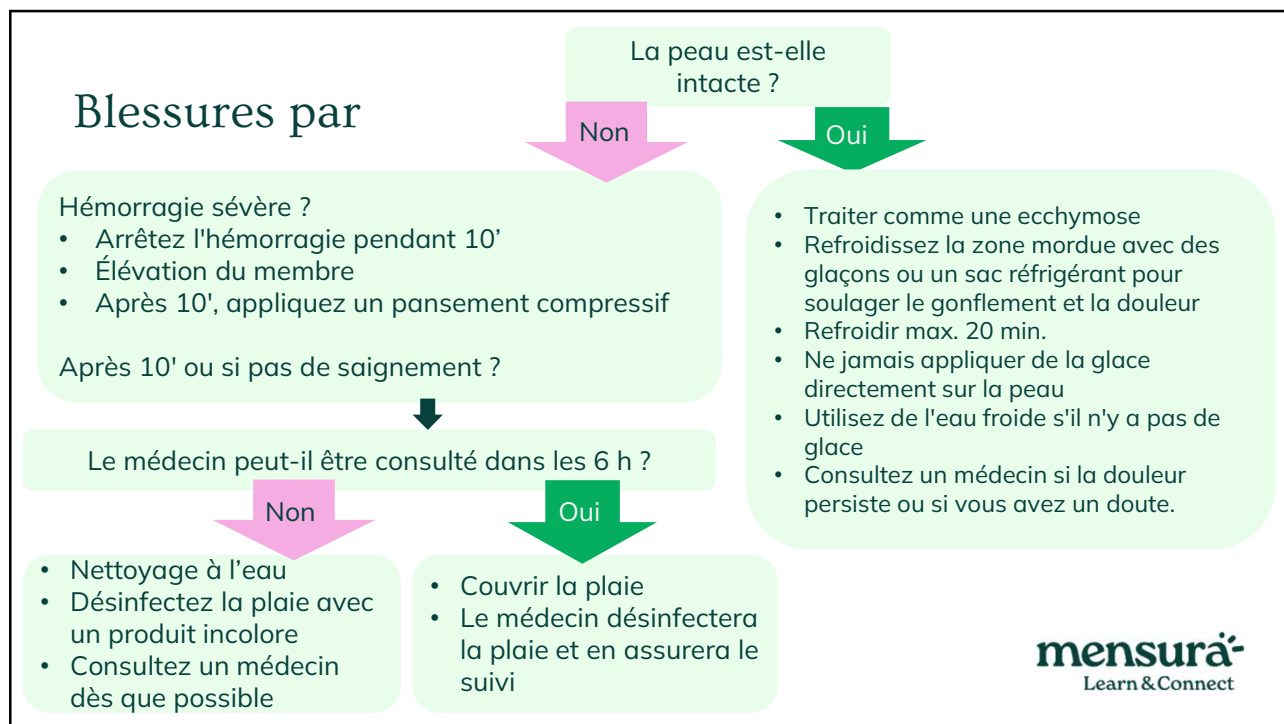


Premiers secours supplémentaires

- La peau est intacte ? Refroidir jusqu'à 20 minutes avec de la glace
- La peau est endommagée ?
 - Arrêtez un saignement grave
 - Rincez ou désinfectez la plaie de la morsure

mensurá
Learn & Connect

316



317

Blessure par balle

- Causé par une balle ou un projectile industriel
- Généralement une petite blessure d'entrée
- Si présent : plaie de sortie plus large
- Possibilité de gros dégâts internes et invisibles :
 - Saignement
 - Fractures

Les blessures par balle à la tête, à la poitrine ou à l'abdomen sont toujours considérées comme mortelles jusqu'à preuve du contraire



mensurà
Learn & Connect

318

1

Sécurité générale

- Alerte le 112 en cas d'incident de tir
- Ne donnez les premiers secours que si vous pouvez le faire en toute sécurité.
- Gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?
- Contrôle de la conscience et de la respiration
- Calmez la victime si nécessaire
- Vérifiez s'il y a plusieurs blessures par balle (par exemple en cas de blessures par balle avec grêle).

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Appelez ou faites appeler le 112 immédiatement.

mensurá
Learn & Connect

319

4

Premiers secours supplémentaires

- Pression manuelle directe sur l'endroit de saignement
- Utilisez pour obturer
 - Chiffon propre
 - Compresse
- Posez un pansement sur les plaies d'entrée et de sortie.
- Parfois, une aide spécifique en cas de :
 - Blessure au **thorax**
 - Rassurez la victime
 - Plaie visible qui saigne
 - Appuyez sur la plaie avec la/les main(s)
 - Ne pas utiliser de bandages peu ou pas perméables à l'air
 - Blessures **abdominales**
 - Couvrez la plaie avec une compresse et appuyez fermement dessus jusqu'à l'arrivée des secours

mensurá
Learn & Connect

320

Ampoules

- Principalement en raison de frictions
- Peut être très gênant sur les mains et les pieds
- Il s'agit d'une poche de liquide (clair) dans ou sous l'épiderme.
- Il est possible que l'ampoule se déchire spontanément.



Conséquence

- Plaie
- Risque d'infection

mensurá
Learn & Connect

321

1

Sécurité générale

- Lavez et désinfectez vos mains
- Portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- S'il y a des signes d'infection
- Si la victime souffre de diabète
- Si la victime a une résistance physique réduite

mensurá
Learn & Connect

322

Premiers secours supplémentaires

- Laissez intacte une ampoule qui n'est pas gênante
- **L'ampoule est ouverte**
 - Nettoyez l'ampoule et la zone environnante à l'eau courante.
 - Pas d'eau ? Utilisez un désinfectant incolore.
 - Enlevez la peau détachée avec une pincette et des ciseaux à plaies (désinfectez ensuite).
 - Soignez comme une plaie cutanée
 - Recouvrez ensuite la plaie d'une compresse ou d'un pansement « deuxième peau ».
- **L'ampoule est intacte** mais il y a une gêne ou un risque qu'elle se déchire
 - Nettoyez la zone avec de l'eau ou un désinfectant incolore.
 - Percez l'ampoule à la base (piquez horizontalement) avec une aiguille stérile.
 - Videz l'ampoule à l'aide d'une compresse stérile et nettoyez/désinfectez
 - Tamponnez la zone pour la sécher
 - Couvrez ensuite la plaie avec une compresse ou un pansement « seconde peau ».

mensurà
Learn & Connect

323

Echardes

- Survient fréquemment
- Pas toujours facile à enlever
- Il y a toujours un risque d'infection



mensurà
Learn & Connect

324

1

Sécurité générale

- Lavez-vous et désinfectez-vous les mains
- Portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Extrémité de l'éclat mal visible
- L'écharde ne peut pas être retirée ou se casse pendant le retrait
- En cas de réaction allergique (bois tropicaux durs tels que l'okan ou le bankirai)
- Éclat de métal ou de verre
- Une écharde dans ou autour de l'œil
- Pas de vaccination contre le tétanos
- Signes d'infection

mensurà
Learn & Connect

325

4

Premiers secours supplémentaires

- Nettoyez ou désinfectez soigneusement la plaie et la zone environnante à l'eau ou avec un désinfectant aqueux non décolorant
- Désinfectez une pince à épiler en la plongeant pendant environ 1 minute dans de l'alcool à brûler, puis attendez quelques secondes que l'alcool s'évapore (ne soufflez pas dessus).
- Saisissez l'extrémité de l'écharde à l'aide d'une pince à épiler, que vous tiendrez dans le prolongement de l'écharde
- Retirez l'écharde de la peau.
- Nettoyez ou désinfectez la plaie
- Couvrez la plaie avec un pansement ou une compresse

mensurà
Learn & Connect

326

Peau coincée dans la fermeture éclair

- Il est important de détacher la peau aussi vite que possible.
- La peau peut commencer à gonfler et rendre difficile l'aide à apporter



mensura
Learn & Connect

327

1

Sécurité générale

- Lavez-vous et désinfectez-vous les mains
- Portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- La peau ne peut pas être détachée
- Il y a une blessure cutanée après avoir retiré la fermeture éclair

mensura
Learn & Connect

328

Premiers secours supplémentaires

- Détachez la peau de la fermeture éclair
- La peau est coincée entre le mécanisme de la fermeture éclair → Utilisez un tournevis
 - Placez la tête d'un tournevis plat entre les glissières supérieure et inférieure
 - Déplacez-vous vers la gauche et vers la droite jusqu'à ce que la peau se détache
- La peau coincée entre les dents d'une fermeture éclair
 - Coupez la fermeture éclair juste en dessous du coincement et écartez les dents de la fermeture éclair
- Soignez la blessure cutanée éventuelle

mensurà
Learn & Connect

329

Déchirure de la peau

Lésion cutanée dans laquelle la couche supérieure de la peau se détache de la couche sous-jacente

Généralement sur les membres des personnes âgées, en raison de :

- Friction
- Coups
- Tomber

Même après une radiothérapie ou une utilisation prolongée de médicaments



mensurà
Learn & Connect

330

1

Sécurité générale

- Lavez-vous et désinfectez-vous les mains
- Portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

mensurà
Learn & Connect

331

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Consultez toujours un médecin

4

Premiers secours supplémentaires

- Traitez avec beaucoup de précaution afin de ne pas aggraver la blessure
- Coupez la peau qui ne pend PAS
- Rincez délicatement la plaie à l'eau, sans frotter
- Veillez à ce que la plaie reste humide
- Compresse avec de l'eau / désinfectant non décolorant
- PAS de pansement

mensurà
Learn & Connect

332

JM1 Aangepaste slide.

Moerman Joséphine; 2025-08-18T12:10:22.567

Blessure causée par un jet à haute pression

Dans l'industrie, cette blessure survient lors de travaux impliquant:

- Air
- Eau
- Vapeur
- Huile
- Peinture
- Sable
- Solvants



mensurà
Learn & Connect

333

Blessure causée par un jet à haute pression

On parle ici d'une **lésion due à une pression élevée**.

Souvent, la plaie d'entrée est petite.

Cela peut entraîner des blessures graves :

- Tendons
- Nerfs
- Muscles
- Vaisseaux sanguins

Circonstances aggravantes pouvant complexifier la blessure :

- Substances irritantes et/ou toxiques

mensurà
Learn & Connect

334

1

Sécurité générale

- Éliminez la cause de la blessure due à la pression élevée
- Lavez et désinfectez vos mains et portez des gants jetables

2

Évaluez l'état de la victime

- Que s'est-il passé ?

3

Consultez un spécialiste 112, médecin

- Consultez toujours un médecin
- Ne sous-estimez jamais la gravité d'une blessure due à une pression élevée

4

Premiers secours supplémentaires

- Traitez une hémorragie grave si nécessaire
- Refroidissez les brûlures éventuelles avec de l'eau
- Couvrez la plaie

JM1 Aangepaste slide.

Moerman Joséphine; 2025-08-18T12:10:22.567



337

Prévenir la contamination : bandages de fixation

Objectif

- Fixation d'un autre bandage ou d'une compresse

Types

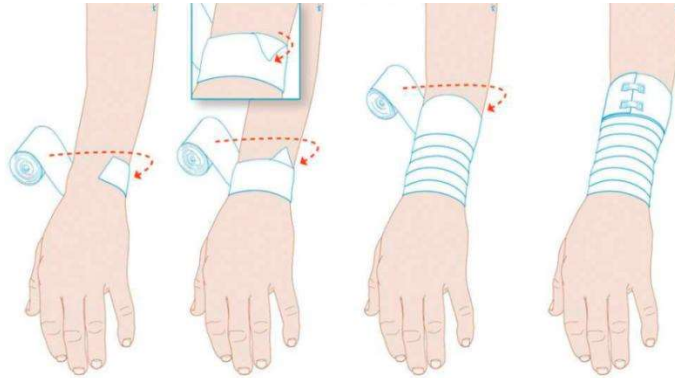
- Bandage en spirale (croisé)
- Bandages tubulaires, doigtiers, bandages en filet

mensurà
Learn & Connect

338

Bandages de fixation

Bandage en spirale

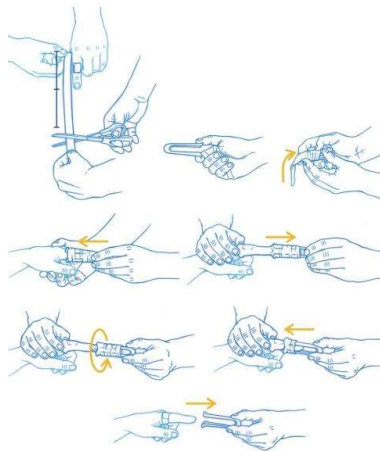


mensurá-
Learn & Connect

339

Bandages de fixation

Doigtier



mensurá-
Learn & Connect

340

Bandages de soutien

Moins fréquent lors d'une intervention de premiers secours

Objectif

Soutien supplémentaire à une partie du corps blessée

Types

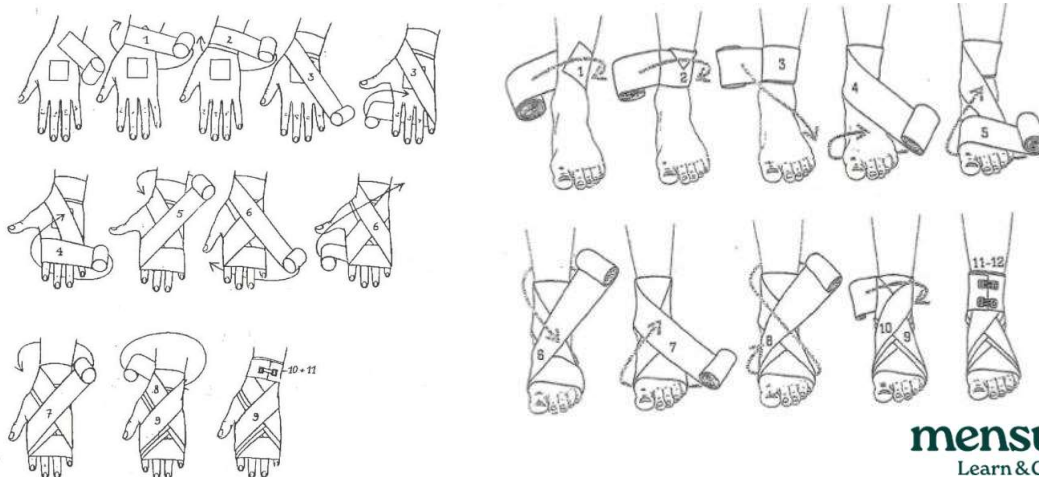
- Bandage en croix
- Assemblage à charnière

mensurà
Learn & Connect

341

Bandages de soutien

Bandage en croix à la main ou au pied

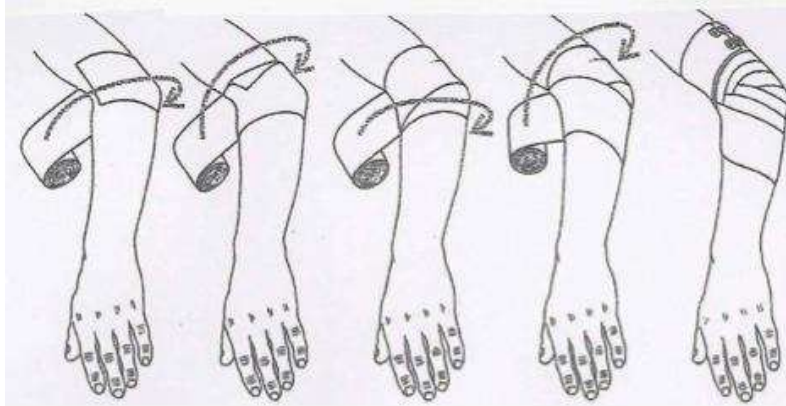


mensurà
Learn & Connect

342

Bandages de soutien

Assemblage à charnière



mensurá-
Learn & Connect

343



Cadre juridique

344

ARTICLE 422 BIS (8 juin 1867): Négligence grave



= **Toute personne** est tenu de porter secours en cas de danger

- Pour les situations où vous constatez vous-même l'état de la victime
- Non-assistance à personne en danger
→ Condamnation **négligence coupable**

Remarque:

- Le premier secouriste ne doit pas mettre en danger sa propre sécurité ni celle d'autrui
- Le secouriste n'effectue aucun acte médical
Par exemple: administrer des médicaments, ...

mensurá-
Learn & Connect

345

ARTICLE 422 BIS (8 juin 1867) : Négligence grave



Exemple

Huit personnes risquent des poursuites pénales pour ne pas avoir aidé un homme en détresse. L'homme s'était rendu sur la Grand-Place de Courtrai peu après minuit et s'était assis sur un banc. Les images de la caméra auraient montré que l'homme a ensuite fait un malaise et est tombé. Plusieurs personnes ont croisé l'homme mais n'ont pas offert d'aide. Certains sont même allés jeter un coup d'œil, mais ont ensuite continué leur chemin.

La négligence coupable signifie que :

- Une personne ne donne pas ou ne porte pas assistance à une personne en grand danger
- C'est lorsqu'il a lui-même constaté l'état de la victime ou que cet état lui a été décrit par ceux qui lui demandent de l'aide.

Il faut que la personne ait pu apporter son aide sans danger grave pour elle-même ou pour autrui.

mensurá-
Learn & Connect

346

Qu'est-ce qu'un grand danger?



L'état dans lequel l'intégrité personnelle, la liberté ou l'honneur d'une personne risquent d'être compromis.

- **Aucun** danger de **mort requis**
- Des exemples d'un tel "grand danger" sont :
 - une personne gravement blessée à la suite d'un accident de la route
 - une personne qui a reçu des coups violents et est jetée à la rue sans aucune aide
 - un accouchement
 - un viol
 - ...

mensurà
Learn & Connect

347

Quelle aide devez-vous apporter?



La jurisprudence dominante soutient donc qu'il vaut mieux essayer de faire **quelque chose** plutôt que de ne rien faire

- Par exemple, **alarmer le 112**
- Il n'y a **pas de négligence coupable** si la personne a fourni une assistance mais que celle-ci a été infructueuse, inefficace ou maladroite.
- Il n'y a **pas de négligence coupable** si la personne pouvait croire, sur base des circonstances dans lesquelles elle a été sollicitée, que la demande n'était pas sérieuse ou qu'elle comportait un danger pour elle-même ou pour des tiers.

mensurà
Learn & Connect

348

Code pénal



- Le fait de ne pas porter assistance à une personne en danger, constitue un risque :
 - une peine de prison de **huit jours à un an**
 - une amende comprise **entre 400 et 4 000 €**
- La durée maximale de l'emprisonnement est portée à **deux ans** si la personne qui est en danger est :
 - **Mineur**
 - Dans **un état de vulnérabilité** en raison de son âge, d'une grossesse ou d'une maladie
 - **Handicap ou insuffisance physique ou mentale** si cette condition était évidente pour la personne qui ne fournit pas d'assistance.

MOYENS D'ENGAGEMENT

Utiliser ses connaissances et ses compétences pour aider la victime.

AUCUN ENGAGEMENT DE RÉSULTAT

Il n'y a pas de référence que l'aide offerte doit réussir.

mensurá
Learn & Connect

349

Article 458 (8 juin 1867) : Secret professionnel



Certaines professions sont soumises au secret professionnel.

= Les personnes occupant certaines fonctions ne peuvent divulguer aucune information.

Il s'agit de :

- Professions de la santé et du bien-être (médecin, pharmacien, travailleur social...)
- Agents de police
- Toutes les personnes qui, en raison de leur statut ou de leur profession, ont connaissance de secrets = **les secouristes**



Le secret professionnel reste **toujours** applicable, même lorsque la relation de confiance a pris fin ou lorsque le contrat de travail a expiré.

mensurá
Learn & Connect

350



Article 458 (8 juin 1867) Secret professionnel

Les informations dont tous les noms et détails concrets ont été supprimés, de sorte qu'il s'agit d'une description de la situation en termes généraux, ne relèvent pas du secret professionnel.

Les informations suivantes sont **confidentielles** :

- Tout ce qui a été confié explicitement ou tacitement à la personne de confiance
- Toutes les informations qui sont vues ou entendues
- Informations sur les tiers
- Les secrets industriels, tels que la formule d'un médicament

mensurá
Learn & Connect

351



Article 458 (8 juin 1867) Secret professionnel

Vous enfreignez le secret professionnel lorsque vous divulguez délibérément des secrets, même si vous n'avez pas l'intention de causer un préjudice ou un dommage à quelqu'un.



La manière dont vous révélez un secret n'a aucune importance
Le secret professionnel peut être levé dans certains cas

État d'urgence

- Secret professionnel partagé → Partage d'informations avec le professionnel de santé qui assure le suivi de la victime.
- Si un secouriste est appelé à témoigner pour faire une déclaration
- Signaler les informations au procureur du Roi en cas d'atteinte à la vie de la victime et s'il s'avère que la victime n'est pas en mesure d'agir lui-même (par exemple, violence conjugale)

mensurá
Learn & Connect

352



Obligation de déclarer

= Obligation de signaler certains délits

Exemples :

- Maltraitance des enfants
- Violence parentale

Important:

1. Dans cette situation, n'agissez **pas de votre propre initiative**
2. Consultez un **conseiller juridique** ou votre responsable

mensurá-
Learn & Connect

353

M1



Déclaration de volonté négative

En cas d'urgence grave, on agit toujours de manière à sauver des vies,

sauf si l'on tombe **par hasard** sur une déclaration de volonté.

Exemple : tatouage sur la poitrine, bracelet au poignet, ...



Le premier secouriste **ne doit pas rechercher activement** une déclaration de volonté négative.

mensurá-
Learn & Connect

354

JM1 Nieuw toegevoegde slide 7/11.
Moerman Joséphine; 2025-11-07T09:16:55.429

Remarque:

Pas de médicaments dans la trousse de premiers secours

Qu'en est-il de l'EpiPen ?

Les employés présentant une réaction allergique connue doivent avoir leur EpiPen sur eux !
L'administration de médicaments ne relève pas de la compétence du secouriste.

MAIS que faire en cas d'urgence ? Le secouriste n'est pas en mesure d'administrer l'EpiPen

Obligation légale de porter secours !

Administration de l'EpiPen comme **mesure de sauvetage**

mensurá
Learn & Connect

357

Anaphylaxie

= Réaction allergique grave pouvant rapidement évoluer vers une situation potentiellement mortelle

Causes de l'anaphylaxie :

- Aliments, médicaments, insectes, ...
- Piqûre ou morsure d'insecte, par exemple les guêpes ou les abeilles piquent à l'aide de leur dard
 - **Conséquence:** Petite blessure cutanée + **Poison dans la blessure**
 - Réaction grave (en cas de piqûres multiples, de piqûre dans la bouche ou la gorge, d'allergie au venin d'insectes) → **Choc anaphylactique**

Symptômes :

Gonflement local, rougeur cutanée, démangeaisons, douleurs, maux de tête, vertiges, difficultés respiratoires, problèmes de déglutition, perte de conscience

mensurá
Learn & Connect

358

JM1 Aangepaste slide volgens ERC 2025.
Moerman Joséphine; 2025-08-06T10:39:06.239

Traitement des piqûres ou morsures d'insectes

1

Sécurité

- Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains
- Enfilez des gants jetable

2

Évaluez l'état de la victime

- Vérifiez ce qui ne va pas ?
- Demandez-lui s'il a des difficultés à avaler.

3

Consultez de l'aide spécialisée (112, médecin)

- Aide spécialisée telle que :
 - Si vous ne parvenez pas à retirer le dard
 - Si vous présentez une rougeur étendue ou un gonflement douloureux
 - Si la victime commence à se sentir mal après la piqûre/morsure (jusqu'à 24 heures après)
 - La victime a été très souvent piqué/mordu
 - Signes d'inflammation au niveau du site de piqûre
- Centrale d'urgence 112 comme :
 - La victime a été poignardé dans la bouche ou le pharynx
 - Symptômes de l'anaphylaxie

mensurà
Learn & Connect

359

Traitement des piqûres ou morsures d'insectes

4

Premiers secours supplémentaires

- Rassurez la victime, conseillez-lui de ne pas se gratter
- **Le dard est-il encore dans la peau ? Retirez-le dès que possible !**
 - Grattez le dard avec votre ongle, une carte bancaire ou le côté émoussé d'un couteau
 - Nettoyez la plaie à l'eau
 - Désinfectez la plaie si vous n'avez pas d'eau à disposition
 - Refroidir la zone touchée pendant 20 minutes maximum à l'aide d'une poche de glace/des glaçons dans un sac rempli d'eau + une serviette
 - Glaçons dans la bouche/glace à l'eau en cas de piqûre dans la bouche
- Retirer les bijoux en cas de coupure à la main
- Pommade anti-démangeaisons disponible chez le médecin / en pharmacie
- EpiPen (en appliquant des conditions!)

mensurà
Learn & Connect

360

Symptômes de l'anaphylaxie

- Gonflement du visage (paupières, lèvres, langue et gorge)
- Maux de tête, vertiges
- Douleurs abdominales, nausées, diarrhée et parfois vomissements
- Toux et respiration sifflante
- Baisse de la tension artérielle et accélération du pouls
- Rougeurs cutanées accompagnées de démangeaisons met jeukend gevoel
- Verlies bewustzijn

mensurá
Learn & Connect

361

Traitement anaphylaxie

EpiPen = Stylo injecteur automatique rempli d'adrénaline

- Appelez 112
- Positionnez la victime: Position confortable si la victime présente des problèmes respiratoires en position semi-assise.
- Tenez l'injecteur d'une main, le pouce près du capuchon de sécurité bleu → Poing autour de l'injecteur
- Retirez le capuchon de sécurité bleu avec l'autre main.
- Maintenez l'extrémité orange à environ 10 cm de la **cuisse**.



mensurá
Learn & Connect

362

Traitement anaphylaxie

EpiPen = Stylo injecteur automatique rempli d'adrénaline

- Appuyez fermement l'extrémité orange de l'injecteur contre l'extérieur de la cuisse (à travers les vêtements) → **CLIC**
- Maintenez l'injecteur dans cette position pendant 10 secondes
- Retirez l'injecteur et massez le site d'injection pendant 10 secondes
- Le capuchon orange recouvre l'aiguille → Rangez l'injecteur en toute sécurité dans un conteneur à aiguilles



Remarque : 2e injection nécessaire après 5 minutes si les symptômes ne s'atténuent pas.

mensura
Learn & Connect

363

MyMensura Espace client

Documents informatifs **Contenu de la trousse de premiers secours**

Le matériel de base et la boîte de secours							
L'employeur détermine, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité :							
• quel matériel de base est nécessaire • le contenu de la boîte de secours, • l'endroit où ce matériel doit se trouver, • si des compléments sont nécessaires.							
La quantité et la nature des produits dépendent du nombre de travailleurs et de la nature des activités de l'entreprise. Vous pouvez mentionner vous-même le nombre de produits sur la liste. Sur la base de l'analyse des risques, du matériel et des équipements de premiers secours supplémentaires peuvent être recommandés. Cette liste peut également servir de liste de contrôle des produits présents. Vérifiez régulièrement les dates de péremption des produits.							
Matériel de premiers secours	Description	Matériel de base croupe D Autre A, B, C	Extension utile	Risques spécifiques	Nombre	OK/ NOK	Remarques
Eau, savon, brosse à main et serviettes en papier	De préférence un sac-pompe contenant du savon liquide.	X	X				
Gel alcoolisé	Pour la désinfection des mains.		X				
Gants jetables	Les gants protègent contre la transmission des germes pathogènes. De préférence des gants en nitrile. Ceux-ci sont exempts de latex car certaines personnes développent une réaction allergique après contact avec du latex.	X	X				
Désinfectant en handsanid ou cadum... (durée de conservation de 5 ans)	De préférence dans des flacons à usage unique ou bien fermés de bords.	X	X				
Alcool désinfectant	Pour la désinfection d'instruments et de la peau saine.	X	X				

mensura
Learn & Connect

364

MyMensura Espace client

Document à remplir **analyse des risques premiers secours**

The screenshot shows a web interface for 'MyMensura Espace client'. At the top, there's a green header bar with the text 'Exemple Analyse des risques Premiers secours'. Below this, a section titled 'Ce document comprend:' lists three items: A. Check-list analyse des risques Premiers secours, B. Check-list Organisation Premiers secours, and C. Conclusion. Below the list is a table with five rows, each containing a label and a text input field with a placeholder 'Click here to enter text.'.

Label	Text Input
Entreprise :	Click here to enter text.
Adresse :	Click here to enter text.
Conseiller en prévention interne :	Click here to enter text.
Conseiller en prévention – médecin de travail :	Click here to enter text.
Date :	Click here to enter text.

mensura
Learn & Connect

365

Exigences d'un local de premiers secours

Pour les entreprises A, B et C (pour les entreprises D selon l'analyse des risques)

- Aménagement déterminé par l'employeur après avis du médecin et éventuelle approbation du Comité (CPPT)

→ **Remarque :** Non obligatoire si l'analyse des risques démontre que cela n'est pas nécessaire

→ **Remarque :** Peut également être utilisé comme salle de repos pour les employées enceintes, pour l'allaitement et pour effectuer des examens médicaux.

mensura
Learn & Connect

366

Exigences d'un local de premiers secours

- La pièce est-elle ventilée ? Éclairée ? (min. 500 lux)
Bien chauffée ? (min. 20°C)
- Le local est régulièrement entretenu
- Est-il suffisamment spacieux et équipé d'un lit, d'un brancard ? La pièce offre-t-elle une table, deux chaises, un lit de repos, un frigo, une poubelle?
- Aucune vue directe possible par les passants ou les postes de travail voisins
- Eau chaude et froide courante (ou à proximité), savon, serviettes jetables
- Assez spacieux? Les voies d'accès sont-elles libres ?
La pièce offre-t-elle un passage pour une civière ?
- Trousse/armoire de premiers secours
- Y a-t-il des registres d'accidents ?
- Liste des numéros d'urgence internes et externes
- Matériel d'écriture
- La salle est-elle indiquée par un panneau (croix blanche sur fond vert).
- La pièce peut-elle servir de local pouvant être mis à disposition des travailleuses pendant la grossesse ou l'allaitement ?



mensurá
Learn & Connect

367

Autres pictogrammes importantes



	Direction à suivre
	Poste premiers secours
	Téléphone d'urgence et les premiers secours
	Brancard
	Douche de sécurité
	Rincer les yeux

mensurá
Learn & Connect

368

Organisation

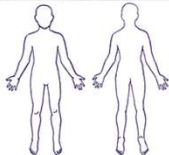
Tenez en compte les activités de l'entreprise, le résultat de l'analyse des risques, le nombre du personnel, et les risques présentes

- Existe-t-il un plan d'urgence interne ?
- Les matériels nécessaires sont présentes
- Y a-t-il un nombre suffisant de secouristes formés pour assurer les premiers secours pendant toute la période de travail de l'entreprise ?
- Les accidents sont-ils inventoriés et analysés (registre) ?
- Existe-t-il un document sur lequel les secouristes peuvent proposer du matériel ou une autre organisation au GT ?
- Existe-t-il une liste de numéros de téléphone utiles ?
- Y a-t-il une liste des employés formés aux premiers secours et leurs numéros de téléphone disponible et affichée ? Postulez-les et garder proche du Kit Premiers Secours
- Le matériel de premiers secours est-il périodiquement vérifié, renouvelé et complété ?
- Des statistiques concernant les accidents sont-elles tenues ?

mensurà
Learn & Connect

369

MyMensura: Registre incidents, interventions et les premiers secours

Registre des interventions de premiers secours - <année>				
N°	Date et heure de l'accident	Victime	Secouriste	☐ aucun soin dispensé
<N°>	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Endroit et description de la lésion : 				
		Lieu accident Circonstances Soins dispensés Date & heure soins Témoins		Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text.
N°	Date et heure de l'accident	Victime	Secouriste	☐ aucun soin dispensé

- Données de la victime (des victimes)
- Données de l'accident/de l'incident
- Détails des lésions
- Données des premiers secours
- Détails du/des témoin(s) potentiel(s)
- Détails du secouriste
- Données de l'enregistrement



Ce registre vous offre l'aperçu des interventions les plus courantes.
Utilisez-en pour votre analyse de risques.

mensurà
Learn & Connect

370



Est-ce qu'il y a des questions?



mensurá
Learn & Connect

371

“ Conclusion
Q&A

mensurá
Learn & Connect

372

Formation de base Secourisme - Évaluation



mensurá
Learn & Connect

373

Formation de recyclage Secourisme - Évaluation



mensurá
Learn & Connect

374

Formation Les gestes qui sauvent les nourrissons et les enfants- Évaluation



mensurà
Learn & Connect

375

Formation pour personnes désignées - Évaluation



mensurà
Learn & Connect

376